

Bunga Rampai **ASUHAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN**

Masa Perimenopause dan Menopause

Rosmawati • Muningar • An Nisa Fithri
Prassanti Widya Pravitasari • Nurbaety

Editor: Ika Nur Saputri



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN MASA PERIMENOPAUSE DAN MENOPAUSE

Penulis:

Bdn. Rosmawati, M.Keb.

Bdn. Muningsgar, SST., MKes.

Dr. An Nisa Fithri, AMd Keb., S.KM., M.KM

Prassanti Widya Pravitasari, S.Tr.Keb., M.Keb

Nurbaety, S.SiT., M.K.M

Editor:

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb

Bunga Rampai: Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Masa Perimenopause dan Menopause

Penulis:

Bdn. Rosmawati, M.Keb.

Bdn. Muningsar, SST., MKes.

Dr. An Nisa Fithri, AMd Keb., S.KM., M.KM

Prassanti Widya Pravitasari, S.Tr.Keb., M.Keb

Nurbaety, S.SiT., M.K.M

Editor: Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-39-8

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga bunga rampai berjudul "Asuhan Kebidanan pada Perempuan Masa Perimenopause dan Menopause" dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkaya referensi kebidanan, khususnya terkait pelayanan kesehatan perempuan pada fase perimenopause dan menopause.

Masa perimenopause dan menopause merupakan fase alamiah dalam kehidupan perempuan yang ditandai oleh berbagai perubahan hormonal, fisik, psikologis, serta sosial. Perubahan tersebut sering kali menimbulkan keluhan yang memengaruhi kualitas hidup, seperti gangguan siklus menstruasi, hot flushes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, penurunan kepadatan tulang, hingga perubahan dalam kehidupan seksual dan relasi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai masa klimakterium menjadi penting bagi bidan, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat agar perempuan dapat menjalani fase ini secara sehat, bermartabat, dan produktif.

Bunga rampai ini membahas berbagai topik penting, mulai dari konsep dasar perimenopause dan menopause, perubahan hormonal, fisik, dan psikologis pada masa klimakterium, hingga keluhan yang sering dialami perempuan pada masa menopause. Selain itu, buku ini juga menguraikan pentingnya edukasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan aktivitas fisik, serta dukungan keluarga dalam membantu perempuan beradaptasi menghadapi menopause. Seluruh pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kebutuhan perempuan pada fase transisi kehidupan ini.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa asuhan kebidanan pada perempuan masa perimenopause dan menopause tidak hanya berfokus pada penanganan keluhan, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, edukatif, dan suportif. Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan konseling, edukasi kesehatan, deteksi dini masalah kesehatan, serta pendampingan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan, menjadi sumber bacaan yang bermakna bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, serta mendukung peningkatan pelayanan kesehatan perempuan, khususnya pada masa perimenopause dan menopause.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PERIMENOPAUSE DAN MENOPAUSE 1

Bdn. Rosmawati, M.Keb.	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi dan Batasan Klinis Fase Klimakterium.....	2
C. Fisiologi Sistem Reproduksi pada Masa Transisi	5
D. Klasifikasi Tahapan Penuaan Reproduksi (STRAW + 10)	7
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Menopause.....	10
F. Epidemiologi dan Perspektif Kesehatan Masyarakat	12
G. Perspektif Pembanding: Konsep Andropause pada Laki-Laki.....	15
H. Kesimpulan	17
I. Referensi	18
J. Glosarium	19

CHAPTER 2 PERUBAHAN HORMONAL, FISIK, DAN PSIKOLOGIS PADA

MASA KLIMAKTERIUM 21

Muninggar, S.ST., M.Kes.	21
A. Pendahuluan	21
B. Klimakterium	22
C. Etiologi	23
D. Patofisiologi.....	24
E. Perubahan Fisik Pada Masa Klimakterium.....	24
F. Perubahan Hormon pada masa klimakterium.....	25
G. Perubahan Psikologis Pada masa Klimakterium	26
H. Simpulan.....	28
I. Referensi	28
J. Glosarium	30

CHAPTER 3 KELUHAN YANG SERING DIALAMI PEREMPUAN PADA

MASA MENOPAUSE..... 32

Dr. An Nisa Fithri, Amd,Keb., M.KM.	32
A. Pendahuluan	32
B. Perubahan dan gejala menopause	33
C. Keluhan yang Sering Dialami Perempuan pada Masa Menopause	34

D. Referensi	59
--------------------	----

CHAPTER 4 EDUKASI GAYA HIDUP SEHAT, NUTRISI DAN AKTIVITAS

FISIK..... 62

Prassanti Widya Pravitasari, S.Tr,Keb., M.Keb.....	62
A. Pendahuluan	62
B. Konsep Edukasi Gaya Hidup Sehat pada Masa Perimenopause dan Menopause.....	62
C. Konsep Edukasi Nutrisi pada Perempuan Perimenopause dan Menopause...	68
D. Konsep Edukasi Aktivitas Fisik	74
E. Konsep Edukasi Pengendalian Berat Badan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular.....	81
F. Peran Bidan dalam Edukasi Gaya Hidup Sehat	81
G. Kesimpulan	82
H. Referensi	82

CHAPTER 5 DUKUNGAN KELUARGA DALAM ADAPTASI PEREMPUAN

MENGHADAPI MENOPAUSE 85

Nurbaety, S.SiT., M.KM	85
A. Pendahuluan	85
B. Menopause sebagai Proses Adaptasi	86
C. Makna Dukungan Keluarga bagi Perempuan Menopause	87
D. Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga	89
E. Peran Suami dan Anak dalam Adaptasi Menopause	92
F. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga	95
G. Tantangan Lapangan	99
H. Strategi Penguatan Dukungan Keluarga	101
I. Simpulan.....	107
J. Referensi	108
K. Glosarium	109

PROFIL PENULIS..... 111

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PERIMENOPAUSE DAN MENOPAUSE

Bdn. Rosmawati, M.Keb.

A. Pendahuluan

Setiap perempuan akan mengalami sebuah transisi biologis fundamental yang menandai berakhirnya kapasitas reproduksi. Fase ini, yang dikenal luas sebagai menopause, sering kali menjadi subjek diskusi yang diselimuti oleh mitos dan kesalahpahaman. Pemahaman yang keliru dapat menimbulkan kecemasan dan menghalangi perempuan untuk mencari dukungan yang tepat. Padahal, menopause bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah tahap kehidupan yang alami. Mengelolanya dengan pengetahuan yang akurat adalah kunci untuk mempertahankan kualitas hidup yang optimal selama dan setelah transisi ini. Bab pertama ini berfungsi sebagai fondasi untuk seluruh pembahasan dalam buku ini.

Tujuannya adalah mendekonstruksi kompleksitas terminologi dan proses biologis yang terkait dengan penuaan reproduksi perempuan. Pembaca akan diajak untuk membedakan secara tegas antara berbagai istilah yang sering digunakan secara tumpang tindih, seperti klimakterium, perimenopause, dan menopause, berdasarkan kriteria klinis yang diterima secara internasional. Pengetahuan fundamental ini sangat krusial bagi bidan agar dapat memberikan diagnosis yang akurat, edukasi yang efektif, dan asuhan yang tepat sasaran. Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri definisi dan batasan setiap fase, diikuti dengan eksplorasi mendalam mengenai perubahan-perubahan fisiologis pada tingkat hormonal dan organ.

Bab ini juga akan memperkenalkan sistem klasifikasi standar STRAW + 10 yang menjadi acuan global dalam menentukan tahapan penuaan reproduksi. Selanjutnya, akan dianalisis berbagai faktor, mulai dari genetika hingga gaya hidup, yang dapat memodulasi waktu onset menopause. Sebagai penutup, bab ini akan menyajikan data epidemiologi untuk memberikan konteks kesehatan masyarakat dan memperkenalkan konsep andropause sebagai pembandingan, guna memperkaya pemahaman tentang penuaan reproduksi secara lebih luas.

Dengan menguasai konsep-konsep dasar yang diuraikan dalam bab ini, para bidan dan mahasiswa kebidanan akan memiliki kerangka kerja yang solid untuk memahami materi pada bab-bab berikutnya. Fondasi ini akan memungkinkan mereka untuk menginterpretasikan gejala klinis, merencanakan intervensi, dan pada

akhirnya memberdayakan perempuan untuk menghadapi fase menopause sebagai sebuah proses yang dapat dikelola dengan baik, bukan sebagai sebuah kondisi yang menakutkan.

B. Definisi dan Batasan Klinis Fase Klimakterium

Klimakterium merupakan sebuah payung terminologis yang mencakup periode transisi panjang dalam kehidupan seorang perempuan, dari masa reproduktif penuh menuju kondisi non-reproduktif. Periode ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses gradual yang ditandai oleh perubahan fungsi ovarium yang progresif. Pemahaman yang jernih terhadap setiap tahapan dalam spektrum klimakterium menjadi landasan esensial bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memberikan asuhan yang tepat waktu dan sesuai dengan fase yang sedang dialami oleh klien.

1. Pengertian Fase Klimakterium secara Umum

Fase klimakterium, sering juga disebut sebagai transisi menopause, secara definitif adalah periode waktu yang membentang dari beberapa tahun sebelum berhentinya menstruasi hingga satu tahun setelah periode menstruasi terakhir. Konsep ini melampaui sekadar berhentinya haid; ia mencakup seluruh spektrum perubahan biologis dan endokrinologis yang terjadi akibat penuaan ovarium. Secara esensial, klimakterium adalah jembatan antara masa subur dan masa senium seorang perempuan. Durasi dan manifestasi klimakterium sangat individual, dipengaruhi oleh genetika, status kesehatan, dan faktor-faktor gaya hidup.

Selama periode ini, fungsi ovarium untuk memproduksi sel telur dan hormon-hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron, mulai menurun secara tidak teratur, yang menyebabkan berbagai gejala fisik dan emosional. Ambikairajah, Walsh, dan Cherbuin (2022) menekankan pentingnya penggunaan terminologi yang konsisten untuk menghindari kebingungan baik di kalangan klinisi maupun pasien, di mana klimakterium berfungsi sebagai istilah inklusif yang menaungi perimenopause dan menopause.

2. Terminologi dan Definisi Perimenopause

Perimenopause secara harfiah berarti "sekitar menopause" dan merujuk pada periode transisi spesifik yang mendahului menopause. Tahap ini adalah bagian dari klimakterium dan ditandai oleh fluktuasi hormonal yang semakin nyata, yang menyebabkan irregularitas siklus menstruasi menjadi manifestasi klinis paling umum. Menurut The North American Menopause Society, perimenopause dapat dimulai sejak usia akhir 30-an atau awal 40-an dan bisa berlangsung selama beberapa bulan hingga lebih dari sepuluh tahun. Selama

perimenopause, ovarium tidak lagi melepaskan sel telur secara teratur, dan produksi estrogen menjadi tidak stabil, terkadang melonjak tinggi dan di lain waktu menurun drastis (Yang et al., 2024).

Fluktuasi inilah yang menjadi pemicu utama gejala-gejala khas seperti *hot flashes*, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan kekeringan vagina. Penting untuk dipahami bahwa selama masa perimenopause, seorang perempuan masih memiliki kemungkinan untuk hamil, meskipun kesuburannya telah menurun secara signifikan. Diagnosis perimenopause sering kali bersifat klinis, didasarkan pada laporan perubahan pola menstruasi dan gejala yang dialami oleh perempuan tersebut.

3. Kriteria Klinis Penegakan Diagnosa Menopause

Menopause didefinisikan secara retrospektif sebagai titik waktu setelah seorang perempuan tidak mengalami periode menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa adanya penyebab patologis atau fisiologis lain yang jelas. Kriteria 12 bulan amenorea ini menjadi standar emas diagnosis secara global. Penegakan diagnosis ini bersifat klinis dan umumnya tidak memerlukan tes laboratorium pada perempuan berusia di atas 45 tahun dengan gejala yang khas. Meskipun demikian, pada kasus-kasus tertentu, seperti pada perempuan yang lebih muda atau yang telah menjalani histerektomi (tanpa ooforektomi), pengukuran kadar *Follicle-Stimulating Hormone* (FSH) dapat membantu. Peningkatan kadar FSH serum secara konsisten di atas 30 mIU/mL, disertai dengan penurunan kadar estradiol, merupakan indikator kuat adanya kegagalan fungsi ovarium (Greene et al., 2025). Akan tetapi, karena kadar hormon sangat fluktuatif selama perimenopause, pengujian tunggal sering kali tidak dapat diandalkan untuk memprediksi atau mendiagnosis menopause secara definitif. Oleh karena itu, anamnesis riwayat menstruasi tetap menjadi pilar utama diagnosis.

4. Batasan Usia dan Rentang Waktu Transisi

Usia rata-rata terjadinya menopause alami secara global adalah sekitar 51 tahun, namun rentangnya cukup lebar, umumnya antara 45 hingga 55 tahun. Menopause yang terjadi sebelum usia 40 tahun diklasifikasikan sebagai *premature ovarian insufficiency* (POI), sementara yang terjadi antara usia 40 dan 45 tahun disebut sebagai menopause dini (*early menopause*). Faktor-faktor seperti genetika, etnis, dan gaya hidup memainkan peran signifikan dalam menentukan waktu terjadinya menopause pada seorang individu. Rentang waktu transisi perimenopause juga sangat bervariasi. Rata-rata, fase ini berlangsung sekitar empat hingga delapan tahun sebelum periode menstruasi terakhir (Davis et al., 2023). Beberapa perempuan mungkin hanya mengalami transisi singkat

selama beberapa bulan, sementara yang lain dapat mengalaminya lebih dari satu dekade. Variabilitas ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan individual dalam memberikan asuhan kebidanan, karena tidak ada dua perempuan yang akan mengalami perjalanan menopause yang identik.

5. Perbedaan Fase Premenopause, Perimenopause, dan Pascamenopause

Membedakan ketiga fase utama dalam kehidupan reproduksi perempuan sangatlah penting untuk penatalaksanaan yang tepat. Premenopause adalah periode sebelum munculnya tanda-tanda perimenopause, di mana siklus menstruasi masih teratur dan fungsi reproduksi berada pada puncaknya. Istilah ini merujuk pada keseluruhan masa subur seorang perempuan sebelum dimulainya transisi menopause. Perimenopause, seperti yang telah dibahas, adalah fase transisi yang ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dan munculnya gejala-gejala klimakterik akibat fluktuasi hormonal. Ini adalah periode "sekitar menopause". Pascamenopause dimulai setelah 12 bulan amenorea terkonfirmasi, menandakan bahwa seorang perempuan telah melewati menopause. Fase ini akan berlangsung seumur hidupnya. Selama pascamenopause, kadar estrogen akan stabil pada tingkat yang sangat rendah, dan gejala-gejala seperti *hot flashes* mungkin masih berlanjut untuk beberapa waktu, sementara risiko kesehatan jangka panjang seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular mulai meningkat.

Analogi/Contoh Kasus:

Memahami fase-fase klimakterium dapat diibaratkan seperti mengamati perubahan musim pada sebuah pohon buah. Premenopause adalah musim panas yang panjang, di mana pohon (sistem reproduksi) secara konsisten dan subur menghasilkan buah (ovulasi dan menstruasi teratur). Perimenopause adalah musim gugur; produksi buah menjadi tidak menentu, daun-daun (lapisan endometrium) mulai rontok dengan pola yang tidak terduga, dan pohon mulai menunjukkan tanda-tanda transisi. Menopause adalah hari pertama musim dingin, sebuah titik waktu spesifik yang menandai akhir dari siklus berbuah. Sementara pascamenopause adalah musim dingin itu sendiri, sebuah fase panjang di mana pohon tidak lagi berbuah tetapi tetap hidup dan memerlukan perawatan berbeda untuk menjaga kekuatan batang dan akarnya (kesehatan tulang dan kardiovaskular).

C. Fisiologi Sistem Reproduksi pada Masa Transisi

Perubahan yang terjadi selama transisi menopause berakar pada proses biologis yang kompleks dan terkonsentrasi, berpusat pada penuaan ovarium. Kegagalan fungsi ovarium secara bertahap ini memicu serangkaian peristiwa hormonal yang berdampak pada seluruh tubuh. Memahami mekanisme fisiologis ini memungkinkan bidan untuk menjelaskan dasar biologis dari gejala-gejala yang dialami perempuan dan memberikan edukasi yang rasional mengenai pilihan-pilihan penatalaksanaan.

1. Mekanisme Penurunan Cadangan Ovarium

Setiap perempuan dilahirkan dengan jumlah folikel ovarium primordial yang terbatas, sekitar satu hingga dua juta. Jumlah ini tidak dapat diregenerasi dan akan terus menurun sepanjang hidup melalui proses yang disebut atresia folikel (kematian sel terprogram). Proses atresia ini terjadi secara kontinu, bahkan sebelum pubertas, namun mengalami akselerasi signifikan setelah usia 35 tahun. Penipisan cadangan folikel ini adalah pemicu utama dari seluruh rangkaian peristiwa hormonal menopause. Ketika jumlah folikel yang responsif terhadap hormon perangsang dari otak berkurang, kemampuan ovarium untuk menghasilkan oosit (sel telur) yang matang dan hormon-hormon steroid seperti estrogen dan inhibin B menurun drastis. Penurunan inhibin B, hormon yang berfungsi memberikan umpan balik negatif ke kelenjar hipofisis, menjadi salah satu penanda paling awal dari penuaan ovarium (Kawakita et al., 2023). Akibatnya, mekanisme kontrol hormonal mulai terganggu, menandai dimulainya transisi perimenopause.

2. Perubahan Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Ovarium

Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Ovarium (HHO) adalah sistem komunikasi hormonal kompleks yang mengatur siklus menstruasi. Hipotalamus melepaskan *Gonadotropin-releasing Hormone* (GnRH), yang merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan *Follicle-Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH). FSH dan LH kemudian bekerja pada ovarium untuk merangsang pematangan folikel dan produksi estrogen serta progesteron. Hormon-hormon ovarium ini, pada gilirannya, memberikan umpan balik (positif atau negatif) ke hipotalamus dan hipofisis. Selama perimenopause, ketika ovarium menjadi kurang responsif akibat penurunan cadangan folikel, umpan balik negatif dari estrogen dan inhibin B ke hipofisis melemah.

Akibatnya, hipofisis mencoba mengompensasi dengan meningkatkan produksi FSH dalam upaya untuk merangsang ovarium lebih kuat. Inilah sebabnya mengapa peningkatan kadar FSH menjadi penanda biokimia utama

dari transisi menopause (Greene et al., 2025). Ketidakseimbangan dalam aksis HHO ini menyebabkan siklus anovulasi (siklus tanpa ovulasi) dan fluktuasi hormonal yang tidak terduga.

3. Fluktuasi Hormon Estrogen dan Progesteron

Salah satu miskonsepsi umum adalah bahwa kadar estrogen menurun secara linear selama perimenopause. Kenyataannya, periode ini ditandai oleh fluktuasi estrogen yang liar dan tidak dapat diprediksi. Pada fase transisi awal, karena kadar FSH yang tinggi, beberapa folikel yang tersisa dapat terstimulasi secara berlebihan, menyebabkan lonjakan kadar estradiol (bentuk estrogen paling poten) yang bisa jauh lebih tinggi daripada kadar normal pada perempuan muda (Yang et al., 2024).

Episode hiperestrogenisme ini sering kali diikuti oleh periode hipoestrogenisme yang tajam ketika ovulasi gagal terjadi. Sementara itu, produksi progesteron, yang bergantung pada terbentuknya korpus luteum setelah ovulasi, menjadi semakin jarang karena meningkatnya jumlah siklus anovulasi. Ketidakseimbangan rasio estrogen terhadap progesteron ini, khususnya defisiensi progesteron relatif, berkontribusi pada gejala seperti perdarahan uterus abnormal dan nyeri payudara. Seiring berjalannya waktu, mendekati menopause, episode hipoestrogenisme menjadi dominan hingga akhirnya stabil pada level yang sangat rendah di masa pascamenopause.

4. Peran Hormon Gonadotropin (FSH dan LH)

Seperti telah dijelaskan, FSH adalah hormon yang paling sensitif terhadap penuaan ovarium. Peningkatannya yang progresif adalah upaya kompensasi dari sistem saraf pusat terhadap kegagalan ovarium. Kadar FSH yang terus-menerus tinggi (>30 mIU/mL) adalah indikator bahwa ovarium tidak lagi merespons stimulasi secara adekuat. Peningkatan kadar LH juga terjadi, meskipun biasanya lebih lambat dan kurang dramatis dibandingkan FSH. Kawakita et al. (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa rasio LH terhadap FSH dapat memberikan informasi tambahan mengenai tahapan transisi menopause. Selama masa reproduksi, rasio ini biasanya mendekati 1, namun seiring penuaan ovarium, rasio ini cenderung menurun karena peningkatan FSH yang lebih dominan. Peran utama gonadotropin pada masa ini bergeser dari regulator siklus menjadi penanda biokimia dari proses penuaan reproduksi.

5. Dampak Penurunan Fungsi Ovarium terhadap Organ Reproduksi

Penurunan drastis kadar estrogen setelah menopause memiliki dampak signifikan pada organ-organ yang sensitif terhadap estrogen. Uterus akan mengalami atrofi, ukurannya menyusut, dan lapisan endometrium menjadi tipis dan tidak aktif. Serviks juga mengecil dan dapat menarik ke dalam kubah vagina,

dengan produksi mukus serviks yang berkurang drastis. Vagina dan vulva mengalami perubahan yang paling nyata, suatu kondisi yang sekarang lebih dikenal sebagai *Genitourinary Syndrome of Menopause* (GSM). Dinding vagina menjadi lebih tipis, pucat, kurang elastis, dan kering karena penurunan aliran darah dan produksi pelumas alami. Perubahan ini dapat menyebabkan gejala seperti kekeringan, gatal, iritasi, dan dispareunia (nyeri saat berhubungan seksual) (Johnston et al., 2021). Perubahan serupa terjadi pada uretra dan kandung kemih, yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, urgensi, dan inkontinensia.

Analogi/Contoh Kasus:

Aksis HHO pada masa transisi dapat diibaratkan sebagai sebuah termostat di dalam rumah. Pada masa reproduktif (premenopause), termostat (hipotalamus-hipofisis) diatur pada suhu yang nyaman. Ketika pendingin ruangan (ovarium) bekerja dengan baik dan menghasilkan udara dingin (estrogen), termostat akan mendeteksinya dan mengurangi aktivitasnya (umpan balik negatif). Selama perimenopause, pendingin ruangan mulai rusak dan tidak konsisten. Kadang ia mengeluarkan udara yang sangat dingin (lonjakan estrogen), kadang mati total (penurunan estrogen). Termostat, yang merasakan kekurangan udara dingin, akan bekerja panik dan terus-menerus mengirimkan sinyal "ON" dengan kekuatan penuh (peningkatan FSH) dalam upaya sia-sia untuk menyalakan kembali pendingin yang sudah aus.

D. Klasifikasi Tahapan Penuaan Reproduksi (STRAW + 10)

Untuk menyeragamkan definisi dan memfasilitasi penelitian serta praktik klinis mengenai penuaan reproduksi, sebuah sistem klasifikasi yang komprehensif telah dikembangkan. Sistem *Stages of Reproductive Aging Workshop* (STRAW), yang kemudian diperbarui menjadi STRAW+10, telah menjadi standar global. Klasifikasi ini menyediakan kerangka kerja yang jelas berdasarkan pola perdarahan menstruasi dan penanda endokrin untuk menentukan di mana posisi seorang perempuan dalam kontinum penuaan reproduksi.

1. Pengenalan Sistem Klasifikasi STRAW (Stages of Reproductive Aging Workshop)

Sistem STRAW pertama kali dikembangkan pada tahun 2001 dan direvisi pada tahun 2011 (menjadi STRAW+10) untuk memasukkan data dan pemahaman baru. Sistem ini membagi kehidupan reproduksi perempuan menjadi 10 tahap, mulai dari prapubertas hingga pascamenopause lanjut. Tahap-tahap ini dikelompokkan ke dalam tiga fase besar: Reproduksi, Transisi Menopause, dan Pascamenopause. Kriteria utama yang digunakan adalah

perubahan siklus menstruasi, didukung oleh perubahan kadar FSH, *Anti-Müllerian Hormone* (AMH), dan *Antral Follicle Count* (AFC). STRAW+10 memberikan bahasa yang sama bagi klinisi dan peneliti di seluruh dunia untuk mendiskusikan penuaan ovarium. Sistem ini membantu dalam memprediksi perjalanan transisi, memberikan konseling kepada pasien mengenai apa yang diharapkan, dan menentukan waktu yang tepat untuk intervensi atau kontrasepsi. Bagi bidan, memahami STRAW+10 memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap status reproduksi klien.

2. Karakteristik Fase Transisi Menopause Awal (-2)

Tahap -2, atau Transisi Menopause Awal, adalah titik di mana siklus menstruasi seorang perempuan yang sebelumnya teratur mulai menunjukkan variabilitas dalam durasi siklus. Karakteristik utamanya adalah adanya perbedaan persistensi selama 7 hari atau lebih antara siklus-siklus yang berurutan. Misalnya, seorang perempuan mungkin mengalami siklus 25 hari, diikuti oleh siklus 33 hari, dan kemudian siklus 26 hari. Pada tahap ini, ovulasi masih sering terjadi, meskipun tidak selalu. Secara endokrin, kadar FSH mulai menunjukkan variabilitas dan kecenderungan untuk meningkat, meskipun masih bisa berada dalam rentang normal. Kadar AMH dan AFC, yang merupakan penanda cadangan ovarium yang lebih sensitif, sudah mulai menurun secara signifikan (Rees et al., 2022). Gejala-gejala vasomotor seperti *hot flashes* mungkin mulai muncul pada beberapa perempuan, meskipun seringkali masih ringan dan sporadis.

3. Karakteristik Fase Transisi Menopause Akhir (-1)

Tahap -1, atau Transisi Menopause Akhir, ditandai dengan gangguan siklus menstruasi yang lebih parah. Karakteristik utamanya adalah terjadinya periode amenorea selama 60 hari atau lebih. Pada tahap ini, siklus menjadi sangat tidak dapat diprediksi, dengan episode perdarahan yang sering kali diselingi oleh periode tanpa menstruasi yang panjang. Siklus anovulasi menjadi semakin umum. Secara hormonal, tahap ini ditandai dengan kadar FSH yang meningkat secara signifikan (biasanya >25 mIU/L) dan fluktuasi estradiol yang ekstrem. Gejala-gejala klimakterik, terutama gejala vasomotor, seringkali menjadi paling intens dan mengganggu selama tahap ini (Davis et al., 2023). Transisi Menopause Akhir biasanya berlangsung selama satu hingga tiga tahun dan berakhir dengan periode menstruasi terakhir (*Final Menstrual Period* - FMP).

4. Identifikasi Fase Pascamenopause Dini (+1)

Tahap Pascamenopause Dini dibagi lagi menjadi tiga sub-tahap: +1a, +1b, dan +1c. Tahap +1a adalah 12 bulan pertama setelah FMP, yang digunakan untuk mengkonfirmasi menopause secara retrospektif. Tahap +1b mencakup tahun kedua setelah FMP. Secara keseluruhan, Tahap +1 (dini) berlangsung selama dua

tahun setelah FMP. Selama periode ini, kadar FSH terus meningkat dan mencapai puncaknya, sementara kadar estradiol menurun dan stabil pada level yang sangat rendah. Gejala vasomotor seringkali masih berlanjut dan bisa tetap parah pada banyak perempuan. Perubahan fisiologis yang berkaitan dengan defisiensi estrogen, seperti percepatan kehilangan massa tulang, mulai menjadi signifikan secara klinis pada tahap ini (Lambrinoudaki et al., 2022).

5. Identifikasi Fase Pascamenopause Lanjut (+2)

Tahap +2, atau Pascamenopause Lanjut, dimulai setelah fase pascamenopause dini selesai dan berlanjut sepanjang sisa hidup perempuan tersebut. Pada tahap ini, sistem reproduksi menjadi stabil dalam keadaan hipoestrogenik. Kadar FSH dan LH tetap tinggi, meskipun mungkin sedikit menurun dari puncaknya. Gejala-gejala vasomotor cenderung berkurang dalam frekuensi dan intensitas bagi sebagian besar perempuan, meskipun beberapa mungkin terus mengalaminya selama bertahun-tahun. Fokus klinis pada tahap ini bergeser ke masalah-masalah kesehatan jangka panjang yang terkait dengan penuaan dan defisiensi estrogen kronis, terutama osteoporosis, penyakit kardiovaskular, perubahan kognitif, dan *Genitourinary Syndrome of Menopause* (GSM) (Johnston et al., 2021).

Analogi/Contoh Kasus:

Sistem STRAW+10 dapat dianalogikan dengan perjalanan kereta api jarak jauh. Fase Reproduksi adalah saat kereta berjalan mulus di jalur utama dengan jadwal kedatangan di stasiun (menstruasi) yang tepat waktu. Tahap -2 (Transisi Awal) adalah ketika kereta mulai mengalami keterlambatan-keterlambatan kecil; jadwalnya menjadi kurang bisa diandalkan, kadang lebih cepat 7 menit, kadang terlambat 7 menit. Tahap -1 (Transisi Akhir) adalah saat kereta mengalami gangguan sinyal yang parah, menyebabkan ia berhenti di tengah jalur untuk waktu yang lama (amenorea >60 hari) sebelum melanjutkan perjalanan yang tersendat-sendat. Menopause (FMP) adalah stasiun tujuan akhir. Tahap +1 (Pascamenopause Dini) adalah dua kilometer pertama setelah stasiun akhir, di mana kereta masih melambat dan sistemnya menyesuaikan diri. Tahap +2 (Pascamenopause Lanjut) adalah saat kereta sudah berhenti total di depo untuk selamanya, dan fokus beralih ke pemeliharaan jangka panjang mesin dan gerbongnya.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Menopause

Waktu terjadinya menopause alami merupakan hasil interaksi kompleks antara predisposisi genetik dan berbagai faktor eksternal sepanjang hidup seorang perempuan. Meskipun ada usia rata-rata global, variasi individual yang signifikan menunjukkan bahwa banyak elemen yang dapat mempercepat atau sedikit menunda proses penuaan ovarium. Memahami faktor-faktor ini membantu bidan dalam memberikan konseling antisipatif dan mengidentifikasi perempuan yang mungkin berisiko mengalami menopause dini.

1. Pengaruh Faktor Genetik dan Keturunan

Faktor genetik dianggap sebagai penentu paling kuat dari usia saat menopause. Studi menunjukkan bahwa hingga 50-75% variasi usia menopause dapat dijelaskan oleh faktor keturunan. Seorang perempuan cenderung akan mengalami menopause pada usia yang tidak jauh berbeda dengan ibu dan saudara perempuannya. Penelitian genomik telah mengidentifikasi beberapa gen yang terlibat dalam perbaikan DNA dan fungsi ovarium yang berkorelasi dengan waktu menopause. Riwayat keluarga yang memiliki menopause dini atau *premature ovarian insufficiency* (POI) merupakan faktor risiko penting yang harus digali dalam anamnesis. Predisposisi genetik ini pada dasarnya menentukan ukuran cadangan folikel awal saat lahir dan laju atresia folikel sepanjang hidup. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan keluarga dan konseling kesehatan jangka panjang.

2. Dampak Status Gizi dan Indeks Massa Tubuh (IMT)

Status gizi dan komposisi tubuh juga memainkan peran dalam modulasi usia menopause. Perempuan dengan IMT yang lebih tinggi seringkali mengalami menopause sedikit lebih lambat. Jaringan adiposa (lemak) adalah sumber produksi estrogen sekunder melalui konversi androgen menjadi estrogen. Cadangan lemak yang lebih besar dapat menyediakan sumber estrogen ekstrasadal yang membantu mempertahankan siklus menstruasi lebih lama. Sebaliknya, malnutrisi, berat badan kurang, dan diet vegetarian yang sangat ketat telah dikaitkan dengan onset menopause yang lebih awal (Lestari et al., 2025). Asupan nutrisi yang tidak memadai dapat mengganggu fungsi aksis HHO dan mempercepat penipisan cadangan ovarium. Oleh karena itu, mempertahankan IMT yang sehat dan gizi seimbang sepanjang hidup dapat berkontribusi pada transisi menopause yang lebih tepat waktu.

3. Pengaruh Gaya Hidup, Merokok, dan Paparan Polusi

Merokok adalah faktor gaya hidup yang paling konsisten dan signifikan terbukti mempercepat menopause. Perempuan perokok rata-rata mengalami menopause satu hingga dua tahun lebih awal dibandingkan non-perokok. Zat-zat kimia dalam asap rokok, seperti nikotin dan hidrokarbon aromatik polisiklik, bersifat toksik terhadap ovarium (gonadotoksik), mempercepat kematian folikel, dan mengganggu metabolisme estrogen (Marlia, 2021). Paparan terhadap polutan lingkungan lainnya, seperti pestisida dan bahan kimia industri tertentu yang bertindak sebagai pengganggu endokrin, juga diduga dapat memengaruhi fungsi ovarium. Meskipun penelitian di bidang ini masih berkembang, bukti awal menunjukkan bahwa paparan kronis terhadap toksin lingkungan dapat berkontribusi pada penuaan reproduksi yang lebih cepat. Aktivitas fisik yang moderat umumnya tidak berpengaruh signifikan, namun aktivitas fisik yang sangat ekstrem dan berlebihan dapat menyebabkan amenorea dan mempercepat menopause.

4. Riwayat Reproduksi: Paritas dan Usia Menarche

Riwayat reproduksi seorang perempuan juga dapat memengaruhi usia menopausenya. Perempuan yang tidak pernah melahirkan (nulipara) cenderung mengalami menopause sedikit lebih awal dibandingkan perempuan yang pernah melahirkan (paritas). Teori yang mendasarinya adalah bahwa kehamilan dan laktasi menekan ovulasi untuk sementara waktu, sehingga "menghemat" cadangan folikel. Setiap kehamilan dapat sedikit menunda usia menopause. Usia menarche (menstruasi pertama) memiliki hubungan yang lebih kompleks dan kurang konsisten. Beberapa studi menunjukkan bahwa menarche yang sangat dini (sebelum usia 11 tahun) mungkin terkait dengan menopause yang lebih awal, sementara studi lain tidak menemukan korelasi yang jelas. Hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosioekonomi dan gizi selama masa kanak-kanak.

5. Pengaruh Kondisi Medis, Operasi Ovarium, dan Kemoterapi

Berbagai intervensi dan kondisi medis dapat menyebabkan menopause iatrogenik (akibat tindakan medis) atau mempercepat menopause alami. Ooforektomi bilateral (pengangkatan kedua ovarium) secara langsung menyebabkan menopause bedah (*surgical menopause*) yang tiba-tiba, terlepas dari usia pasien. Histerektomi (pengangkatan rahim) tanpa ooforektomi juga dapat mempercepat menopause alami sekitar satu hingga dua tahun, kemungkinan karena gangguan suplai darah ke ovarium. Kemoterapi dan radiasi panggul untuk pengobatan kanker bersifat sangat gonadotoksik dan dapat menyebabkan kerusakan ovarium permanen, yang mengarah pada *premature*

ovarian insufficiency. Tingkat kerusakan bergantung pada jenis obat, dosis, dan usia pasien saat pengobatan. Kondisi autoimun tertentu, seperti penyakit tiroid dan lupus eritematosus sistemik, juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko menopause dini.

Analogi/Contoh Kasus:

Cadangan folikel ovarium dapat diibaratkan seperti baterai pada sebuah perangkat elektronik. Faktor genetik menentukan kapasitas awal baterai tersebut saat pertama kali diproduksi. Status gizi dan IMT mirip dengan penggunaan mode hemat daya; perangkat dengan manajemen daya yang baik (gizi seimbang) akan bertahan lebih lama. Merokok dan paparan toksin seperti menjalankan aplikasi-aplikasi berat yang menguras daya dengan cepat, memperpendek umur baterai secara signifikan. Paritas (kehamilan) bisa diibaratkan seperti menempatkan perangkat dalam mode tidur (*sleep mode*) untuk sementara, yang sedikit menghemat daya. Kemoterapi atau operasi ovarium adalah kerusakan fisik langsung pada baterai, yang menyebabkan dayanya habis seketika atau kapasitasnya berkurang drastis.

F. Epidemiologi dan Perspektif Kesehatan Masyarakat

Menopause bukan hanya pengalaman individu, tetapi juga fenomena demografis dengan implikasi kesehatan masyarakat yang luas. Seiring dengan peningkatan angka harapan hidup secara global, jumlah perempuan yang hidup dalam fase pascamenopause terus meningkat. Data epidemiologi membantu pemangku kebijakan dan penyedia layanan kesehatan, termasuk bidan, untuk memahami skala tantangan, merencanakan layanan, dan mengembangkan program promosi kesehatan yang efektif.

1. Prevalensi Menopause di Indonesia dan Global

Secara global, diperkirakan lebih dari satu miliar perempuan akan berada dalam fase pascamenopause pada tahun 2025. Usia rata-rata menopause alami di seluruh dunia adalah sekitar 51 tahun, dengan sedikit variasi antar etnis dan wilayah geografis. Di negara-negara Barat, usia rata-rata cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan di negara-negara Asia dan Afrika. Di Indonesia, data mengenai menopause masih bervariasi. Beberapa penelitian lokal menunjukkan usia rata-rata menopause berada di rentang 48 hingga 51 tahun. Sebuah studi oleh Diyu & Satriani (2022) yang mengamati perempuan berusia 40-65 tahun di Indonesia menyoroti tingginya prevalensi gejala-gejala menopause, seperti gangguan tidur, nyeri sendi, dan keluhan psikologis. Data ini menegaskan bahwa menopause adalah isu kesehatan yang signifikan bagi jutaan perempuan di

Indonesia, yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem pelayanan kesehatan primer.

2. Tren Pergeseran Usia Menopause di Era Modern

Terdapat perdebatan dalam literatur ilmiah mengenai apakah usia menopause telah bergeser seiring waktu. Beberapa data historis menunjukkan adanya sedikit peningkatan usia menopause selama abad ke-20, yang mungkin disebabkan oleh perbaikan gizi, status kesehatan umum, dan penurunan prevalensi merokok di beberapa populasi. Peningkatan ini, jika ada, cenderung sangat kecil, hanya beberapa bulan hingga satu tahun selama beberapa dekade. Faktor-faktor modern seperti peningkatan obesitas dan perubahan gaya hidup lainnya dapat memiliki efek yang saling bertentangan, sehingga sulit untuk menentukan tren yang jelas. Namun, yang lebih pasti adalah peningkatan absolut dalam jumlah perempuan yang mengalami menopause karena pertumbuhan populasi dan peningkatan harapan hidup, yang menjadikan manajemen kesehatan pascamenopause sebagai prioritas kesehatan masyarakat yang semakin mendesak.

3. Angka Harapan Hidup Perempuan Pascamenopause

Salah satu perubahan demografis paling signifikan di era modern adalah peningkatan dramatis dalam angka harapan hidup. Saat ini, di banyak negara termasuk Indonesia, perempuan dapat berharap untuk hidup hingga usia 70-an atau 80-an. Dengan usia menopause rata-rata sekitar 50 tahun, ini berarti perempuan akan menghabiskan sekitar sepertiga dari seluruh hidup mereka dalam keadaan pascamenopause. Implikasinya sangat besar. Fase pascamenopause bukan lagi periode singkat di akhir kehidupan, melainkan sebuah tahap kehidupan yang panjang dan signifikan. Hal ini menggeser fokus dari sekadar mengelola gejala transisi menjadi strategi jangka panjang untuk pencegahan penyakit kronis yang risikonya meningkat setelah menopause, seperti penyakit jantung, osteoporosis, diabetes tipe 2, dan demensia. Hickey et al. (2024) mengusulkan model pemberdayaan untuk manajemen menopause yang berfokus pada kesehatan jangka panjang, bukan hanya gejala jangka pendek.

4. Tantangan Pelayanan Kesehatan bagi Lansia Perempuan

Peningkatan populasi perempuan lansia menimbulkan tantangan unik bagi sistem pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan seringkali masih terfragmentasi, dengan perempuan harus mengunjungi berbagai spesialis untuk masalah-masalah terkait menopause (misalnya, ginekolog untuk GSM, kardiolog untuk kesehatan jantung, ortopedi untuk osteoporosis). Diperlukan model perawatan yang lebih terintegrasi dan holistik. Tantangan lainnya adalah kurangnya

pengetahuan dan kesadaran tentang menopause, baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga kesehatan (Harper et al., 2022). Banyak perempuan tidak mendapatkan informasi yang akurat dan dukungan yang memadai, sehingga mereka menderita dalam diam atau beralih ke pengobatan yang tidak terbukti efektivitasnya. Selain itu, akses terhadap perawatan, terutama terapi hormon menopause (THM) yang efektif, seringkali terbatas karena biaya, ketersediaan, atau kekhawatiran yang tidak berdasar mengenai risikonya (Barber & Charles, 2023).

5. Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Masa Menopause

Bidan berada di posisi yang unik dan strategis untuk memainkan peran kunci dalam promosi kesehatan masa menopause. Sebagai penyedia layanan kesehatan primer bagi perempuan sepanjang siklus kehidupan, bidan sering kali menjadi titik kontak pertama dan paling tepercaya. Peran bidan melampaui sekadar manajemen kehamilan dan persalinan; mereka dapat dan harus terlibat aktif dalam kesehatan perempuan di usia paruh baya dan seterusnya. Peran ini mencakup beberapa area utama: memberikan edukasi yang akurat dan berbasis bukti untuk menghilangkan mitos; melakukan skrining gejala dan faktor risiko penyakit kronis; memberikan konseling mengenai gaya hidup sehat (nutrisi, olahraga, berhenti merokok); mendiskusikan pilihan manajemen gejala, termasuk terapi non-hormonal dan hormonal; serta memberikan dukungan psikososial (Lycke et al., 2025). Dengan memberdayakan bidan melalui pelatihan dan pedoman yang jelas, sistem kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup jutaan perempuan yang menjalani transisi menopause.

Analogi/Contoh Kasus:

Populasi perempuan pascamenopause dapat diibaratkan sebagai armada mobil klasik yang jumlahnya terus bertambah. Pada abad sebelumnya, mobil-mobil ini (perempuan) hanya diharapkan bertahan beberapa tahun setelah berhenti dari "balapan" (masa reproduksi). Kini, berkat "perawatan" yang lebih baik (peningkatan harapan hidup), armada ini diharapkan tetap berfungsi baik di jalan raya selama 20-30 tahun lagi. Tantangan pelayanan kesehatan adalah bagaimana mengubah bengkel-bengkel yang terbiasa menangani mobil balap (layanan obstetri) menjadi pusat servis komprehensif untuk mobil klasik, yang memerlukan jenis pemeliharaan berbeda untuk mesin (jantung), sasis (tulang), dan interior (kesejahteraan psikologis). Peran bidan adalah seperti mekanik tepercaya yang telah mengenal mobil tersebut sejak awal, yang kini dilatih kembali untuk menjadi spesialis restorasi dan pemeliharaan jangka panjang.

G. Perspektif Pemandangan: Konsep Andropause pada Laki-Laki

Untuk melengkapi pemahaman tentang penuaan reproduksi, penting untuk melihat proses serupa yang terjadi pada laki-laki. Meskipun sering disebut sebagai "andropause" atau "menopause pria", proses ini secara fundamental berbeda dari menopause pada perempuan. Memahami perbedaan dan persamaan ini dapat membantu bidan dalam memberikan konseling holistik kepada perempuan dan pasangannya, serta mempromosikan pendekatan bersama dalam menghadapi perubahan-perubahan di usia paruh baya.

1. Definisi Andropause (Late-Onset Hypogonadism)

Istilah "andropause" sebenarnya kurang disukai dalam komunitas medis karena menyiratkan proses yang setara dengan menopause, padahal tidak demikian. Istilah yang lebih akurat secara klinis adalah *Late-Onset Hypogonadism* (LOH) atau sindrom defisiensi testosteron. LOH didefinisikan sebagai sindrom klinis dan biokimia yang terkait dengan penuaan pada laki-laki, ditandai oleh gejala-gejala khas dan penurunan kadar testosteron serum. Tidak seperti menopause yang dialami oleh semua perempuan, LOH tidak terjadi pada semua laki-laki. Prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia, namun banyak laki-laki lansia tetap memiliki kadar testosteron dalam rentang normal untuk usia muda. Diagnosis LOH memerlukan adanya gejala klinis yang konsisten ditambah dengan bukti biokimia berupa kadar testosteron yang rendah.

2. Perubahan Hormonal dan Penurunan Testosteron secara Gradual

Perbedaan paling mendasar antara menopause dan LOH terletak pada laju dan tingkat perubahan hormonal. Menopause ditandai oleh penghentian fungsi ovarium yang relatif cepat dan dramatis, menyebabkan penurunan estrogen yang tajam dalam beberapa tahun. Sebaliknya, penurunan testosteron pada laki-laki adalah proses yang sangat lambat dan gradual. Dimulai sekitar usia 30-40 tahun, kadar testosteron total pada laki-laki menurun rata-rata sekitar 1% per tahun. Penurunan ini bersifat linear dan tidak mengalami akselerasi yang tajam. Akibatnya, banyak laki-laki tidak merasakan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, tidak seperti perempuan yang kehabisan folikel, testis pada laki-laki tidak pernah sepenuhnya berhenti memproduksi testosteron dan sperma, sehingga fungsi reproduksi dapat dipertahankan hingga usia lanjut.

3. Manifestasi Klinis dan Gejala Fisik Andropause

Gejala-gejala LOH seringkali tumpang tindih dengan gejala penuaan secara umum, yang membuatnya sulit didiagnosis. Gejala yang paling spesifik terkait dengan defisiensi testosteron meliputi penurunan hasrat seksual (libido), disfungsi ereksi, dan berkurangnya frekuensi ereksi spontan di pagi hari. Gejala-

gejala lain yang kurang spesifik termasuk kelelahan dan kekurangan energi, penurunan massa dan kekuatan otot, peningkatan lemak tubuh (terutama di sekitar perut), penurunan kepadatan mineral tulang (osteoporosis), perubahan suasana hati (depresi atau mudah tersinggung), dan kesulitan berkonsentrasi. Karena gejala-gejala ini tidak spesifik, penting untuk menyingkirkan penyebab lain seperti penyakit kronis, depresi, atau efek samping obat sebelum mengatribusikannya pada LOH.

4. Perbedaan Mendasar antara Menopause dan Andropause

Perbedaan utama dapat diringkas dalam beberapa poin. Universalitas: Menopause adalah peristiwa universal yang pasti dialami oleh semua perempuan yang hidup cukup lama, sedangkan andropause (LOH) hanya mempengaruhi sebagian populasi laki-laki. Kecepatan: Menopause adalah transisi yang relatif cepat (beberapa tahun), sementara LOH adalah penurunan yang sangat lambat (beberapa dekade). Dampak Hormonal: Menopause menyebabkan penurunan estrogen yang drastis hingga level yang sangat rendah, sementara LOH menyebabkan penurunan testosteron yang moderat. Dampak Fertilitas: Menopause menandai akhir absolut dari kesuburan, sedangkan laki-laki dengan LOH mungkin masih bisa subur. Pemahaman akan perbedaan ini sangat penting. Menyamakan andropause dengan menopause dapat meremehkan dampak signifikan yang dialami perempuan dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis bagi laki-laki.

5. Pentingnya Dukungan Pasangan dalam Menghadapi Masa Klimakterium Bersama

Meskipun prosesnya berbeda, baik perempuan maupun laki-laki menghadapi perubahan fisik, emosional, dan seksual di usia paruh baya. Masa transisi menopause pada perempuan seringkali bertepatan dengan perubahan terkait LOH atau penuaan pada pasangan laki-lakinya. Hal ini dapat menciptakan tantangan baru dalam hubungan, terutama dalam hal keintiman dan komunikasi. Bidan dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi pasangan secara bersama-sama. Mendorong komunikasi terbuka tentang gejala yang dialami masing-masing, perubahan hasrat seksual, dan kebutuhan emosional dapat membantu pasangan menavigasi periode ini sebagai sebuah tim. Memahami bahwa kedua belah pihak sedang mengalami perubahan, meskipun berbeda sifatnya, dapat menumbuhkan empati dan dukungan timbal balik, memperkuat hubungan, dan meningkatkan kualitas hidup keduanya selama dan setelah masa klimakterium.

Analogi/Contoh Kasus:

Jika menopause diibaratkan seperti air terjun yang deras, sebuah perubahan ketinggian air (hormon) yang drastis dan tak terhindarkan dalam bentang alam sebuah sungai (kehidupan perempuan), maka andropause (LOH) lebih mirip dengan proses erosi yang sangat lambat pada tepi sungai yang lain (kehidupan laki-laki). Erosi ini secara bertahap mengubah bentuk tepi sungai selama puluhan tahun, dan dampaknya mungkin tidak terlalu terlihat dari hari ke hari. Beberapa bagian tepi sungai mungkin terkikis lebih cepat, sementara yang lain tetap kokoh. Air terjun adalah peristiwa yang jelas dan transformatif, sementara erosi adalah proses yang halus dan tidak universal. Keduanya mengubah lanskap sungai, tetapi dengan cara dan skala waktu yang sangat berbeda.

H. Kesimpulan

Bab ini telah membangun fondasi yang kokoh untuk memahami kompleksitas transisi menopause. Dimulai dari penjernihan terminologi, di mana klimakterium diidentifikasi sebagai periode transisi yang luas, sementara perimenopause dan menopause merupakan tahapan spesifik di dalamnya dengan kriteria klinis yang jelas. Pemahaman yang akurat terhadap definisi ini adalah langkah pertama yang krusial bagi bidan dalam melakukan asesmen dan memberikan edukasi yang tepat kepada klien. Eksplorasi mendalam pada aspek fisiologis mengungkapkan bahwa penuaan reproduksi berpusat pada penipisan cadangan ovarium. Proses ini memicu serangkaian perubahan pada aksis Hipotalamus-Hipofisis-Ovarium, yang dimanifestasikan melalui fluktuasi hormonal yang tidak menentu dan pada akhirnya berujung pada kondisi hipoestrogenik permanen. Sistem klasifikasi STRAW+10 menyediakan kerangka kerja standar untuk memetakan perjalanan ini, memungkinkan praktisi untuk mengidentifikasi setiap tahap transisi secara objektif.

Selanjutnya, bab ini menegaskan bahwa waktu menopause merupakan hasil dari interaksi multifaktorial antara genetika yang dominan dengan pengaruh gaya hidup, status gizi, dan riwayat medis. Dari perspektif kesehatan masyarakat, peningkatan angka harapan hidup menjadikan manajemen kesehatan pascamenopause sebagai isu yang sangat relevan, di mana bidan memiliki peran strategis. Perbandingan dengan konsep andropause pada laki-laki semakin memperkaya pemahaman dengan menyoroti perbedaan fundamental antara kedua proses penuaan reproduksi, sekaligus menekankan pentingnya dukungan pasangan. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, pembaca kini siap untuk melangkah ke bab-bab berikutnya yang akan membahas manifestasi klinis dan strategi penatalaksanaan secara lebih rinci.

I. Referensi

- Ambikairajah, A., Walsh, E., & Cherbuin, N. (2022). A review of menopause nomenclature. *Reproductive Health*, 19(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01336-7>
- Barber, K., & Charles, A. (2023). Barriers to Accessing Effective Treatment and Support for Menopausal Symptoms: A Qualitative Study Capturing the Behaviours, Beliefs and Experiences of Key Stakeholders. *Patient Preference and Adherence*, 17, 2971–2980. <https://doi.org/10.2147/ppa.s430203>
- Davis, S. R., Taylor, S., Hemachandra, C., Magraith, K., Ebeling, P. R., Jané, F., & Islam, R. M. (2023). The 2023 Practitioner's Toolkit for Managing Menopause. *Climacteric*, 26(6), 517–536. <https://doi.org/10.1080/13697137.2023.2258783>
- Diyu, I. G. P. S., & Satriani, N. L. P. E. (2022). Menopausal symptoms in women aged 40-65 years in Indonesia. *International Journal of Health & Medical Sciences*, 5(2), 173-178. <https://doi.org/10.21744/ijhms.v5n2.1896>
- Greene, D. N., Ahmed, S., Daccarett, S., Kling, J. M., Lorey, T. S., Rytz, C. L., Smock, K. J., & Winston-McPherson, G. N. (2025). A Comprehensive Review of Estradiol, Progesterone, Luteinizing Hormone, and Follicle-Stimulating Hormone in the Context of Laboratory Medicine to Support Women's Health. *Clinical Chemistry*, hvae039. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvae039>
- Harper, J. C., Phillips, S., Biswakarma, R., Yasmin, E., Saridoğan, E., Radhakrishnan, S., Davies, M., & Talaulikar, V. (2022). An online survey of perimenopausal women to determine their attitudes and knowledge of the menopause. *Women's Health*, 18, 17455057221106890. <https://doi.org/10.1177/17455057221106890>
- Hickey, M., LaCroix, A. Z., Doust, J. A., Mishra, G. D., Sivakami, M., Garlick, D., & Hunter, M. S. (2024). An empowerment model for managing menopause. *The Lancet*, 403(10430), 947–957. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02799-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02799-x)
- Johnston, S. L., Bouchard, C., Fortier, M., & Wolfman, W. (2021). Guideline No. 422b: Menopause and Genitourinary Health. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 43(11), 1305-1315.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2021.09.001>
- Kawakita, T., Yasui, T., Yoshida, K., Matsui, S., & Iwasa, T. (2023). Associations of LH and FSH with reproductive hormones depending on each stage of the menopausal transition. *BMC Women's Health*, 23(1), 305. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02438-5>

- Lambrinoudaki, I., Armeni, E., Goulis, D. G., Bretz, S., Ceașu, I., Durmuşoğlu, F., ... & Rees, M. (2022). Menopause, wellbeing and health: A care pathway from the European Menopause and Andropause Society. *Maturitas*, 163, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2022.04.008>
- Lestari, A. D., Sari, N. P. W. P., & Rosmila, R. (2025). Faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita dalam menghadapi masa menopause di wilayah kerja Puskesmas Bangkala. *JOURNAL of Public Health Concerns*, 5(2), 890-896. <https://doi.org/10.56922/phc.v5i2.890>
- Lycke, M., Brorsson, A., & Andersson, E. (2025). Midwives' experiences of working with menopause counselling: a qualitative study. *Midwifery*, 147, 104435. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2025.104435>
- Marlia, T. (2021). Hubungan Antara Paritas Dan Riwayat Merokok Dengan Menopause Dini Pada Lansia. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 248-254. <https://doi.org/10.38165/jk.v12i2.248>
- Rees, M., Abernethy, K., Bachmann, G., Bretz, S., Ceașu, I., Durmuşoğlu, F., ... & Lambrinoudaki, I. (2022). The essential menopause curriculum for healthcare professionals: A European Menopause and Andropause Society (EMAS) position statement. *Maturitas*, 158, 28-35. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2021.12.001>
- Yang, J., Hodara, E., Sriprasert, I., Shoupe, D., & Stanczyk, F. Z. (2024). Estrogen deficiency in the menopause and the role of hormone therapy: integrating the findings of basic science research with clinical trials. *Menopause*, 31(8), 926-939. <https://doi.org/10.1097/gme.0000000000002407>

J. Glosarium

Amenorea: Kondisi tidak adanya periode menstruasi.

Andropause: Istilah populer untuk *Late-Onset Hypogonadism* (LOH), merujuk pada sindrom klinis yang terkait dengan penurunan kadar testosteron seiring bertambahnya usia pada laki-laki.

Atresia Folikel: Proses degenerasi dan kematian terprogram dari folikel ovarium.

Estrogen: Kelompok hormon steroid yang berfungsi sebagai hormon seks primer pada perempuan, bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seksual sekunder dan regulasi siklus menstruasi.

Follicle-Stimulating Hormone (FSH): Hormon yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium.

Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM): Kumpulan gejala dan tanda yang terkait dengan penurunan estrogen pada area vulvovaginal dan saluran kemih bawah.

Klimakterium: Periode transisi dalam kehidupan perempuan dari masa reproduktif ke non-reproduktif, mencakup perimenopause, menopause, dan awal pascamenopause.

Menopause: Berhentinya menstruasi secara permanen yang didiagnosis secara retrospektif setelah 12 bulan amenorea berturut-turut tanpa penyebab patologis.

Pascamenopause: Fase kehidupan setelah menopause, dimulai 12 bulan setelah periode menstruasi terakhir.

Perimenopause: Periode waktu "sekitar menopause," ditandai dengan ketidakaturan siklus menstruasi dan fluktuasi hormonal yang mendahului menopause.

STRAW +10: *Stages of Reproductive Aging Workshop*, sebuah sistem klasifikasi standar yang membagi penuaan reproduksi perempuan menjadi 10 tahap.

CHAPTER 2

PERUBAHAN HORMONAL, FISIK, DAN PSIKOLOGIS PADA MASA KLIMAKTERIUM

Muninggar, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Klimakterium adalah masa transisi yang diawali dari akhir proses reproduksi dan berakhir pada awal senium biasanya terjadi pada wanita usia 45-65 tahun pada masa ini digejalai dengan berbagai macam yaitu, endokrinologis dan vegetative pada masa itu biasanya disebabkan oleh adanya penurunan ovarium salah satu gejala khasnya yaitu berhentinya menstruasi pada wanita yang dikenal sebagai perimenopause. (Nuramalia, 2024)

Dalam Siklus kehidupan seorang wanita, terdapat enam tahapan perkembangan yang sesuai dengan perubahan anatomi dan fisiologi. Diantaranya dimulai dari masa prapubertas, pubertas, reproduksi, klimakterium, menopause bahkan hingga fase lanjut usia. Pada dasarnya menjelang menopause, Wanita cenderung akan mengalami perubahan fisik dan psikologis disebabkan adanya penurunan fungsi tubuh yaitu penurunan gejala vasomotor, dan terjadinya ketidakseimbangan hormonal progesterone dan juga esterogen. (Tirtonegoro, 2024).

Sorang perempuan yang usianya sudah mulai memasuki masa klimakterium terkadang memiliki beberapa keluhan, diantaranya adanya perubahan fisik dan mulai meningkatnya kerapuhan pada tulang yang menyebabkan terganggunya aktivitas setiap hari, namun keluhan juga mulai terjadi pada sistem kardiovaskuler seperti adanya penyakit jantung coroner beberapa akibat lainnya yaitu meningkatnya angka kanker payudara maupun endometrium jika beberapa gejala patologis tidak segera di atasi dengan baik. (Hamdajani, 2023).

Dalam data World Health Organizations (WHO) Tahun 2022 jumlah menepous diseluruh dunia mencapai angka 38.9% yang artinya dari total 4.8 miliar wanita di dunia 1.8 miliar wanita sudah memasuki masa klimakterium. Padata data WHO Tahun 2025 menyatakan bahwa wanita diasia akan mngalami peningkatan 107 juta jiwa akan menjadi 273 juta jiwa. Pada tahun 2020 di Indonesia baru mencapai 14 juta wanita menopause atau 7.4 dari popilasi yang ada (Suharnita, 2024).

B. Klimakterium

Klimakterium adalahh fase peralihan yang dialami perempuan dari periode reprodktif ke periode non-produktif (menopause). Pada perempuan yang akan atau sudah memasuki masa menopause, aktivitas menstruasi akan mengalami penurunan dan berakhir di tidak menstruasi kembali. Penyebab utamanya adalah penurunan hormon yang disebut dengan hormon endrogen dan progesteron yang menyebabkan ovarium tidak menghasilkan sel telur kembali.hal ini menunjukkan adanya perubahan secara fisiologis yang akan dialami oleh perempuan pada umumnya, perempuan akan mengalami beberapa fase yaitu: tahapan primenopause, perimenopause, menopause dan pasca menopause. (Tampubolon, 2025) (Ifayanti, 2025)

Pada fase pre-menopause, perempuan mengalami perubahan dalam sistem endokrin, fisik, dan mental yang terjadi selama masa reproduksinya. Dalam periode ini, wanita beradaptasi dengan penurunan produksi hormon. Dampak yang dirasakan oleh perempuan bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kedewasaan mental, latar belakang sosial ekonomi, budaya, pemahaman tentang menopause, dan kematangan emosional. Jika seorang wanita tidak siap secara mental untuk menghadapi fase klimakterik atau menjelang menopause, dan lingkungan psikososialnya tidak memberikan dukungan yang positif, hal ini dapat berakibat buruk (irawati, 2024)

Masalah pada masa pre menopause sangat bervariasi dan dapat berlangsung lama atau sementara. Permasalahan yang dijumpai pada masa pre menopause seperti *hot flashes*, berkeringat malam, fatigue, insomnia, depresi, ansietas, gangguan daya ingat, gejala urogenital, dan sering menyebabkan gangguan kualitas hidup.

Seorang wanita biasanya mulai mengalami perimenopause pada sekitar usia 40 tahun dan akan menyentuh fase menopause pada usia sekitar 51,5 tahun. Namun, usia untuk memasuki perimenopause bervariasi pada tiap individu. Berbagai faktor mempengaruhi perbedaan usia ini. Wanita yang tidak pernah melahirkan, menderita diabetes, perokok berat, memiliki pola makan yang tidak sehat, menjalani gaya hidup vegetarian, berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang, atau tinggal di daerah dengan ketinggian lebih dari 4000 meter, cenderung mengalami menopause lebih awal. Selain itu, wanita kembar dizigot atau yang memiliki siklus menstruasi yang lebih pendek juga akan mencapai menopause lebih awal. Sebaliknya, wanita yang pernah melahirkan banyak anak, sering mengonsumsi daging, atau mengonsumsi alkohol biasanya akan memasuki perimenopause lebih lambat. (Irawati, K., 2021)

Tindakan yang bisa diambil oleh wanita untuk menghadapi perubahan fisik yang terjadi pada masa premenopause adalah dengan menerima proses menopause sambil memperhatikan pola hidup, seperti mengatur pola makan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi berbagai jenis vitamin, rutin berolahraga, menghindari rokok dan minuman beralkohol, serta membatasi asupan kafein, alkohol, garam, dan gula. Selain itu, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Untuk mengatasi perubahan psikologis, perempuan bisa berpikir positif melalui penerimaan yang baik dan menghindari stres, serta memperkuat ibadah agar dapat menciptakan penerimaan yang lebih positif. . (Atikah, 2021)

C. Etiologi

Bertambahnya usia menyebabkan penipisan bertahap folikel ovarium melalui proses atresia dan ovulasi. Jumlah sel granulosa dalam ovarium berkurang, yang berdampak pada penurunan produksi estradiol dan inhibin Kadar hormon antimullerian (AMH), hormon lainnya yang diproduksi oleh sel granulosa ovarium, juga mengalami penurunan. Berkurangnya umpan balik penghambatan dari estrogen dan inhibin A serta B menyebabkan peningkatan produksi hormon perangsang folikel (FSH) dan hormon luteinizing (LH). Penurunan estrogen mengganggu sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium dan menyebabkan masalah pada perkembangan endometrium yang normal. Perubahan hormonal dan fisik ini berkontribusi terhadap siklus menstruasi yang tidak teratur yang pada akhirnya berujung pada penghentian menstruasi sepenuhnya.(Irawati, K., 2021)

Selama fase perimenopause, perubahan awal pada siklus menstruasi umumnya menunjukkan pemendekan pada fase folikuler, yang mengakibatkan menstruasi yang lebih sering. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi biasanya menghasilkan siklus menstruasi yang menjadi lebih panjang. Banyak siklus menjadi anovulasi, yang menyebabkan perdarahan uterus yang tidak normal pada masa perimenopause. Akhirnya, menstruasi akan berhenti sepenuhnya. Level testosteron tidak banyak berubah selama menopause awal, yang mengakibatkan peningkatan relatif rasio testosteron terhadap estrogen yang dapat memicu gejala terkait kelebihan androgen.

Menopause juga bisa terjadi akibat tindakan bedah, seperti oophorektomi dua sisi. Faktor lain yang dapat memicu menopause termasuk pengobatan untuk berbagai kondisi kesehatan, seperti endometriosis, kemoterapi untuk kanker—terutama dengan obat alkilasi—terapi radiasi, penyakit jangka panjang, seperti HIV-AIDS, serta pengobatan yang menggunakan agen antiestrogen. Diskusi ini akan lebih menitikberatkan pada menopause yang terjadi secara alami.

D. Patofisiologi

Menopause adalah tahap alami dalam proses penuaan wanita yang dicirikan oleh penurunan drastis jumlah folikel ovarium utama, sehingga tidak ada cukup folikel untuk bereaksi terhadap hormon perangsang folikel (FSH). Kurangnya reaksi dari folikel menghambat kenaikan hormon luteinizing (LH) dan ovulasi, yang berujung pada penurunan kadar estrogen dan akhirnya menghentikan menstruasi. Setelah menopause, kadar LH dan FSH tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Sedikit estrogen masih dapat diproduksi melalui pengubahan testosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal, yang mungkin menyebabkan gejala yang minimal selain berhentinya menstruasi pada beberapa wanita.

Lebih dari 80% wanita mengalami gejala selama fase peralihan menopause, meskipun setiap pengalaman bisa sangat berbeda. Berbagai faktor memengaruhi perubahan fisik terkait menopause, termasuk pola makan, kebiasaan merokok, ras, kondisi kesehatan, aktivitas fisik, latar belakang ekonomi, indeks massa tubuh, dan kesehatan reproduksi secara umum.

E. Perubahan Fisik Pada Masa Klimakterium

Proses penuaan pada dasarnya sudah dimulai ketika seorang wanita mencapai usia 40 tahun. Saat dilahirkan, seorang wanita memiliki sekitar 750.000 folikel, dan jumlah ini akan terus berkurang seiring bertambahnya usia hingga hanya tersisa beberapa ribu saat memasuki masa menopause. Dengan bertambahnya usia, terutama ketika memasuki periode perimenopause, folikel-folikel ini semakin tahan terhadap rangsangan gonadotropin. Ini mengakibatkan perlahan-lahan terhentinya perkembangan folikel, ovulasi, dan pembentukan korpus luteum dalam siklus ovarium. Di antara wanita yang berusia di atas 40 tahun, sekitar 25% mengalami siklus menstruasi yang tidak ovulasi. Ketahanan folikel terhadap gonadotropin berperan dalam mengurangi produksi estrogen dan meningkatkan kadar hormon gonadotropin. Tingginya kadar gonadotropin ini disebabkan oleh rendahnya estrogen, sehingga tidak ada umpan balik negatif pada sistem hipotalamus dan hipofisis. Meskipun terjadi perubahan hormon secara endokrin, tidak ada ukuran spesifik untuk menentukan kadar hormon yang bisa menunjukkan fase awal atau akhir dari transisi menopause.(Elly Dwi Wahyuni., 2019)

Seorang wanita yang telah mencapai masa menopause umumnya mengalami berbagai keluhan, seperti perubahan fisik dan peningkatan risiko kerapuhan tulang (Baziad, 2003). Secara umum, gejala yang muncul akibat menopause mencakup menstruasi yang tidak teratur, semburan panas (hot flushes), serta perubahan

emosional. Di samping gejala-gejala itu, wanita yang menopause berisiko lebih tinggi terhadap kerapuhan tulang (osteoporosis) dan lebih rentan terhadap beberapa penyakit, seperti yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Kerapuhan tulang pada wanita menopause bisa menyebabkan peningkatan kemungkinan patah tulang. Di sisi lain, masalah kardiovaskular yang muncul adalah penyakit jantung koroner. Selain itu, terdapat peningkatan kasus kanker payudara dan kanker endometrium (Baziad, 2003). Proses klimakterium dan menopause biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik, namun ada kemungkinan faktor lain juga berperan sehingga menopause dapat terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut termasuk kondisi sosial ekonomi dan status gizi. (Hamdajani, 2023)

F. Perubahan Hormon pada masa klimakterium

1. Estrogen

Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium. Estrogen berfungsi untuk mendorong pertumbuhan sel di jaringan labia, vagina, rahim, tuba falopi, dan payudara, serta memunculkan ciri-ciri fisik seksual wanita seperti payudara, bentuk tubuh, dan rambut di area genital. Selain itu, estrogen berperan penting dalam siklus menstruasi dengan membantu menebalkan lapisan endometrium serta menjaga kualitas dan jumlah cairan serviks dan vagina agar mendukung penetrasi sperma. Ada tiga jenis estrogen dalam tubuh, yaitu estradiol, estron, dan estriol, tetapi estradiol merupakan yang paling krusial untuk proses reproduksi. Estradiol adalah bentuk estrogen terkuat yang diproduksi oleh ovarium dan berperan dalam perkembangan payudara. Estron, yang merupakan bentuk estrogen yang lebih lemah dibandingkan estradiol, diproduksi oleh ovarium dan jaringan lemak. Estron adalah bentuk estrogen yang paling lemah. (Bdn Susi Hartati, SST., 2024)

2. Progesteron

Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum. Selama kehamilan, progesteron juga dihasilkan oleh plasenta. Proses pembentukan dan pelepasan progesteron dipicu oleh Luteinizing Hormone (LH). Fungsi dari hormon ini adalah mempersiapkan dinding rahim agar dapat menerima hasil konsepsi. Kadar progesteron dijaga tetap tinggi selama trimester pertama kehamilan hingga plasenta dapat memproduksi Hormon Chorionic Gonadotrophine (HCG).

3. Gonadotrophine Releasing Hormone (GnRH)

GnRH adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Hormon ini akan merangsang pelepasan Follicle Stimulating Hormone (FSH) dari kelenjar

hipofisis. Saat kadar estrogen tinggi, estrogen akan memberi sinyal kembali ke hipotalamus sehingga kadar GnRH menurun, dan sebaliknya.

4. FSH dan LH

FSH dan LH dikenal sebagai hormon gonadotrophin yang diproduksi oleh bagian depan hipofisis sebagai respons terhadap rangsangan dari GnRH. FSH bertanggung jawab untuk mematangkan folikel, sedangkan LH menyebabkan folikel yang telah matang untuk pecah dan mengeluarkan ovum. Folikel yang sudah matang ini kemudian berubah menjadi korpus luteum dan akan dipertahankan untuk beberapa waktu oleh LH.

G. Perubahan Psikologis Pada masa Klimakterium

Perubahan mental selama fase perimenopause jelas sering muncul. Banyak wanita mengalami fluktuasi hormonal dan merasa perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung, membuat proses menopause terasa sangat menantang. Cara seorang wanita memandang menopause, termasuk seberapa banyak dia memahami proses tersebut, sangat menentukan perubahan mental yang terjadi. Dampak dari perubahan mental ini dapat sangat memengaruhi kualitas hidup individu. Berikut adalah beberapa ciri-ciri perubahan emosi yang bisa dialami oleh wanita yang sedang melewati menopause. (saleha.Siti., S.ST., 2024)

1. Penurunan daya ingat

Kadar estrogen yang berkurang memengaruhi neurotransmitter di dalam otak. Di dalam otak, ada beberapa neurotransmitter seperti dopamine, serotonin, dan endorfin. Neurotransmitter ini memainkan peranan penting dalam mendukung kehidupan. Sementara itu, endorfin memiliki fungsi yang berkaitan dengan memori dan perasaan, seperti rasa sakit atau ketidaknyamanan. Selama fase pramenopause, produksi endorfin menurun, yang berhubungan dengan turunnya kadar estrogen dalam darah. Penurunan level endorfin, dopamine, dan serotonin menyebabkan masalah yang tampak sebagai berkurangnya kemampuan ingat dan perubahan suasana hati, sering kali ditandai dengan memori yang lemah dan sifat yang mudah tersinggung. Tanda-tanda penurunan daya ingat dapat dilihat pada wanita yang sebelum fase perimenopause cenderung mudah mengingat. Namun, setelah memasuki perimenopause, terdapat penurunan kemampuan mengingat, bahkan mereka sering kali melupakan hal-hal kecil dan sederhana.

2. Kecemasan

Banyak wanita yang berada dalam fase perimenopause merasa lebih rentan terhadap kecemasan. Perasaan cemas ini muncul disebabkan oleh kekhawatiran yang terus menuntut perhatian mereka terkait situasi yang sebelumnya tidak

menjadi masalah. Kecemasan ini umumnya bersifat temporer, artinya bisa diatasi dan diredakan. Namun, bagi sebagian individu, hal ini menjadi sulit untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa tanda-tanda psikologis yang sering dirasakan oleh wanita yang memasuki masa menopause:

- a. Perubahan suasana hati yang menunjukkan ketidakstabilan emosional, seperti mudah tersulut emosi atau merasa tertekan.
- b. Pikiran yang tidak terarah akibat ketakutan yang berkepanjangan, sehingga mereka kesulitan untuk memusatkan perhatian. Terkadang, mereka juga merasa pikiran mereka kosong dan berlebihan dalam memikirkan ancaman.
- c. Tingkat sensitivitas yang tinggi dan perasaan tak berdaya.
- d. Kecenderungan untuk menghindari situasi yang memicu kecemasan, serta mengabaikan realitas.
- e. Tingkah laku yang gelisah seperti rasa gugup, kegelisahan, dan kewaspadaan yang berlebihan.
- f. Gangguan psikogenik yang meliputi meningkatnya kecemasan, depresi, perasaan mudah cemas, masalah tidur, serta sakit kepala. Kondisi lain dapat semakin parah akibat gejala menopause, termasuk masalah psikosomatik yang diperburuk oleh gejala panas, gangguan pola tidur dengan keringat malam, dan penurunan hasrat seksual karena vaginitis atrofi yang menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual. (Rolas, 2024)

3. Mudah Tersinggung

Penurunan kadar estrogen berpengaruh pada zat kimia di otak. Zat kimia yang ada di otak termasuk: dopamin, serotonin, dan endorfin. Dopamin berperan dalam mengatur emosi, sistem imun, dan libido. Kadar dopamin dipengaruhi oleh estrogen, sementara itu endorfin dapat membantu merangsang produksi dopamin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati dan waktu istirahat. (dr Novitrian, 2024)

Gejala ini lebih jelas terlihat jika dibandingkan dengan rasa cemas. Wanita yang mengalami menopause cenderung lebih cepat tersulut emosi dan marah. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang mereka alami. Perasaan mereka sangat peka terhadap sikap dan tindakan orang-orang di sekitarnya. Kondisi ini akan sangat terlihat ketika mereka melihat perilaku tersebut dengan cara yang negatif dan merasa tersinggung.

4. Stres

Reaksi stres yang dialami oleh wanita menopause sangat bervariasi dan kadang-kadang bersifat jangka panjang. Dari segi psikologis, sumber-sumber stres bagi wanita menopause tidak dapat diprediksi dengan mudah, tetapi yang dapat diamati adalah perubahan suasana hati, seperti respons marah atau sedih.

Beberapa faktor yang memicu stres pada wanita menopause meliputi kondisi emosional pribadi dan sikap orang-orang di sekitarnya. (Trisetiyaningsih, 2023)

5. Depresi

Penelitian mengungkapkan bahwa perempuan yang mengalami menopause memiliki risiko lebih tinggi dan lebih mudah mengalami depresi dibandingkan dengan fase kehidupan mereka sebelumnya. Gejala-gejala depresi pada perempuan menopause dapat terlihat dari:

- a. Berkurangnya kepercayaan diri terkait kemampuan reproduksinya.
- b. Kesedihan karena ditinggal oleh anak-anak atau suami yang telah meninggal.
- c. Merasa sedih karena penurunan daya tarik fisik.
- d. Merasa tertekan karena semua aktivitas dan perannya telah diambil alih.
- e. Mengalami sakit yang tak kunjung sembuh atau kondisi kesehatan yang kronis. (Indonesia, 2024)

H. Simpulan

Masa menopause adalah periode transisi yang dialami perempuan berusia antara 45 hingga 65 tahun, yang ditandai dengan perubahan hormon yang signifikan, terutama penurunan kadar estrogen dan progesteron. Perubahan ini memicu berbagai gejala fisik dan emosional, seperti bengkak panas, masalah tidur, serta berkurangnya keinginan seksual, dan juga meningkatkan kemungkinan munculnya masalah kesehatan seperti osteoporosis dan penyakit jantung. Selain itu, banyak wanita merasa cemas, mengalami depresi, dan perubahan emosi akibat penurunan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan endorfin. Masa menopause terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu premenopause, perimenopause, menopause, dan pasca-menopause, di mana lebih dari 80% perempuan merasakan gejala saat melalui fase transisi ini. Karena itu, sangat penting bagi wanita untuk menerapkan gaya hidup sehat, menjalani pemeriksaan kesehatan yang rutin, serta mengelola stres guna mengurangi efek negatif dari perubahan yang terjadi selama masa menopause.

I. Referensi

- Atikah, P. (2021). *Menopause dan sindrom premenopause*. Nuha Medika.
- Bdn Susi Hartati, SST., M. K. (2024). *Kesehatan Reproduksi dan Klimakterium* (R. Nurismail (ed.); Riszki Nur). Buku Loka.
- dr Novitrian, E. P. (2024). *Mengenal Klimakterium pada Wanita dan Gejalanya*. Ciputra IVF.
- Elly Dwi Wahyuni., S. S. m. ke. (2019). *Kesiapan Ibu Menghadapi Masa Klimakterium*

(Poltekes Kemenkes Jakarta III (ed.); Poltekes K). Women's reproductive health Center.

- Hamdajani, M. D. O. (2023). Pendidikan Kesehatan Tentang Perubahan Fisik dan Psikologis Pada Masa Klimakterium. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 03 No(2746–3818), 49–53. <https://doi.org/10.30587/ijcd.v3i025487>
- Ifayanti, H. (2025). EDUKASI PERUBAHAN PADA MASA KLIMAKTERIUM. *Jurnal Pngabdian Masyarakat*, vol 7 No 2(2715–95558), 143–148.
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Dampak Kesehatan Menopause*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Irawati, K., Bu. (2021). Stress Management Training For Working, elderly, and health cadre women: Rumah Pendamping Emak Sehat Jiwa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 7(2), 130–136.
- irawati, harahap. (2024). Hubungan Pengetahuan Perempuan Dengan Kesiapan menghadapi menopause di Desa Perigi. Dolok Kabupaten Padang lawa utara. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol 9 NO 1, 109–112.
- Nuramalia, D. alif hidayatul laila. (2024). Edukasi Perubahan Pada Masa Klimakterium Atau Menopause Kepada Ibu PKK Di desa Raci Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3030=8895, 80–489.
- Rolas, M. (2024). *Kenali Perubahan Psikologis pada wanita setelah menopause*. IHC PT Rolas Nusantara Medika.
- saleha.Siti., S.ST., M. K. (2024). *Buku Ajar Perempuan Dan Kesehatan Keluarga* (I. Zumarano (ed.)). Nuansa Pajar Cemerlang.
- Suharnita, W. (2024). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perempuan Umur 40-55 Tahun Dalam Menghadapi Menopause di Kelurahan Buntu Burake Tahun 2024. *Jurnal Edu Reearch*, Vol 4 No 5, 1086–1096.
- Tampubolon, lindawati F. (2025). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Perempuan Mneepouse Sewaktu Menghadapi Fase Klimakterium Di Klinik Romana Tahun 2024. *Jurnal of Innovative and Creatvity*, vol 5 No 3(30195–30202), 30195–30205.
- Tirtonegoro, soeradji dr. (2024, November). Perubahan Hormonal Pada Masa Menopause. *Artikel*, 1. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3817/perubahan-hormonal-pada-masa-menopause
- Trisetiyaningsih, Y. (2023). Gambaran Gejala Menopause dan Psychology well being pada wanita klimakterium. *Jurnal Formail KesMas Respati*, Vol 8 No.(2550–0864), 99–108.

J. Glosarium

AMH (Anti-Müllerian Hormone)	:	Hormon yang diproduksi oleh sel granulosa ovarium yang mencerminkan cadangan folikel ovarium.
Ansietas	:	Perasaan cemas berlebihan yang sering muncul tanpa sebab jelas dan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari.
Atresia	:	Proses degenerasi atau penurunan jumlah folikel ovarium secara alami seiring bertambahnya usia.
Dopamin	:	Neurotransmitter di otak yang berperan dalam pengaturan emosi, motivasi, dan kesenangan.
Endometrium	:	Lapisan dalam rahim yang menebal selama siklus menstruasi untuk persiapan kehamilan.
Endorfin	:	Zat kimia alami dalam tubuh yang berfungsi mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan perasaan bahagia.
Estrogen	:	Hormon utama wanita yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan pengaturan siklus menstruasi.
Estradiol	:	Bentuk estrogen paling kuat yang berperan penting dalam fungsi reproduksi wanita.
Estron	:	Salah satu jenis estrogen yang biasanya meningkat selama kehamilan.
Etiologi	:	Ilmu yang mempelajari penyebab suatu kondisi atau penyakit
FSH (Follicle Stimulating Hormone)	:	Hormon yang merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium.
GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)	:	Hormon dari hipotalamus yang mengontrol pelepasan FSH dan LH
Hipofisis	;	Kelenjar di otak yang mengatur produksi berbagai hormon dalam tubuh.
Hipotalamus	;	Bagian otak yang mengontrol sistem hormon dan menjaga keseimbangan tubuh.
Hot Flashes (Semburan Panas)	;	Sensasi panas tiba-tiba pada tubuh, terutama di wajah dan dada, yang umum terjadi saat menopause.
Insomnia	:	Gangguan tidur yang menyebabkan kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur
Klimakterium	:	Masa transisi dari periode reproduktif ke non-reproduktif pada wanita.

Korpus Luteum	:	Struktur di ovarium yang terbentuk setelah ovulasi dan menghasilkan progesteron.
LH (Luteinizing Hormone)	:	Hormon yang memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum.
Menopause	:	Berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium.
Neurotransmitter	:	Zat kimia di otak yang berfungsi menghantarkan sinyal antar sel saraf.
Ooforektomi	:	Tindakan bedah pengangkatan ovarium.
Osteoporosis	:	Kondisi kerapuhan tulang akibat penurunan kepadatan tulang.
Ovarium	:	Organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur dan hormon.
Ovulasi	:	Proses pelepasan sel telur dari ovarium.
Perimenopause	:	Fase sebelum menopause yang ditandai dengan perubahan hormonal dan siklus menstruasi tidak teratur.
Postmenopause	:	Fase setelah menopause dimana menstruasi telah berhenti sepenuhnya.
Premenopause	:	Fase sebelum terjadi perubahan menuju menopause.
Progesteron	:	Hormon yang berfungsi mempersiapkan rahim untuk kehamilan.
Psikosomatik	:	Gangguan fisik yang dipengaruhi oleh faktor psikologis.
Serotonin	:	
Serotonin	:	Neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, dan emosi. Siklus menstruasi tanpa terjadinya ovulasi.
Vasomotor	:	Berkaitan dengan pengaturan pembuluh darah, seperti gejala hot flashes.

CHAPTER 3

KELUHAN YANG SERING DIALAMI PEREMPUAN PADA MASA MENOPAUSE

Dr. An Nisa Fithri, Amd,Keb., M.KM.

A. Pendahuluan

Menopause merupakan fase alami dalam siklus kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium. Kondisi ini umumnya terjadi pada usia 45–55 tahun dan menjadi bagian dari proses penuaan reproduksi perempuan. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, jumlah perempuan yang memasuki masa menopause juga semakin meningkat sehingga permasalahan kesehatan pada periode ini memerlukan perhatian yang lebih komprehensif. Perubahan hormonal, khususnya penurunan hormon estrogen dan progesteron, menyebabkan berbagai perubahan fisiologis maupun psikologis pada perempuan menopause. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah gangguan metabolik dan kenaikan berat badan. Banyak perempuan mengalami peningkatan berat badan, terutama pada area abdomen, meskipun pola makan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini berkaitan dengan perlambatan metabolisme tubuh, penurunan massa otot, serta perubahan distribusi lemak tubuh yang dipengaruhi oleh penurunan estrogen. Gangguan metabolik pada masa menopause tidak hanya berdampak terhadap penampilan fisik, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif seperti obesitas sentral, diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dislipidemia, dan penyakit kardiovaskular. Penumpukan lemak abdominal diketahui berhubungan erat dengan sindrom metabolik yang dapat menurunkan kualitas hidup perempuan menopause. Selain faktor hormonal, gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi kalori, stres, dan gangguan tidur turut berkontribusi terhadap terjadinya kenaikan berat badan pada perempuan menopause. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, modifikasi gaya hidup, serta pendekatan berbasis *evidence based practice* untuk membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan metabolik. Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, serta pendampingan kepada perempuan menopause agar mampu memahami perubahan yang terjadi dan menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan asuhan

yang holistik diharapkan dapat membantu perempuan menopause menjalani proses penuaan secara sehat, aktif, dan berkualitas.

B. Perubahan dan gejala menopause

Gejala menopause sudah dikenal secara luas, beberapa efek sistemik penting yang memengaruhi kesehatan yang terjadi di antaranya:

1. Penyakit kardiovaskular (CVD) dikenal sebagai penyebab peningkatan mortalitas di kalangan wanita, khususnya wanita pascamenopause. Estrogen bersifat kardioprotektif karena meningkatkan kadar lipoprotein densitas tinggi dan menurunkan tingkat lipoprotein densitas rendah. Wanita pasca-menopause kekurangan estrogen dan risiko mereka terkena penyakit kardiovaskular meningkat dibandingkan dengan rekan pria pada usia 70 tahun (Stevenson, *et al.*, 2021). Obesitas trunkal, faktor risiko independen penyakit kardiovaskular, dikendalikan oleh proporsi androgen relatif Kondisi androgen tinggi merupakan faktor risiko terjadinya penurunan estrogen dan resistensi insulin dapat berkontribusi pada keadaan risiko dapat di cegah oleh strategi pencegahan yang normal; penggunaan penggantian hormon tidak diindikasikan (Stevenson, *et al.*, 2021).
2. Penuaan ovarium terprogram dipercepat seiring usia wanita Wanita pasca-menopause telah menandai perbedaan anatomi karena penuaan, termasuk: volume yang lebih kecil, kurangnya kista folikel, peningkatan folikel atretik, dan corpora albicans persisten (O'Neill & Eden, 2017).
3. Endometrium bereaksi dengan kadar estrogen dan progesteron serum, yang berfluktuasi tergantung pada tahap transisi menopause Awal: penebalan endometrium berfluktuasi sebagai respons terhadap kadar estrogen dan hambat oleh progesterone Akhir : anovulasi estrogen tidak lagi dihambat oleh progesteron peningkatan proliferasi dan disorganisasi jaringan endometrium Estrogen berasal dari aromatisasi ekstragonadal androgen ke estrogen karena obesitas Penurunan globulin pengikat hormon seks (SHBG) meningkatkan kadar bebas, bioavailable estrogen. Pasca menopause: tidak ada estrogen atrofi dan perubahan kistik
4. Reseptor estrogen dan progesteron di seluruh saluran Kekurangan substrat menyebabkan: penurunan vaskularisasi menyebabkan penurunan otot, penurunan lapisan epitel, peningkatan deposit lemak menimbulkan iritasi, rasa terbakar, gatal dan kurangnya pelumasan. Perubahan tersebut menyebabkan dyspareunia karena atrofi vagina yang mengarah ke peningkatan trauma jaringan dan perdarahan Kurang glikogen dan asam laktat menyebabkan pH berubah ke keadaan yang lebih basa (dari ~ 4,5 hingga ~ 7) mengalami peningkatan

kerentanan terhadap infeksi. Reseptor pada jaringan ikat dapat mempengaruhi kelemahan struktur ligamen di dasar panggul menyebabkan inkontinensia dan prolaps struktur pelvis ke dalam vagina meningkat setelah menopause (O'Neill & Eden, 2017).

5. Struktur duktus dipengaruhi oleh estrogen Struktur lobular dipengaruhi oleh progesterone penurunan kadar serum baik pada periode pascamenopause menyebabkan hilangnya volume penggantian jaringan payudara padat dengan adiposa lunak (Monteleone *et al.*, 2018).
6. Gejala vasomotor yang dialami menopause jangka pendek seperti hot flushes dan keringat malam (vasomotor menopause sindrom/VMS). Vasomotor menopause sindrom semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa PMS dapat menjadi biomarker untuk penyakit kronis (Biglia *et al.*, 2017). Health Across the Nation (SWAN), melakukan penelitian hasilnya 60-80% wanita menopause, mengalami VMS selama transisi menopause

Gambaran klinis: Paling sering terjadi pada transisi menopause terlambat dan pascamenopause dini, ketika fluktuasi kadar estrogen paling tinggi Ditandai dengan hot flash / flushes dan keringat berlebihan yang muncul tiba-tiba, diikuti oleh kedinginan Biasanya berlangsung 1-5 menit; pada tubuh bagian atas umumnya terjadi di malam hari. Gejala ini dipicu oleh stres, lingkungan yang panas dan makanan pedas (Al-Safi & Santoro, 2014).

C. Keluhan yang Sering Dialami Perempuan pada Masa Menopause

1. Vasomotor symptoms

Vasomotor symptoms (VMS) merupakan kumpulan gejala yang paling sering dialami perempuan selama masa perimenopause dan menopause akibat perubahan regulasi suhu tubuh yang dipengaruhi oleh penurunan hormon estrogen. Gejala ini umumnya berupa sensasi panas mendadak pada wajah, leher, dan dada yang dikenal sebagai *hot flushes*, serta keringat berlebih pada malam hari (*night sweats*). Kondisi tersebut dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan sering kali disertai kemerahan pada kulit, jantung berdebar, serta rasa tidak nyaman.

Secara fisiologis, vasomotor symptoms terjadi karena penurunan kadar estrogen memengaruhi kerja hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Ketidakseimbangan hormon menyebabkan hipotalamus menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu kecil sehingga tubuh merespons secara berlebihan melalui pelebaran pembuluh darah dan peningkatan produksi keringat. Respons inilah yang menimbulkan sensasi panas secara tiba-tiba pada perempuan menopause.

Keluhan vasomotor dapat muncul dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda pada setiap perempuan. Beberapa perempuan hanya mengalami gejala ringan, sedangkan sebagian lainnya merasakan gangguan yang cukup berat hingga memengaruhi aktivitas sehari-hari, kualitas tidur, kondisi emosional, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Faktor seperti stres, kelelahan, konsumsi makanan pedas, kafein, merokok, serta suhu lingkungan yang panas dapat memperberat munculnya gejala vasomotor.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa vasomotor symptoms merupakan salah satu indikator utama perubahan hormonal pada masa menopause. Keluhan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis perempuan, seperti meningkatnya kecemasan, mudah marah, dan gangguan konsentrasi. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat diperlukan melalui pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis.

Penatalaksanaan vasomotor symptoms dapat dilakukan melalui terapi hormonal, perubahan gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, teknik relaksasi, serta penggunaan terapi komplementer tertentu yang telah didukung oleh evidence based practice. Edukasi dan konseling oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, juga memiliki peran penting dalam membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi selama menopause serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap gejala yang dialami.

a. Mekanisme Terjadinya *Vasomotor Symptoms*

Vasomotor symptoms pada perempuan menopause terutama terjadi akibat perubahan kadar hormon estrogen yang memengaruhi sistem pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi mengontrol keseimbangan suhu tubuh. Pada masa menopause, penurunan hormon estrogen menyebabkan pusat pengatur suhu menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu tubuh yang sangat kecil. Dalam kondisi normal, tubuh memiliki rentang toleransi suhu tertentu sehingga perubahan suhu ringan tidak menimbulkan respons berlebihan. Namun, pada perempuan menopause, rentang tersebut menjadi lebih sempit akibat ketidakseimbangan hormon. Akibatnya, sedikit peningkatan suhu tubuh dapat dianggap sebagai kondisi panas oleh hipotalamus sehingga tubuh segera melakukan mekanisme pelepasan panas. Respons tubuh terhadap kondisi tersebut ditunjukkan melalui pelebaran pembuluh darah perifer (*vasodilatasi*) terutama pada area wajah, leher, dan dada. Pelebaran pembuluh darah menyebabkan munculnya sensasi panas secara tiba-tiba atau *hot flushes*. Selain itu, tubuh juga meningkatkan produksi keringat sebagai upaya menurunkan suhu tubuh. Setelah episode tersebut berakhir, beberapa

perempuan dapat merasakan menggigil atau rasa dingin akibat penurunan suhu tubuh yang terjadi secara cepat. Selain dipengaruhi oleh hormon estrogen, mekanisme vasomotor symptoms juga berhubungan dengan perubahan neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan norepinefrin. Ketidakseimbangan zat tersebut dapat memengaruhi stabilitas pusat termoregulasi sehingga memperberat munculnya gejala vasomotor.

b. Faktor Pencetus *Vasomotor Symptoms* (Simon & Andrews, 2022)

Keluhan vasomotor pada masa menopause dapat dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan frekuensi maupun intensitas gejala yang dialami perempuan menopause.

1) Perubahan Hormonal

Penurunan kadar estrogen merupakan faktor utama yang memicu vasomotor symptoms. Semakin besar fluktuasi hormon yang terjadi, semakin tinggi kemungkinan munculnya gejala seperti hot flushes dan keringat malam.

2) Stres dan Kondisi Emosional

Keadaan psikologis seperti stres, kecemasan, dan ketegangan emosional dapat memengaruhi sistem saraf otonom sehingga memicu munculnya sensasi panas secara mendadak. Perempuan dengan tingkat stres tinggi umumnya lebih sering mengalami keluhan vasomotor.

3) Suhu Lingkungan yang Panas

Paparan suhu panas, ruangan yang kurang ventilasi, serta penggunaan pakaian tebal dapat meningkatkan suhu tubuh sehingga memicu hot flushes lebih sering terjadi.

4) Konsumsi Makanan dan Minuman Tertentu

Makanan pedas, minuman berkafein, serta alkohol diketahui dapat merangsang pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan sensasi panas pada tubuh.

5) Kebiasaan Merokok

Nikotin dalam rokok dapat memengaruhi sirkulasi darah dan metabolisme hormon estrogen sehingga meningkatkan risiko dan keparahan gejala vasomotor.

6) Obesitas atau Berat Badan Berlebih

Perempuan dengan indeks massa tubuh tinggi cenderung mengalami hot flushes lebih berat karena jaringan lemak dapat menghambat pengeluaran panas tubuh.

7) Kurangnya Aktivitas Fisik

Gaya hidup sedentari dapat memengaruhi metabolisme dan regulasi suhu tubuh sehingga gejala menopause lebih mudah muncul.

8) Kelelahan dan Gangguan Tidur

Kurang istirahat dan kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk sensitivitas tubuh terhadap perubahan suhu dan meningkatkan frekuensi keringat malam.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengendalian faktor pencetus melalui pola hidup sehat, manajemen stres, olahraga teratur, serta pengaturan lingkungan dapat membantu mengurangi gejala vasomotor pada perempuan menopause. Oleh karena itu, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan pada masa menopause.

2. Hot flushes

Hot flushes merupakan salah satu keluhan vasomotor yang paling sering dialami perempuan pada masa perimenopause dan menopause. Kondisi ini ditandai dengan munculnya sensasi panas secara tiba-tiba, terutama pada wajah, leher, dan dada, yang sering disertai kemerahan kulit, keringat berlebih, serta jantung berdebar.

a. Mekanisme terjadinya hot flushes

Mekanisme terjadinya hot flushes berkaitan erat dengan perubahan hormonal dan gangguan pengaturan suhu tubuh. Pada masa menopause, produksi hormon estrogen oleh ovarium mengalami penurunan secara signifikan. Estrogen memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pusat termoregulasi di hipotalamus, yaitu bagian otak yang berfungsi mengatur suhu tubuh. (Dalal & Agarwal, 2020)

Ketika kadar estrogen menurun, sensitivitas hipotalamus terhadap perubahan suhu tubuh menjadi meningkat. Dalam keadaan normal, tubuh memiliki zona termonetral, yaitu rentang suhu tertentu yang masih dapat ditoleransi tanpa memicu respons tubuh. Namun, penurunan estrogen menyebabkan zona tersebut menjadi lebih sempit sehingga perubahan suhu tubuh yang kecil sekalipun dapat dianggap sebagai peningkatan suhu yang berlebihan. Akibatnya, hipotalamus segera mengaktifkan mekanisme pelepasan panas. Respons pertama yang terjadi adalah pelebaran pembuluh darah perifer (*vasodilatasi*), terutama pada area wajah, leher, dan dada. Pelebaran pembuluh darah ini meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit sehingga timbul sensasi panas dan kemerahan. Selain itu, tubuh juga meningkatkan produksi keringat sebagai upaya menurunkan suhu tubuh melalui proses penguapan.

Setelah episode panas berakhir, beberapa perempuan dapat mengalami sensasi dingin atau menggigil akibat penurunan suhu tubuh yang berlangsung cepat. Gejala ini dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dengan frekuensi yang berbeda pada setiap individu. Selain faktor hormonal, mekanisme *hot flushes* juga dipengaruhi oleh perubahan neurotransmitter di sistem saraf pusat, terutama serotonin dan norepinefrin (Dalal & Agarwal, 2020)

Ketidakseimbangan neurotransmitter tersebut dapat memperberat ketidakstabilan pusat pengatur suhu sehingga gejala vasomotor lebih mudah muncul. Beberapa faktor seperti stres, konsumsi makanan pedas, kafein, merokok, suhu lingkungan panas, kelelahan, dan gangguan tidur diketahui dapat memicu atau memperberat *hot flushes*. Oleh karena itu, penatalaksanaan tidak hanya berfokus pada terapi hormonal, tetapi juga meliputi modifikasi gaya hidup, manajemen stres, aktivitas fisik teratur, serta edukasi kesehatan bagi perempuan menopause.

b. Faktor pencetus

Hot flushes pada perempuan menopause dapat dipicu oleh berbagai faktor yang memengaruhi kestabilan suhu tubuh dan sistem hormonal. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan frekuensi maupun intensitas gejala vasomotor yang dialami perempuan selama masa menopause.

1) Penurunan Hormon Estrogen

Penurunan kadar estrogen merupakan faktor utama yang memicu terjadinya *hot flushes*. Berkurangnya hormon estrogen menyebabkan gangguan pada pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga tubuh menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu yang kecil.

2) Stres dan Gangguan Emosional

Kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, mudah marah, dan ketegangan emosional dapat merangsang sistem saraf simpatis sehingga memicu sensasi panas secara tiba-tiba. Perempuan dengan tingkat stres tinggi cenderung mengalami *hot flushes* lebih sering.

3) Suhu Lingkungan Panas

Paparan udara panas, ruangan dengan ventilasi buruk, cuaca panas, atau penggunaan pakaian tebal dapat meningkatkan suhu tubuh dan memicu munculnya *hot flushes*.

4) Konsumsi Makanan Pedas

Makanan pedas dapat merangsang pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan produksi panas tubuh sehingga memperberat keluhan vasomotor.

5) Minuman Berkafein

Kafein yang terdapat pada kopi, teh, atau minuman energi dapat meningkatkan stimulasi sistem saraf dan denyut jantung sehingga memicu sensasi panas pada tubuh.

6) Kebiasaan Merokok

Nikotin pada rokok dapat memengaruhi metabolisme estrogen dan sirkulasi darah sehingga perempuan perokok memiliki risiko lebih tinggi mengalami hot flushes yang lebih berat.

7) Konsumsi Alkohol

Alkohol dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah perifer sehingga meningkatkan sensasi panas dan keringat berlebih.

8) Obesitas atau Berat Badan Berlebih

Perempuan dengan berat badan berlebih cenderung lebih sulit melepaskan panas tubuh karena penumpukan jaringan lemak, sehingga keluhan hot flushes dapat terjadi lebih sering.

9) Kurangnya Aktivitas Fisik

Gaya hidup kurang aktif dapat memengaruhi metabolisme tubuh dan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu sehingga gejala menopause lebih mudah muncul.

10) Kelelahan dan Kurang Tidur

11) Kondisi tubuh yang lelah dan kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan sensitivitas sistem saraf terhadap perubahan suhu tubuh.

12) Konsumsi Makanan atau Minuman Panas

Makanan dan minuman dengan suhu tinggi dapat meningkatkan suhu inti tubuh sehingga memicu episode hot flushes.

c. Penatalaksanaan Farmakologis

1) Terapi Hormon (Hormone Therapy / HT)

Terapi hormon merupakan terapi yang paling efektif untuk mengurangi gejala vasomotor pada perempuan menopause, terutama *hot flushes* dan *night sweats*. Terapi ini bekerja dengan menggantikan hormon estrogen yang menurun selama menopause.

2) Jenis terapi hormon; Estrogen saja, Kombinasi estrogen dan progesteron , Estrogen lokal atau sistemik, perlu diperhatikan efek sampingnya. Penggunaan terapi hormon perlu mempertimbangkan risiko seperti: Tromboemboli Kanker payudara Penyakit kardiovaskular Stroke Oleh karena itu, terapi diberikan dengan dosis efektif terendah dan durasi sesingkat mungkin sesuai evaluasi medis

3) Obat Nonhormonal

Pada perempuan yang tidak dapat menggunakan terapi hormon, beberapa obat nonhormonal dapat digunakan untuk membantu mengurangi gejala vasomotor. Yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) (contoh. Paroxetine Fluoxetine. Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) Contoh: Venlafaxine, Gabapentin Digunakan terutama pada perempuan dengan gangguan tidur akibat *night sweats*. Clonidine Membantu mengurangi gejala vasomotor melalui mekanisme pengaturan pembuluh darah.

d. Penatalaksanaan Nonfarmakologis

Pendekatan nonfarmakologis menjadi pilihan penting karena relatif aman, mudah dilakukan, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan menopause secara menyeluruh. Gaya hidup menjadi salah satu faktor resiko terjadinya *hot flushes* merubah gaya hidup sebagai bentuk intervensi diantaranya; Menghindari makanan pedas, Mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, berhenti merokok, menggunakan pakaian yang nyaman, menjaga suhu ruangan tetap sejuk . (Kaunitz & Manson, 2021).

3. Gangguan Tidur pada Masa Menopause

Gangguan tidur merupakan salah satu keluhan yang sering dialami perempuan pada masa perimenopause dan menopause. Kondisi ini dapat berupa sulit memulai tidur, sering terbangun pada malam hari, tidur tidak nyenyak, hingga bangun terlalu dini dan sulit tidur kembali. Gangguan tidur pada masa menopause tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan hormonal, tetapi juga berkaitan dengan perubahan fisik, psikologis, dan lingkungan yang terjadi selama proses penuaan reproduksi. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas tidur perempuan menopause. Estrogen memiliki peran dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, fungsi neurotransmitter otak, dan regulasi tidur. Ketika kadar estrogen menurun, perempuan lebih rentan mengalami gangguan vasomotor seperti *hot flushes* dan *night sweats* yang dapat menyebabkan terbangun berulang kali pada malam hari. Sementara itu, progesteron memiliki efek relaksasi dan sedatif alami sehingga penurunannya dapat menyebabkan kesulitan tidur. Selain faktor hormonal, perubahan psikologis seperti stres, kecemasan, perubahan suasana hati, dan depresi juga berkontribusi terhadap munculnya gangguan tidur pada masa menopause. Perempuan menopause sering mengalami peningkatan sensitivitas emosional sehingga lebih mudah merasa gelisah atau sulit rileks saat akan tidur.

a. Jenis Gangguan Tidur pada Masa Menopause

- 1) *Insomnia* merupakan gangguan tidur yang paling sering terjadi pada perempuan menopause. Kondisi ini ditandai dengan kesulitan memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur dengan kualitas yang buruk.
- 2) *Night Sweats* Keringat malam merupakan bagian dari gejala vasomotor yang dapat menyebabkan perempuan terbangun karena tubuh terasa panas dan berkeringat berlebihan.
- 3) *Sleep Fragmentation* Gangguan ini menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak karena sering terbangun sehingga tubuh tidak mendapatkan istirahat yang optimal.
- 4) *Sleep Apnea* Pada beberapa perempuan menopause, peningkatan berat badan dan perubahan hormonal dapat meningkatkan risiko terjadinya *sleep apnea*, yaitu gangguan napas saat tidur.

b. Dampak Gangguan Tidur pada Masa Menopause

Gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus dapat memberikan berbagai dampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup perempuan menopause, antara lain:

- 1) Mudah lelah dan kurang bertenaga
- 2) Penurunan konsentrasi dan daya ingat
- 3) Mudah marah dan perubahan emosi
- 4) Menurunnya produktivitas kerja
- 5) Gangguan hubungan sosial
- 6) Peningkatan risiko depresi dan kecemasan
- 7) Penurunan kualitas hidup secara keseluruhan

c. Faktor yang Memengaruhi Gangguan Tidur

Beberapa faktor yang dapat memperberat gangguan tidur pada masa menopause meliputi:

- 1) Hot flushes dan keringat malam
- 2) Stres dan kecemasan
- 3) Konsumsi kafein berlebihan
- 4) Kurangnya aktivitas fisik
- 5) Lingkungan tidur yang tidak nyaman
- 6) Obesitas
- 7) Penyakit kronis tertentu
- 8) Penggunaan gadget sebelum tidur

d. Penatalaksanaan Gangguan Tidur Berdasarkan Evidence Based Practice

1) Pendekatan Nonfarmakologis

- a) Sleep Hygiene Perempuan menopause dianjurkan menerapkan kebiasaan tidur yang sehat, seperti: tidur dan bangun pada jam yang sama, Menghindari penggunaan gadget sebelum tidur, Mengurangi konsumsi kafein pada malam hari, menjaga suasana kamar tetap nyaman dan sejuk
- b) Aktivitas Fisik; Olahraga ringan hingga sedang secara rutin dapat membantu tubuh lebih rileks dan meningkatkan kualitas tidur. Latihan aerobik, yoga, dan jalan kaki terbukti membantu memperbaiki kualitas tidur serta mengurangi stres.
- c) Relaksasi; Teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, dan mindfulness dapat membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan. Berbagai studi menunjukkan bahwa relaksasi membantu menurunkan insomnia pada perempuan menopause.
- d) Cognitive Behavioral Therapy (CBT); CBT membantu perempuan mengubah pola pikir dan perilaku yang menyebabkan gangguan tidur. CBT merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang direkomendasikan untuk insomnia pada menopause.

2) Pendekatan Farmakologis

- a) Terapi Hormon; Terapi estrogen dapat membantu mengurangi hot flashes dan memperbaiki kualitas tidur pada perempuan dengan gejala menopause sedang hingga berat.
- b) Obat Tidur Pada kondisi tertentu, dokter dapat memberikan obat tidur dalam jangka pendek sesuai indikasi medis.
- c) Antidepresan Tertentu Beberapa obat golongan SSRI atau SNRI dapat membantu mengurangi gangguan tidur yang berkaitan dengan gejala vasomotor dan kecemasan Pinkerton, & Stovall, 2022)

e. Peran Bidan dalam Asuhan Gangguan Tidur pada Menopause

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada perempuan menopause terkait:

- 1) Penerapan pola hidup sehat
- 2) Manajemen stres
- 3) Konseling menopause
- 4) Deteksi dini gangguan tidur
- 5) Edukasi sleep hygiene
- 6) Rujukan bila diperlukan

Pendekatan asuhan yang holistik dan berbasis evidence based practice dapat membantu perempuan menopause beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sehingga kualitas hidup tetap optimal.

4. Perubahan Psikologis dan Emosional

a. Bentuk Perubahan Psikologis dan Emosional pada Menopause

- 1) Mood Swing; *Mood swing* merupakan perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat dan tidak stabil. Perempuan menopause dapat merasa sedih, mudah marah, sensitif, atau emosional tanpa penyebab yang jelas.
- 2) Mekanisme: Penurunan hormon estrogen memengaruhi kestabilan neurotransmitter di otak sehingga regulasi emosi menjadi terganggu.
- 3) Kecemasan (*Anxiety*); Sebagian perempuan menopause mengalami rasa cemas berlebihan terhadap kondisi kesehatan, perubahan tubuh, maupun masa depan. Kecemasan dapat disertai gejala seperti jantung berdebar, sulit rileks, dan gangguan tidur.
- 4) Faktor pencetus: Hot flushes, Gangguan tidur , Perubahan peran sosial, Kekhawatiran terhadap penuaan
- 5) Depresi Pada beberapa perempuan, menopause dapat meningkatkan risiko depresi ringan hingga sedang. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas, mudah lelah, dan penurunan motivasi. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat depresi sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan depresi selama menopause.
- 6) Mudah Marah dan Sensitif, perubahan hormonal dapat menyebabkan perempuan menjadi lebih mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi. Kondisi ini sering dipengaruhi oleh kelelahan dan kurang tidur.
- 7) Penurunan Konsentrasi dan Daya Ingat, beberapa perempuan menopause mengeluhkan sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan penurunan kemampuan fokus.
- 8) Penurunan Kepercayaan Diri; Perubahan fisik seperti kenaikan berat badan, kulit menua, dan perubahan fungsi seksual dapat memengaruhi citra diri perempuan menopause sehingga menurunkan rasa percaya diri.

b. Faktor yang Memengaruhi Perubahan Psikologis pada Menopause

Beberapa faktor yang dapat memperberat perubahan psikologis dan emosional antara lain:

- 1) Perubahan hormonal
- 2) Gangguan tidur
- 3) Stres berkepanjangan
- 4) Kurangnya dukungan keluarga

- 5) Masalah ekonomi atau pekerjaan
 - 6) Penyakit kronis
 - 7) Kurangnya aktivitas fisik
 - 8) Isolasi sosial
- c. Dampak terhadap Kualitas Hidup
- Perubahan psikologis dan emosional pada menopause dapat berdampak terhadap:
- 1) Hubungan keluarga dan pasangan
 - 2) Aktivitas sosial
 - 3) Produktivitas kerja
 - 4) Kesehatan mental
 - 5) Kualitas tidur
 - 6) Kesejahteraan emosional
- Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup perempuan menopause secara menyeluruh.
- d. Penatalaksanaan
- 1) Pendekatan Nonfarmakologis
 - a) Edukasi dan Konseling, Pemberian informasi mengenai menopause membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi sehingga lebih mampu beradaptasi secara emosional.
 - b) Evidence Based: Konseling menopause terbukti membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan psikologis perempuan menopause.
 - c) Dukungan Keluarga dan Sosial Dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial membantu perempuan merasa lebih dihargai dan tidak sendirian dalam menghadapi menopause.
 - d) Aktivitas Fisik Olahraga teratur membantu meningkatkan produksi endorfin sehingga suasana hati menjadi lebih baik. Yoga, senam, dan aktivitas aerobik ringan terbukti membantu mengurangi stres dan depresi ringan pada perempuan menopause.
 - e) Teknik Relaksasi Meditasi, mindfulness, dan latihan pernapasan membantu menurunkan ketegangan emosional.
 - f) Cognitive Behavioral Therapy (CBT) CBT membantu perempuan mengelola pikiran negatif dan meningkatkan kemampuan adaptasi psikologis. CBT efektif membantu mengurangi kecemasan dan gangguan mood pada perempuan menopause.

2) Pendekatan Farmakologis

Pada kondisi tertentu, terapi medis dapat diberikan sesuai indikasi, antara lain: Terapi hormon , Antidepresan, Obat antiansietas. Penggunaan obat harus berdasarkan evaluasi tenaga kesehatan dan mempertimbangkan manfaat serta risiko terapi.

e. Peran Bidan dalam Asuhan Psikologis Menopause

Bidan memiliki peran penting dalam:

- 1) Memberikan edukasi kesehatan
- 2) Melakukan konseling menopause
- 3) Mengidentifikasi gangguan psikologis sejak dini
- 4) Memberikan dukungan emosional
- 5) Mendorong pola hidup sehat
- 6) Melakukan rujukan bila diperlukan

Pendekatan yang empatik, komunikatif, dan woman centered care sangat penting untuk membantu perempuan menopause menjalani masa transisi dengan lebih sehat dan berkualitas.

f. Penurunan Libido dan Gangguan Seksual

Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya fungsi reproduksi akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron. Perubahan hormonal tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan seksual perempuan. Salah satu keluhan yang sering muncul pada masa menopause adalah penurunan libido dan gangguan fungsi seksual yang dapat memengaruhi kualitas hidup serta hubungan dengan pasangan. Penurunan libido pada perempuan menopause merupakan kondisi berkurangnya keinginan atau minat terhadap aktivitas seksual. Sementara itu, gangguan seksual mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan gairah seksual, respons seksual, kenyamanan saat berhubungan, hingga kepuasan seksual. Kondisi ini dapat terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, maupun hubungan interpersonal.

1) Mekanisme Terjadinya Penurunan Libido pada Menopause

Penurunan kadar estrogen selama menopause menyebabkan perubahan pada organ reproduksi perempuan. Estrogen berperan penting dalam menjaga elastisitas vagina, kelembapan jaringan, dan aliran darah ke organ genital. Ketika kadar estrogen menurun, jaringan vagina menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis sehingga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual.

Selain estrogen, penurunan hormon androgen seperti testosteron juga berpengaruh terhadap menurunnya gairah seksual perempuan. Hormon androgen memiliki peran dalam mempertahankan libido, energi, dan respons seksual.

Perubahan hormonal juga memengaruhi neurotransmitter di otak yang berhubungan dengan suasana hati dan respons seksual. Akibatnya, perempuan menopause dapat mengalami penurunan minat seksual, kesulitan mencapai orgasme, atau berkurangnya kepuasan seksual.

2) Bentuk Gangguan Seksual pada Masa Menopause

- a) Penurunan Libido; Perempuan menopause sering mengalami penurunan hasrat seksual akibat perubahan hormonal, kelelahan, stres, dan perubahan emosional.
- b) Vaginal Dryness; Penurunan estrogen menyebabkan produksi cairan pelumas alami vagina berkurang sehingga vagina terasa kering yang berdampak pada; Rasa tidak nyaman, Nyeri saat hubungan seksual, Iritasi vagina
- c) Dispareunia; Dispareunia adalah nyeri saat berhubungan seksual yang sering terjadi akibat kekeringan dan penipisan dinding vagina. Penelitian menunjukkan bahwa atrofi vagina pada menopause merupakan penyebab utama nyeri seksual pada perempuan menopause
- d) Penurunan Respons Seksual; Sebagian perempuan mengalami kesulitan mencapai orgasme atau penurunan sensitivitas seksual.
- e) Gangguan Psikologis Terkait Seksualitas; Perubahan citra tubuh, rasa tidak percaya diri, kecemasan, dan stres dapat memengaruhi hubungan intim dengan pasangan.

3) Faktor yang Memengaruhi Gangguan Seksual pada Menopause

Beberapa faktor yang dapat memperberat gangguan seksual antara lain:

- a) Penurunan hormon estrogen dan androgen
- b) Gangguan tidur
- c) Stres dan depresi
- d) Hubungan dengan pasangan
- e) Penyakit kronis
- f) Penggunaan obat tertentu
- g) Kurangnya komunikasi dengan pasangan
- h) Kelelahan fisik
- i) Penurunan kepercayaan diri

Gangguan seksual pada masa menopause dapat berdampak terhadap:

- a) Keharmonisan hubungan pasangan
- b) Kesehatan psikologis perempuan
- c) Rasa percaya diri
- d) Kepuasan hidup
- e) Kualitas hubungan interpersonal

Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan stres emosional dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

4) Penatalaksanaan

a) Pendekatan Nonfarmakologis

- Edukasi dan Konseling Seksual Pendidikan kesehatan membantu perempuan memahami perubahan seksual yang terjadi selama menopause sehingga mampu beradaptasi secara positif. Konseling seksual terbukti membantu meningkatkan komunikasi pasangan dan kualitas hubungan seksual.
- Komunikasi dengan Pasangan Komunikasi terbuka membantu pasangan memahami perubahan yang dialami perempuan menopause dan meningkatkan dukungan emosional.
- Aktivitas Fisik Olahraga teratur membantu meningkatkan aliran darah, kebugaran tubuh, dan suasana hati. Aktivitas fisik rutin dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seksual perempuan menopause.
- Teknik Relaksasi dan Manajemen Stres

Stres yang berlebihan dapat menurunkan libido sehingga teknik relaksasi membantu perempuan lebih rileks dan nyaman

b) Pendekatan Farmakologis

- Pelumas dan Pelembap Vagina Pelumas berbahan dasar air digunakan untuk mengurangi kekeringan vagina dan nyeri saat berhubungan seksual. Penggunaan pelumas vagina terbukti efektif meningkatkan kenyamanan seksual perempuan menopause.
- Terapi Estrogen Lokal Terapi estrogen lokal membantu memperbaiki kelembapan dan elastisitas jaringan vagina. Estrogen vaginal efektif mengurangi atrofi vagina dan dispareunia pada perempuan menopause.
- Terapi Hormon Sistemik Pada perempuan dengan gejala menopause sedang hingga berat, terapi hormon dapat membantu memperbaiki gejala vasomotor dan fungsi seksual. Penggunaan terapi hormon

harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta dilakukan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

5) Peran Bidan dalam Asuhan Seksualitas Menopause

Bidan memiliki peran penting dalam membantu perempuan menopause menghadapi perubahan seksual melalui:

- a) Edukasi kesehatan reproduksi
- b) Konseling seksual
- c) Dukungan emosional
- d) Promosi komunikasi pasangan
- e) Identifikasi gangguan seksual
- f) Rujukan bila diperlukan

Pendekatan yang empatik, terbuka, dan berbasis *woman centered care* sangat penting agar perempuan menopause merasa nyaman dalam mendiskusikan masalah seksual yang dialami sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan reproduksi dapat tetap terjaga.

5. Osteoporosis

Osteoporosis merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada perempuan setelah menopause. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya kepadatan dan kualitas tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah mengalami patah tulang. Osteoporosis berkembang secara perlahan dan sering disebut sebagai *silent disease* karena pada tahap awal umumnya tidak menimbulkan gejala yang khas.

Perempuan menopause memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki karena adanya penurunan hormon estrogen secara signifikan setelah menopause. Estrogen berperan penting dalam menjaga keseimbangan proses pembentukan dan penghancuran tulang. Ketika kadar estrogen menurun, proses resorpsi tulang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan tulang baru sehingga massa tulang berkurang secara bertahap.

a. Mekanisme Terjadinya Osteoporosis pada Menopause

Tulang merupakan jaringan hidup yang terus mengalami proses remodeling, yaitu pembentukan tulang baru oleh osteoblas dan penghancuran tulang lama oleh osteoklas. Pada kondisi normal, kedua proses tersebut berlangsung seimbang.

Pada masa menopause, penurunan kadar estrogen menyebabkan aktivitas osteoklas meningkat sehingga penghancuran tulang berlangsung lebih cepat. Sementara itu, pembentukan tulang baru tidak mampu menggantikan kehilangan massa tulang yang terjadi. Akibatnya, kepadatan tulang menurun dan struktur tulang menjadi lebih rapuh.

Selain memengaruhi metabolisme tulang, penurunan estrogen juga mengurangi penyerapan kalsium di usus dan meningkatkan pengeluaran kalsium melalui ginjal. Kondisi ini semakin mempercepat terjadinya osteoporosis pada perempuan menopause.

b. Faktor Risiko Osteoporosis pada Perempuan Menopause

- 1) Penurunan Hormon Estrogen; Penurunan estrogen merupakan faktor utama yang menyebabkan hilangnya massa tulang pada perempuan menopause.
- 2) Usia; Semakin bertambah usia, proses pembentukan tulang semakin menurun sehingga risiko osteoporosis meningkat.
- 3) Riwayat Keluarga; Perempuan dengan riwayat keluarga osteoporosis memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa.
- 4) Kurangnya Asupan Kalsium dan Vitamin D; Kalsium dan vitamin D sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan nutrisi tersebut dapat mempercepat penurunan kepadatan tulang.
- 5) Kurangnya Aktivitas Fisik; Kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan beban (*weight-bearing exercise*), dapat menyebabkan tulang kehilangan kekuatan.
- 6) Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Alkohol; Merokok dan alkohol dapat mengganggu metabolisme tulang dan mempercepat kehilangan massa tulang.
- 7) Berat Badan Rendah; Perempuan dengan indeks massa tubuh rendah cenderung memiliki massa tulang yang lebih sedikit sehingga lebih rentan mengalami osteoporosis.
- 8) Penyakit Kronis dan Penggunaan Obat Tertentu; Beberapa penyakit dan penggunaan obat jangka panjang, seperti kortikosteroid, dapat meningkatkan risiko osteoporosis.

c. Gejala Osteoporosis; Pada tahap awal, osteoporosis sering tidak menimbulkan gejala. Namun, ketika kondisi semakin berat, dapat muncul keluhan seperti:

- 1) Nyeri punggung
- 2) Penurunan tinggi badan
- 3) Postur tubuh membungkuk (*kyphosis*)
- 4) Tulang mudah patah
- 5) Nyeri tulang dan sendi

Patah tulang akibat osteoporosis paling sering terjadi pada tulang belakang, pergelangan tangan, dan panggul

d. Pencegahan Osteoporosis Berdasarkan Evidence Based Practice

- 1) Konsumsi Kalsium dan Vitamin D, Kalsium membantu mempertahankan kekuatan tulang, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kalsium dan vitamin D yang cukup membantu memperlambat penurunan massa tulang pada perempuan menopause.
- 2) Aktivitas Fisik dan Olahraga; Olahraga secara rutin membantu meningkatkan kepadatan tulang dan kekuatan otot.
- 3) Jenis olahraga: Jalan kaki, Senam , Naik tangga, Latihan beban ringan *Weight-bearing exercise* terbukti membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko fraktur.
- 4) Menghindari Rokok dan Alkohol
- 5) Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol membantu menjaga kesehatan tulang.
- 6) Menjaga Berat Badan Ideal; Berat badan yang seimbang membantu mempertahankan kekuatan tulang dan mencegah kehilangan massa tulang berlebihan.
- 7) Paparan Sinar Matahari; Paparan sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D alami dalam tubuh.

e. Penatalaksanaan Osteoporosis

- 1) Pendekatan Nonfarmakologis
 - a) Edukasi kesehatan
 - b) Aktivitas fisik rutin
 - c) Nutrisi seimbang
 - d) Pencegahan jatuh
 - e) Modifikasi lingkungan rumah
- 2) Pendekatan Farmakologi
 - a) Suplemen Kalsium dan Vitamin D; Digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tulang.
 - b) Terapi Hormon; Terapi estrogen dapat membantu mempertahankan massa tulang pada perempuan menopause tertentu.
 - c) Bisfosfonat; Obat ini membantu menghambat proses penghancuran tulang.
 - d) Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs); Membantu mempertahankan kepadatan tulang dengan efek menyerupai estrogen pada jaringan tulang. Pedoman internasional menyatakan bahwa terapi osteoporosis dapat membantu menurunkan risiko fraktur pada perempuan menopause dengan risiko tinggi.

e) Peran Bidan dalam Pencegahan Osteoporosis

Bidan memiliki peran penting dalam:

- Edukasi kesehatan tulang
- Konseling nutrisi
- Promosi aktivitas fisik
- Skrining faktor risiko osteoporosis
- Deteksi dini keluhan muskuloskeletal
- Rujukan bila diperlukan

Pendekatan promotif dan preventif sangat penting untuk membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan tulang serta meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut.

6. Peningkatan Risiko Penyakit Kardiovaskular

a. Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Perempuan Menopause.

Masa menopause merupakan periode transisi yang tidak hanya memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga berdampak terhadap sistem kardiovaskular. Setelah menopause, risiko terjadinya penyakit kardiovaskular cenderung meningkat akibat perubahan hormonal, metabolisme tubuh, dan faktor gaya hidup. Penyakit kardiovaskular meliputi hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, aterosklerosis, dan gangguan pembuluh darah lainnya. Sebelum menopause, hormon estrogen memiliki efek protektif terhadap jantung dan pembuluh darah. Estrogen membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, mengontrol metabolisme lemak, meningkatkan kadar kolesterol baik (*High Density Lipoprotein/HDL*), serta menurunkan kadar kolesterol jahat (*Low Density Lipoprotein/LDL*). Namun, ketika menopause terjadi, kadar estrogen menurun secara signifikan sehingga perlindungan alami terhadap sistem kardiovaskular ikut berkurang.

b. Mekanisme Peningkatan Risiko Kardiovaskular pada Menopause Penurunan hormon estrogen menyebabkan berbagai perubahan metabolik dan vaskular yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Perubahan Profil Lipid Setelah menopause, kadar kolesterol LDL dan trigliserida cenderung meningkat, sedangkan kadar HDL menurun. Kondisi ini dapat mempercepat pembentukan plak aterosklerosis pada pembuluh darah. Penurunan Elastisitas Pembuluh Darah Estrogen membantu menjaga elastisitas dinding pembuluh darah. Ketika kadar estrogen menurun, pembuluh darah menjadi lebih kaku sehingga tekanan darah lebih mudah meningkat. Peningkatan Lemak Visceral Perempuan menopause cenderung mengalami penumpukan lemak di area abdomen (*obesitas sentral*). Kondisi ini

berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung koroner.

7. Gangguan Metabolisme Glukosa

Perubahan hormonal dapat menyebabkan resistensi insulin sehingga meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2 yang merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular.

a. Proses Inflamasi dan Aterosklerosis

estrogen dapat meningkatkan proses inflamasi kronis yang berperan dalam pembentukan plak pada pembuluh darah.

b. Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Perempuan Menopause

- 1) Usia; Risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia.
- 2) Hipertensi; Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular pada perempuan menopause.
- 3) Dislipidemia; Kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi meningkatkan risiko aterosklerosis.
- 4) Diabetes Melitus; Gangguan metabolisme glukosa dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah.
- 5) Obesitas; Kelebihan berat badan, terutama obesitas sentral, meningkatkan risiko penyakit jantung.
- 6) Kurangnya Aktivitas Fisik; Gaya hidup sedentari dapat memperburuk kesehatan jantung dan metabolisme tubuh.
- 7) Merokok; Merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner serta stroke.
- 8) Stres; Stres berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah dan memengaruhi kesehatan jantung.
- 9) Riwayat Keluarga; Riwayat penyakit jantung dalam keluarga dapat meningkatkan risiko pada perempuan menopause.

c. Gejala Penyakit Kardiovaskular pada Perempuan Menopause

Gejala penyakit kardiovaskular pada perempuan sering kali tidak khas sehingga perlu kewaspadaan dalam deteksi dini. Beberapa gejala yang dapat muncul meliputi:

- 1) Nyeri dada
- 2) Sesak napas
- 3) Mudah lelah
- 4) Jantung berdebar
- 5) Pusing
- 6) Pembengkakan tungkai
- 7) Tekanan darah meningkat

Pada beberapa perempuan, gejala dapat muncul ringan atau menyerupai gangguan pencernaan sehingga sering terlambat dikenali.

d. Penanganan

1) Pola Makan Sehat

Perempuan menopause dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat. Diet sehat seperti *Mediterranean diet* terbukti membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

a) Aktivitas Fisik Teratur; Olahraga membantu menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, dan metabolisme tubuh.

b) Jenis aktivitas:

- Jalan kaki
- Senam
- Bersepeda
- Yoga

c) Aktivitas fisik rutin terbukti menurunkan risiko hipertensi dan penyakit jantung koroner.

d) Menjaga Berat Badan Ideal; Pengendalian berat badan membantu mengurangi risiko hipertensi dan diabetes.

e) Berhenti Merokok dan Membatasi Alkohol; Menghindari rokok dan alkohol membantu menjaga fungsi pembuluh darah dan kesehatan jantung.

f) Manajemen Stres; Teknik relaksasi dan dukungan psikologis membantu mengurangi dampak stres terhadap sistem kardiovaskular.

g) Pemeriksaan Kesehatan Berkala; Skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol penting dilakukan untuk deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko terbukti membantu menurunkan angka komplikasi penyakit kardiovaskular.

e. Penatalaksanaan

1) Nonfarmakologis

a) Edukasi kesehatan

b) Diet sehat

c) Aktivitas fisik

d) Pengendalian stres

e) Modifikasi gaya hidup

2) Farmakologis; Terapi medis diberikan sesuai kondisi dan faktor risiko, seperti: Obat antihipertensi, Obat penurun kolesterol, Antidiabetik, Terapi hormon pada indikasi tertentu. Penggunaan terapi harus berdasarkan

evaluasi tenaga kesehatan dan mempertimbangkan manfaat serta risiko terapi.

3) Peran Bidan dalam Pencegahan Penyakit Kardiovaskular

Bidan memiliki peran penting dalam:

- a) Edukasi kesehatan menopause
- b) Promosi gaya hidup sehat
- c) Skrining faktor risiko
- d) Konseling nutrisi
- e) Pemantauan tekanan darah dan berat badan
- f) Rujukan bila diperlukan

Pendekatan preventif dan woman centered care sangat penting untuk membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut.

8. Gangguan Metabolik dan Kenaikan Berat Badan

Gangguan metabolik dan kenaikan berat badan merupakan keluhan yang sering dialami perempuan pada masa menopause. Kondisi ini terjadi akibat perubahan hormonal, penurunan aktivitas metabolisme tubuh, serta perubahan komposisi lemak dan massa otot. Setelah menopause, perempuan cenderung mengalami peningkatan berat badan, terutama penumpukan lemak di area perut (*obesitas sentral*), yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif.

Penurunan hormon estrogen memiliki peran penting dalam perubahan metabolisme tubuh pada masa menopause. Estrogen berfungsi membantu mengatur distribusi lemak tubuh, sensitivitas insulin, metabolisme glukosa, serta penggunaan energi. Ketika kadar estrogen menurun, tubuh lebih mudah menyimpan lemak dan mengalami perubahan metabolik yang dapat berdampak terhadap kesehatan jangka panjang.

a. Mekanisme Gangguan Metabolik pada Menopause

- 1) Penurunan Hormon Estrogen Penurunan estrogen menyebabkan perubahan distribusi lemak tubuh dari area pinggul dan paha menuju area abdomen. Kondisi ini meningkatkan risiko obesitas sentral yang berhubungan dengan penyakit metabolik dan kardiovaskular.
- 2) Penurunan Laju Metabolisme; Seiring bertambahnya usia dan menopause, metabolisme basal tubuh menurun sehingga pembakaran kalori menjadi lebih lambat. Akibatnya, berat badan lebih mudah meningkat meskipun pola makan tidak banyak berubah.
- 3) Penurunan Massa Otot; Perempuan menopause cenderung mengalami penurunan massa otot (*sarcopenia*). Massa otot yang berkurang

menyebabkan kebutuhan energi tubuh menurun sehingga kalori lebih mudah disimpan sebagai lemak.

- 4) Resistensi Insulin; Perubahan hormonal dapat memengaruhi sensitivitas insulin sehingga tubuh mengalami kesulitan menggunakan glukosa secara optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko diabetes melitus tipe
- 5) Perubahan Profil Lipid; Setelah menopause, kadar kolesterol LDL dan trigliserida cenderung meningkat, sedangkan HDL menurun. Kondisi ini meningkatkan risiko sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular.

b. Faktor Risiko Gangguan Metabolik dan Kenaikan Berat Badan

Beberapa faktor yang dapat memperberat gangguan metabolik pada perempuan menopause meliputi:

- 1) Kurangnya aktivitas fisik
- 2) Pola makan tinggi lemak dan gula
- 3) Stres berkepanjangan
- 4) Gangguan tidur
- 5) Riwayat keluarga obesitas atau diabetes
- 6) Kebiasaan merokok
- 7) Konsumsi alkohol berlebihan
- 8) Peningkatan usia

c. Dampak Gangguan Metabolik pada Perempuan Menopause Gangguan metabolik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, antara lain; Obesitas Sentral Penumpukan lemak di area perut meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Resistensi insulin yang terjadi pada menopause dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Kelebihan berat badan dan perubahan metabolik dapat meningkatkan tekanan darah. Dislipidemia. Gangguan metabolisme lemak meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Penyakit Kardiovaskular Gangguan metabolik merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner dan stroke. Kenaikan berat badan dapat memengaruhi mobilitas, kepercayaan diri, kesehatan mental, dan aktivitas sehari-hari perempuan menopause.

d. Pencegahan dan Penatalaksanaan Berdasarkan Evidence Based Practice

- 1) Pendekatan Nonfarmakologis
 - a) Pola Makan Sehat; Perempuan menopause dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan: Tinggi serat, Rendah lemak jenuh, Mengurangi gula sederhana, Memperbanyak buah dan sayur, Cukup protein. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan sehat seperti Mediterranean diet membantu mengontrol berat badan dan memperbaiki metabolisme tubuh.

- b) Aktivitas Fisik dan Olahraga Olahraga membantu meningkatkan pembakaran kalori, mempertahankan massa otot, dan memperbaiki sensitivitas insulin. Jenis olahraga: Jalan kaki , Senam aerobik, Yoga Latihan kekuatan otot. Aktivitas fisik rutin terbukti membantu mengurangi obesitas sentral dan menurunkan risiko sindrom metabolik pada perempuan menopause.
- c) Manajemen Stres Stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang berhubungan dengan penumpukan lemak tubuh. Teknik relaksasi dan mindfulness membantu memperbaiki keseimbangan psikologis dan mendukung pengendalian berat badan.
- d) Sleep Hygiene Tidur yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme tubuh.
- e) si Gaya Hidup Sehat Pendidikan kesehatan membantu perempuan memahami pentingnya pola hidup sehat selama menopause.

e. Pendekatan Farmakologis

Pada kondisi tertentu, terapi medis dapat diberikan sesuai indikasi tenaga kesehatan, antara lain: obat penurun gula darah , obat penurun kolesterol , obat antihipertensi, terapi hormon pada kondisi tertentu. penggunaan terapi harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta dilakukan sesuai evaluasi medis.

f. Peran Bidan dalam Pencegahan Gangguan Metabolik

Bidan memiliki peran penting dalam:

- 1) Edukasi nutrisi menopause
- 2) Pemantauan berat badan dan indeks massa tubuh
- 3) Promosi aktivitas fisik
- 4) Konseling gaya hidup sehat
- 5) Deteksi dini faktor risiko metabolik
- 6) Rujukan bila diperlukan

Pendekatan promotif dan preventif berbasis evidence based practice sangat penting untuk membantu perempuan menopause mempertahankan kesehatan metabolik, mencegah komplikasi penyakit degeneratif, dan meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut.

9. Inkontinensia Urin dan Gangguan Sistem Urogenital

Inkontinensia urin dan gangguan sistem urogenital merupakan masalah kesehatan yang sering dialami perempuan pada masa menopause akibat perubahan hormonal, terutama penurunan kadar estrogen. Kondisi ini dapat memengaruhi fungsi saluran kemih, organ reproduksi, serta kualitas hidup perempuan secara fisik, psikologis, dan sosial. Banyak perempuan menopause

merasa malu atau enggan membicarakan keluhan tersebut sehingga penanganannya sering terlambat dilakukan. Penurunan hormon estrogen selama menopause menyebabkan perubahan struktur dan fungsi jaringan pada sistem urogenital. Estrogen berperan dalam menjaga elastisitas, kelembapan, ketebalan mukosa, serta kekuatan otot dasar panggul. Ketika kadar estrogen menurun, jaringan menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis sehingga fungsi kandung kemih dan organ genital dapat terganggu.

a. Mekanisme Terjadinya Gangguan Urogenital pada Menopause

Penurunan estrogen menyebabkan atrofi atau penipisan jaringan pada vagina, uretra, dan kandung kemih. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya aliran darah, penurunan produksi cairan pelumas, serta melemahnya jaringan penyangga organ panggul. Selain itu, kelemahan otot dasar panggul dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menahan urin sehingga perempuan lebih mudah mengalami kebocoran urin. Proses penuaan, persalinan berulang, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik juga dapat memperburuk kondisi tersebut.

1) Jenis Inkontinensia Urin

- a) Stress Urinary Incontinence; Kebocoran urin terjadi saat tekanan dalam perut meningkat, misalnya ketika batuk, bersin, tertawa, atau mengangkat beban. Kelemahan otot dasar panggul dan sfingter uretra menyebabkan urin mudah keluar saat terjadi tekanan
- b) Urge Incontinence; Perempuan merasakan dorongan berkemih yang sangat kuat dan sulit ditahan sehingga urin keluar sebelum mencapai toilet. Kontraksi kandung kemih yang berlebihan menyebabkan keinginan berkemih muncul secara tiba-tiba.
- c) Mixed Incontinence; Merupakan kombinasi antara stress urinary incontinence dan urge incontinence.

2) Gangguan Sistem Genital pada Menopause

- a) Vaginal Dryness; Penurunan estrogen menyebabkan vagina menjadi lebih kering akibat berkurangnya produksi cairan pelumas alami yang menyebabkan: Rasa tidak nyaman, Gatal, Nyeri saat hubungan seksual
- b) Atrofi Vagina; Dinding vagina menjadi lebih tipis, rapuh, dan kurang elastis. Atrofi vagina merupakan salah satu gangguan urogenital yang paling sering ditemukan pada perempuan menopause.
- c) Dispareunia Dispareunia adalah nyeri saat berhubungan seksual akibat kekeringan dan penipisan jaringan vagina.

- d) Infeksi Saluran Kemih Berulang: Perubahan pH vagina dan penurunan flora normal meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pada perempuan menopause.
- b. Faktor Risiko
- Beberapa faktor yang meningkatkan risiko inkontinensia urin dan gangguan urogenital meliputi:
- 1) Penurunan hormon estrogen
 - 2) Persalinan pervaginam berulang
 - 3) Obesitas
 - 4) Peningkatan usia
 - 5) Batuk kronis
 - 6) Konstipasi
 - 7) Kurangnya aktivitas fisik
 - 8) Riwayat operasi panggul
- c. Dampak terhadap Kualitas Hidup, gangguan urogenital dapat menyebabkan: Rasa malu dan rendah diri, Gangguan aktivitas sosial, Penurunan kualitas hubungan seksual, Gangguan psikologis, Keterbatasan aktivitas fisik, Penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, Sebagian perempuan juga mengalami kecemasan karena takut terjadi kebocoran urin saat beraktivitas di luar rumah.
- d. Penatalaksanaan
- 1) Pendekatan Nonfarmakologis
 - a) Pelvic Floor Muscle Exercise (Senam Kegel); Senam Kegel membantu memperkuat otot dasar panggul sehingga meningkatkan kemampuan menahan urin. Penelitian menunjukkan bahwa latihan otot dasar panggul efektif mengurangi inkontinensia urin ringan hingga sedang pada perempuan menopause.
 - b) Bladder Training, latihan kandung kemih dilakukan dengan mengatur jadwal berkemih secara teratur untuk meningkatkan kontrol kandung kemih.
 - c) Modifikasi Gaya Hidup, meliputi: Menurunkan berat badan, Mengurangi konsumsi kafein, Berhenti merokok „Menghindari konstipasi, Aktivitas fisik teratur, Perubahan gaya hidup membantu mengurangi gejala inkontinensia urin dan meningkatkan kesehatan panggul.
 - d) Edukasi Personal Hygiene, Menjaga kebersihan area genital membantu mencegah iritasi dan infeksi saluran kemih.

2) Pendekatan Farmakologis

- a) Estrogen Lokal Terapi estrogen vaginal membantu memperbaiki kelembapan, elastisitas jaringan, dan kesehatan uretra. Estrogen lokal terbukti membantu mengurangi atrofi vagina dan gejala gangguan urogenital pada perempuan menopause.
- b) Obat Antimuskarini, Digunakan untuk mengurangi kontraksi kandung kemih berlebihan pada urge incontinence.
- c) Pelumas dan Pelembap Vagina, Membantu mengurangi kekeringan vagina dan meningkatkan kenyamanan seksual.

3) Peran Bidan dalam Asuhan Urogenital Menopause, Bidan memiliki peran penting dalam:

- a) Edukasi kesehatan reproduksi menopause
- b) Deteksi dini inkontinensia urin
- c) Mengajarkan senam Kegel
- d) Konseling personal hygiene
- e) Dukungan psikologis
- f) Promosi gaya hidup sehat
- g) Rujukan bila diperlukan

Pendekatan woman centered care dan komunikasi yang empatik sangat penting agar perempuan menopause merasa nyaman menyampaikan keluhan yang dialami sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan kualitas hidup tetap terjaga. Bidan berperan sebagai edukator dengan memberikan informasi mengenai perubahan fisiologis yang terjadi selama menopause, termasuk gejala vasomotor, gangguan tidur, perubahan emosional, gangguan seksual, osteoporosis, serta risiko penyakit degeneratif. Edukasi kesehatan membantu perempuan memahami bahwa menopause merupakan proses alami sehingga dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang dialami. Pendekatan asuhan menopause yang berbasis *evidence based practice* sangat penting dalam praktik kebidanan modern. Dengan penggunaan intervensi yang didukung bukti ilmiah, bidan dapat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas sehingga perempuan menopause mampu menjalani masa transisi kehidupannya secara sehat, mandiri, dan produktif.

D. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Management of menopausal symptoms*. ACOG Practice Bulletin.

- Baber, R. J., Panay, N., & Fenton, A. (2022). 2022 IMS recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy. *Climacteric*, 25(6), 573–590.
- Berek, J. S. (2021). *Berek & Novak's gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- Dalal, P. K., & Agarwal, M. (2020). Postmenopausal syndrome. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(3), 222–232.
- Faubion, S. S., Larkin, L. C., & Stuenkel, C. A. (2023). Management of menopause symptoms. *Mayo Clinic Proceedings*, 98(4), 745–760.
- Greendale, G. A., & Gold, E. B. (2021). Lifestyle factors and menopause. *The Lancet Healthy Longevity*, 2(8), e486–e495.
- Harlow, S. D., Gass, M., Hall, J. E., et al. (2022). Executive summary of the stages of reproductive aging workshop. *Menopause*, 29(5), 543–552.
- Kaunitz, A. M., & Manson, J. E. (2021). Management of menopausal symptoms. *Obstetrics & Gynecology*, 137(5), 859–876.
- Kim, H. K., & Park, H. Y. (2023). Sleep disturbances in menopausal women. *Journal of Women's Health*, 32(2), 140–148.
- Lobo, R. A. (2021). *Treatment of the postmenopausal woman: Basic and clinical aspects* (4th ed.). Elsevier.
- Manson, J. E., & Kaunitz, A. M. (2022). Menopause management—Getting clinical care back on track. *New England Journal of Medicine*, 386(16), 1497–1501.
- Monteleone, P., Mascagni, G., Giannini, A., Genazzani, A. R., & Simoncini, T. (2021). Symptoms of menopause. *Journal of Endocrinological Investigation*, 44(11), 2299–2315.
- North American Menopause Society. (2023). *The 2023 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society*. Menopause Journal.
- Panay, N., Briggs, P., & Kovacs, G. (2020). *Managing the menopause*. Cambridge University Press.
- Pinkerton, J. V., & Stovall, D. W. (2022). Menopause and quality of life. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 49(3), 421–438.
- Santoro, N., & Epperson, C. N. (2021). Menopausal symptoms and their management. *Endocrinology and Metabolism Clinics*, 50(3), 495–512.

- Shifren, J. L., & Gass, M. L. S. (2021). The North American Menopause Society recommendations. *Menopause*, 28(9), 973–997.
- Simon, J. A., Kaunitz, A. M., & Andrews, M. C. (2022). Vasomotor symptoms during menopause. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 107(4), 1023–1034.
- Stevenson, J. C., Hodis, H. N., & Pickar, J. H. (2021). Cardiovascular health and menopause. *Climacteric*, 24(4), 339–347.
- Thurston, R. C., & Joffe, H. (2021). Vasomotor symptoms and menopause. *The Lancet*, 397(10274), 849–861.
- Utian, W. H. (2020). *Principles and practice of menopause management*. Springer.
- World Health Organization. (2022). *Women ageing and health report*. WHO Press.
- Yusuf, S., Joseph, P., & Rangarajan, S. (2020). Modifiable risk factors in women's cardiovascular health. *The Lancet*, 395(10226), 795–808.
- Zhu, D., Chung, H. F., Pandeya, N., et al. (2021). Body mass index and age at natural menopause. *Human Reproduction*, 36(8), 2218–2227.
- Zimmermann, C., & Eijkemans, M. J. (2023). Metabolic syndrome in postmenopausal women. *Menopause Review*, 22(1), 15–24.

CHAPTER 4

EDUKASI GAYA HIDUP SEHAT, NUTRISI DAN AKTIVITAS FISIK

Prassanti Widya Pravitasari, S.Tr,Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Perimenopause dan menopause merupakan fase alami dalam siklus kehidupan perempuan. Menopause ditandai dengan berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, umumnya terjadi pada usia 45–55 tahun, dan bukan merupakan penyakit, melainkan proses biologis akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron. Pada fase ini, perempuan perlu memperoleh edukasi yang benar agar mampu memahami perubahan tubuhnya, mengurangi kecemasan, dan tetap menjalani kehidupan yang sehat, aktif, serta produktif. (Kemenkes RI, 2025)

Dalam asuhan kebidanan, bidan berperan sebagai edukator, konselor, pendamping, dan penghubung layanan kesehatan. Edukasi pada masa perimenopause dan menopause tidak hanya berfokus pada keluhan fisik seperti hot flushes, gangguan tidur, nyeri sendi, atau perubahan berat badan, tetapi juga mencakup kesehatan mental, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan tulang, pencegahan penyakit tidak menular, dan kesiapan perempuan menerima perubahan dirinya. (Kemenkes RI, 2025; Widjayanti, 2021)

B. Konsep Edukasi Gaya Hidup Sehat pada Masa Perimenopause dan Menopause

Edukasi gaya hidup sehat pada masa perimenopause dan menopause adalah proses pemberian informasi, bimbingan, motivasi, serta pendampingan kepada perempuan agar mampu memahami perubahan tubuh, mengenali keluhan, mengambil keputusan sehat, dan menerapkan perilaku hidup yang mendukung kesehatan jangka panjang. Edukasi ini tidak hanya bertujuan agar perempuan “tahu” tentang menopause, tetapi juga mampu mengubah pengetahuan menjadi sikap positif dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa menopause, perubahan hormonal dapat memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial, sehingga edukasi perlu diberikan secara komprehensif dan berkesinambungan. (WHO, 2024; Annisa et al., 2023)

Edukasi gaya hidup sehat menjadi penting karena keluhan menopause bersifat individual. Sebagian perempuan mengalami keluhan ringan, sedangkan sebagian lainnya mengalami keluhan yang mengganggu aktivitas, pekerjaan, hubungan

keluarga, kehidupan seksual, dan kualitas hidup. WHO menegaskan bahwa menopause perlu dipahami sebagai bagian dari rangkaian kehidupan perempuan, bukan sekadar peristiwa biologis, dan fase ini dapat menjadi kesempatan untuk menilai ulang kesehatan, gaya hidup, serta tujuan hidup perempuan. (WHO, 2024)

Ruang lingkup edukasi gaya hidup sehat pada masa perimenopause dan menopause meliputi edukasi nutrisi, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, kesehatan tulang, kesehatan jantung, kesehatan mental, kualitas tidur, kesehatan seksual, pengelolaan stres, pencegahan penyakit tidak menular, pemeriksaan kesehatan berkala, serta dukungan keluarga dan sosial. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa gaya hidup yang mencakup pola makan, aktivitas fisik, stres, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan tidur berhubungan dengan keluhan menopause; perempuan dengan gaya hidup lebih sehat cenderung melaporkan keluhan yang lebih ringan. (Annisa et al., 2023; Alomedika, 2024)

1. Tujuan Edukasi Gaya Hidup Sehat

Tujuan pertama edukasi gaya hidup sehat adalah meningkatkan pengetahuan perempuan tentang proses perimenopause dan menopause. Banyak perempuan merasa cemas karena tidak memahami bahwa perubahan siklus menstruasi, hot flushes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, nyeri sendi, kekeringan vagina, atau perubahan berat badan dapat berkaitan dengan transisi menopause. Dengan pengetahuan yang benar, perempuan dapat membedakan perubahan fisiologis normal dengan tanda bahaya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. (WHO, 2024; Alomedika, 2024)

Tujuan kedua adalah membentuk sikap positif terhadap menopause. Edukasi perlu membantu perempuan memahami bahwa menopause bukan akhir dari produktivitas, feminitas, ataupun kualitas hidup. Edukasi yang tepat dapat membantu perempuan menerima perubahan tubuh, mengurangi stigma, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendorong perempuan untuk mencari pertolongan kesehatan tanpa rasa malu. (WHO, 2024; Widjayanti, 2022)

Tujuan ketiga adalah mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Perempuan perlu dibimbing agar mampu menerapkan pola makan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik teratur, menjaga berat badan, tidur cukup, mengelola stres, menghindari rokok dan alkohol, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Edukasi tidak cukup disampaikan dalam bentuk ceramah, tetapi perlu diarahkan pada perubahan perilaku yang realistis dan sesuai kondisi individu. (Mukarrama et al., 2025; Annisa et al., 2023)

Tujuan keempat adalah mencegah komplikasi jangka panjang. Penurunan estrogen pada masa menopause berkaitan dengan peningkatan risiko osteoporosis, gangguan kardiometabolik, peningkatan berat badan, gangguan

tidur, serta masalah psikologis. Karena itu, edukasi gaya hidup sehat berperan sebagai upaya promotif dan preventif agar perempuan tidak hanya mengatasi keluhan saat ini, tetapi juga menjaga kesehatan pada masa lanjut usia. (Alomedika, 2024; International Menopause Society, 2025)

2. Manfaat Edukasi Gaya Hidup Sehat

Manfaat edukasi gaya hidup sehat adalah meningkatnya kemampuan perempuan dalam melakukan perawatan diri. Perempuan yang memahami faktor pencetus keluhan dan cara mengatasinya akan lebih mampu mengelola hot flushes, gangguan tidur, perubahan mood, peningkatan berat badan, serta keluhan muskuloskeletal. Edukasi juga dapat mengurangi kecemasan karena perempuan memperoleh penjelasan yang benar mengenai perubahan tubuhnya. (WHO, 2024; Annisa et al., 2023)

Edukasi juga bermanfaat meningkatkan kualitas hidup. Penelitian pada perempuan menopause di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik berhubungan signifikan dengan kualitas hidup perempuan menopause. Literature review tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa aktivitas fisik, baik aktivitas harian, latihan fisik, maupun olahraga, berpotensi memengaruhi kualitas hidup wanita menopause. (Guna et al., 2024; Khoeriyah et al., 2024)

Manfaat lain adalah meningkatnya kesadaran terhadap pencegahan penyakit tidak menular. Pada masa menopause, perempuan perlu lebih memperhatikan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, berat badan, lingkaran perut, dan kesehatan tulang. Edukasi nutrisi dan aktivitas fisik membantu perempuan memahami bahwa perubahan gaya hidup dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, osteoporosis, dan penurunan fungsi fisik. (Erdélyi et al., 2023; International Menopause Society, 2025)

Edukasi gaya hidup sehat juga bermanfaat memperkuat dukungan keluarga dan sosial. Penelitian di Jakarta menunjukkan adanya hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup perempuan postmenopause. Penelitian lain di Indonesia juga menemukan bahwa pendidikan, dukungan suami, dukungan teman sebaya, aktivitas fisik, dan kecemasan berhubungan dengan kualitas hidup perempuan menopause. (Syam et al., 2022; Anggraini et al., 2024)

3. Jenis-Jenis Edukasi Gaya Hidup Sehat

Edukasi promotif bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan bahwa menopause adalah fase alami yang tetap dapat dijalani secara sehat, aktif, dan produktif. Materi promotif mencakup pengenalan proses menopause, perubahan yang mungkin terjadi, pentingnya penerimaan diri, serta dorongan untuk mempertahankan aktivitas sosial dan peran keluarga. Edukasi promotif penting karena masih banyak perempuan yang kurang mendapat informasi tentang

menopause di keluarga, masyarakat, tempat kerja, maupun layanan kesehatan. (WHO, 2024)

Edukasi preventif bertujuan mencegah munculnya gangguan kesehatan yang sering meningkat setelah menopause. Materinya meliputi pencegahan osteoporosis, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, obesitas, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan mental. Dalam praktik kebidanan, edukasi preventif dapat diberikan dengan menganjurkan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, lingkar perut, dan pemeriksaan lain sesuai indikasi. (Alomedika, 2024; Nabila, 2024)

Edukasi nutrisi berfokus pada pemenuhan makanan bergizi seimbang, kecukupan protein, kalsium, vitamin D, cairan, serat, serta pembatasan gula, garam, lemak jenuh, dan makanan ultra-proses. Tinjauan nutrisi pada menopause menekankan pentingnya pola makan seimbang, asupan cairan, pencegahan penyakit kardiovaskular melalui diet, serta zat gizi kunci seperti vitamin D, kalsium, vitamin C, vitamin B, dan protein. Edukasi nutrisi perlu disesuaikan dengan kebiasaan makan lokal, kemampuan ekonomi, penyakit penyerta, dan preferensi perempuan. (Erdélyi et al., 2023)

Edukasi aktivitas fisik bertujuan meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan, mempertahankan massa otot, menjaga kepadatan tulang, mengurangi risiko jatuh, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kualitas hidup. WHO menganjurkan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu atau aktivitas intensitas berat 75 menit per minggu, ditambah latihan penguatan otot dua hari atau lebih per minggu. Rekomendasi serupa juga digunakan dalam kajian menopause, yaitu aktivitas aerobik sedang minimal 150 menit per minggu dan latihan kekuatan atau resistensi minimal dua hari per minggu. (WHO, 2024; International Menopause Society, 2025)

Edukasi kesehatan mental dan manajemen stres diberikan karena masa perimenopause dan menopause dapat disertai perubahan suasana hati, mudah cemas, mudah marah, gangguan tidur, penurunan kepercayaan diri, dan stres akibat perubahan peran sosial. Bidan dapat mengajarkan teknik relaksasi sederhana, latihan napas, aktivitas spiritual, dukungan kelompok, kegiatan sosial, hobi, serta anjuran mencari bantuan profesional bila muncul kecemasan berat atau gejala depresi. Stres pada masa paruh baya dapat berkaitan dengan perubahan fisik, metabolik, psikologis, serta beban keluarga dan pekerjaan. (International Menopause Society, 2025; WHO, 2024)

Edukasi tidur sehat penting karena gangguan tidur sering terjadi pada masa menopause dan dapat memperburuk kelelahan, emosi, konsentrasi, dan kualitas hidup. Edukasi dapat mencakup tidur dan bangun pada jam yang teratur,

membatasi kafein pada sore atau malam hari, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, serta melakukan relaksasi sebelum tidur. Edukasi tidur perlu dikaitkan dengan edukasi stres, aktivitas fisik, dan pengaturan gejala vasomotor seperti hot flushes. (Annisa et al., 2023; Alomedika, 2024)

Edukasi kesehatan seksual dan urogenital bertujuan membantu perempuan memahami perubahan yang mungkin terjadi, seperti vagina kering, nyeri saat berhubungan seksual, penurunan libido, atau gangguan berkemih. Topik ini sering tidak dibicarakan karena dianggap tabu, padahal dapat memengaruhi kualitas hidup dan hubungan pasangan. Bidan perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sopan, menjaga privasi, dan memberikan rujukan bila ditemukan keluhan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. (WHO, 2024; Alomedika, 2024)

Edukasi berbasis keluarga dan dukungan sosial perlu diberikan karena keberhasilan perubahan gaya hidup sering dipengaruhi oleh lingkungan rumah. Pasangan dan keluarga dapat membantu menyediakan makanan sehat, mendukung aktivitas fisik, memahami perubahan emosi, serta mengurangi stigma terhadap menopause. Dukungan sosial terbukti berhubungan dengan kualitas hidup perempuan postmenopause, sehingga edukasi tidak sebaiknya hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga melibatkan keluarga bila memungkinkan. (Syam et al., 2022; Anggraini et al., 2024)

4. Metode Edukasi yang Dapat Digunakan Bidan

Metode edukasi dapat dilakukan melalui konseling individual, konseling kelompok kecil, penyuluhan kelas ibu, diskusi interaktif, demonstrasi aktivitas fisik ringan, penggunaan leaflet, poster, media digital, serta pemantauan berkala. Pengabdian masyarakat pada perempuan menopause menunjukkan bahwa penyuluhan dan diskusi interaktif dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang nutrisi seimbang, aktivitas fisik, manajemen stres, dan pemeriksaan kesehatan rutin. (Mukarrama et al., 2025)

Konseling individual bermanfaat untuk perempuan yang memiliki keluhan spesifik, penyakit penyerta, kecemasan, masalah seksual, atau hambatan pribadi dalam menjalankan gaya hidup sehat. Dalam konseling individual, bidan dapat melakukan pengkajian pola makan, aktivitas fisik, tidur, stres, riwayat penyakit, berat badan, dan dukungan keluarga, lalu menyusun rencana perubahan perilaku yang realistis. (Alomedika, 2024; Annisa et al., 2023)

Konseling kelompok bermanfaat untuk membangun rasa saling mendukung antarperempuan. Dalam pelatihan kesehatan “Sehat dan Bahagia di Masa Menopause”, edukasi dilakukan melalui konseling individual atau

kelompok kecil dengan media leaflet tentang perubahan fisik dan psikologis, aktivitas fisik, serta diet fitoestrogen; hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan setelah pelatihan. (Widjayanti, 2022)

5. Prinsip Edukasi Gaya Hidup Sehat

Prinsip pertama adalah berpusat pada perempuan. Bidan perlu menghargai pengalaman, keluhan, nilai budaya, keyakinan, kemampuan ekonomi, dan prioritas perempuan. Edukasi yang terlalu umum sering sulit diterapkan, sehingga pesan kesehatan perlu disesuaikan dengan kondisi individu, misalnya pekerjaan, kebiasaan makan keluarga, akses terhadap tempat olahraga, dan penyakit penyerta. (WHO, 2024; Alomedika, 2024)

Prinsip kedua adalah pemberdayaan. Edukasi harus membuat perempuan merasa mampu mengambil keputusan sehat, bukan merasa disalahkan atas keluhan yang dialami. Bidan dapat menggunakan pendekatan bertahap, misalnya meminta klien memilih satu perubahan kecil yang paling mungkin dilakukan, seperti berjalan kaki 10–15 menit setiap hari, menambah sayur pada makan siang, mengurangi minuman manis, atau tidur lebih teratur. (Mukarrama et al., 2025; Widjayanti, 2022)

Prinsip ketiga adalah berkelanjutan. Perubahan gaya hidup tidak dapat dicapai hanya dengan satu kali penyuluhan. Bidan perlu melakukan penguatan pesan, evaluasi, dan tindak lanjut pada kunjungan berikutnya. Edukasi berulang membantu perempuan mempertahankan perilaku sehat dan menyesuaikan rencana bila terdapat hambatan. (Widjayanti, 2022; Nabila, 2024)

Prinsip keempat adalah melibatkan keluarga dan lingkungan sosial. Perempuan akan lebih mudah mempertahankan perilaku sehat bila keluarga mendukung pilihan makanan sehat, memberi waktu untuk berolahraga, tidak meremehkan keluhan, dan bersedia menemani pemeriksaan kesehatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan suami dan teman sebaya berkaitan dengan kualitas hidup perempuan menopause. (Anggraini et al., 2024; Syam et al., 2022)

6. Indikator Keberhasilan Edukasi

Keberhasilan edukasi dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan perempuan tentang menopause, nutrisi, aktivitas fisik, manajemen stres, dan pemeriksaan kesehatan. Indikator sederhana dapat diukur melalui pertanyaan lisan, pre-test dan post-test, atau diskusi ulang mengenai pesan yang telah diberikan. Kegiatan edukasi kesehatan pada perempuan menopause menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah penyuluhan dan diskusi interaktif. (Mukarrama et al., 2025; Widjayanti, 2022)

Keberhasilan juga dapat dilihat dari perubahan perilaku, seperti mulai melakukan aktivitas fisik teratur, memperbaiki pola makan, mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, tidur lebih teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta mampu mengelola stres dengan cara yang sehat. Perubahan perilaku ini perlu dinilai secara bertahap karena keberhasilan edukasi bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga kemampuan perempuan menerapkan pesan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. (Annisa et al., 2023; Alomedika, 2024)

Indikator lain adalah membaiknya kualitas hidup, menurunnya keluhan yang mengganggu, meningkatnya rasa percaya diri, meningkatnya dukungan keluarga, dan meningkatnya kemampuan perempuan mencari pertolongan bila mengalami tanda bahaya. Faktor pendidikan, dukungan sosial, aktivitas fisik, dan kecemasan terbukti berkaitan dengan kualitas hidup perempuan menopause, sehingga indikator keberhasilan edukasi sebaiknya mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan perilaku. (Anggraini et al., 2024; Guna et al., 2024)

C. Konsep Edukasi Nutrisi pada Perempuan Perimenopause dan Menopause

Prinsip utama nutrisi pada masa menopause adalah gizi seimbang. Pedoman “Isi Piringku” dari Kementerian Kesehatan RI menganjurkan agar dalam satu kali makan, 50% piring diisi sayur dan buah, sedangkan 50% lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk. Prinsip ini dapat digunakan bidan sebagai media edukasi sederhana karena mudah dipahami oleh perempuan dan keluarga dalam praktik makan sehari-hari. (Kemenkes RI, 2024)

Makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, kentang, ubi, roti, atau olahan gandum berfungsi sebagai sumber energi. Pada perempuan menopause, pilihan makanan pokok sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan energi, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Perempuan dengan berat badan berlebih atau kadar gula darah tinggi perlu diedukasi untuk mengontrol porsi karbohidrat, memilih sumber karbohidrat yang lebih berserat, dan menghindari konsumsi makanan manis berlebihan. (Kemenkes RI, 2024)

Laik pauk dibutuhkan sebagai sumber protein untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, dan mempertahankan daya tahan tubuh. Sumber protein dapat berasal dari hewani seperti ikan, telur, ayam, daging tanpa lemak, susu, yoghurt, dan keju, serta sumber nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lauk nabati seperti tempe dan tahu juga sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia serta dapat menjadi pilihan ekonomis dalam edukasi gizi keluarga. (Kemenkes RI, 2024)

Sayur dan buah penting karena mengandung serat, vitamin, mineral, air, dan antioksidan. Serat membantu memperlancar buang air besar, membantu pengendalian berat badan, dan mendukung kesehatan metabolik. Kementerian Kesehatan juga menekankan bahwa sayur dan buah bermanfaat dalam menjaga berat badan seimbang serta mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan kanker. (Kemenkes RI, 2024)

Kalsium dan vitamin D merupakan zat gizi penting pada masa menopause karena penurunan estrogen dapat mempercepat kehilangan massa tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa perempuan pascamenopause disarankan memenuhi sekitar 1.200 mg kalsium per hari, dengan sumber seperti susu, yoghurt, keju, sayuran hijau, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian; vitamin D membantu penyerapan kalsium dan dapat diperoleh dari paparan sinar matahari, ikan berlemak, kuning telur, serta makanan yang diperkaya vitamin D. (Kemenkes RI, 2025)

Bidan perlu mengedukasi perempuan menopause untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Kementerian Kesehatan menganjurkan batas konsumsi per orang per hari yaitu gula maksimal 50 gram atau 4 sendok makan, garam 2.000 mg natrium atau 5 gram/1 sendok teh garam, dan lemak 67 gram atau sekitar 5 sendok makan minyak goreng. Pesan ini penting karena konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan berhubungan dengan obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. (Kemenkes RI, 2024)

Kebutuhan gizi perempuan perlu mempertimbangkan usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 menetapkan Angka Kecukupan Gizi sebagai standar nasional kebutuhan zat gizi harian masyarakat Indonesia berdasarkan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Dalam praktik kebidanan, AKG dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun edukasi makan sehat, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi individu, penyakit penyerta, dan anjuran tenaga kesehatan. (Kemenkes RI, 2019)

1. Pengertian Edukasi Nutrisi

Edukasi nutrisi pada perempuan perimenopause dan menopause adalah proses pemberian informasi, bimbingan, dan motivasi agar perempuan mampu memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Edukasi ini penting karena perubahan hormon pada masa menopause dapat memengaruhi berat badan, kesehatan tulang, metabolisme, suasana hati, dan kualitas hidup. (WHO, 2024; Liu et al., 2025)

Edukasi nutrisi tidak hanya membahas makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga mengajarkan cara mengatur porsi makan, memilih

bahan makanan sehat, mengolah makanan dengan tepat, dan menerapkan pola makan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. (WHO, 2026; Erdélyi et al., 2023)

2. Tujuan Edukasi Nutrisi

Tujuan edukasi nutrisi pada perempuan perimenopause dan menopause antara lain:

a. Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kebutuhan gizi.

Perempuan perlu memahami bahwa kebutuhan gizi dapat berubah seiring penurunan hormon estrogen, penambahan usia, dan perubahan metabolisme tubuh. (Erdélyi et al., 2023)

b. Membantu mempertahankan status gizi normal.

Edukasi nutrisi membantu perempuan mencegah kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan obesitas yang dapat memperberat keluhan menopause. (Widjayanti, 2021)

c. Mencegah penyakit tidak menular.

Pola makan sehat dapat membantu mencegah hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, obesitas, dan dislipidemia. (WHO, 2026)

d. Menjaga kesehatan tulang.

Edukasi nutrisi membantu perempuan memahami pentingnya kalsium, vitamin D, protein, dan zat gizi lain untuk mencegah osteoporosis. (Liu et al., 2025)

e. Mengurangi keluhan menopause.

Pola makan yang tepat dapat membantu mengurangi keluhan seperti cepat lelah, konstipasi, gangguan tidur, peningkatan berat badan, dan keluhan metabolik lainnya. (Liu et al., 2025)

3. Manfaat Edukasi Nutrisi

Manfaat edukasi nutrisi bagi perempuan perimenopause dan menopause meliputi:

a. Meningkatkan kemampuan perawatan diri.

Perempuan menjadi lebih mampu memilih makanan sehat dan mengatur pola makan secara mandiri. (WHO, 2026)

b. Membantu mengontrol berat badan.

Pengaturan asupan energi, protein, serat, dan lemak sehat dapat membantu mencegah peningkatan berat badan pada masa menopause. (Liu et al., 2025)

c. Menjaga kesehatan tulang dan otot.

Asupan kalsium, vitamin D, dan protein yang cukup membantu mempertahankan kepadatan tulang dan massa otot. (Liu et al., 2025)

d. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Pola makan yang kaya sayur, buah, kacang-kacangan, ikan, dan lemak sehat dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. (Erdélyi et al., 2023; Liu et al., 2025)

e. Meningkatkan kualitas hidup.

Perempuan yang memahami nutrisi sehat cenderung lebih siap menghadapi perubahan tubuh dan lebih termotivasi menjaga kesehatannya. (Musaidah, Idris, & Kadir, 2024)

4. Prinsip Edukasi Nutrisi

Prinsip edukasi nutrisi pada perempuan perimenopause dan menopause meliputi:

a. Gizi seimbang.

Makanan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan cairan dalam jumlah seimbang. (WHO, 2026)

b. Makan beragam.

Perempuan dianjurkan mengonsumsi berbagai jenis makanan agar kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi. (WHO, 2026)

c. Mengutamakan makanan alami.

Makanan segar seperti sayur, buah, ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian lebih dianjurkan dibandingkan makanan ultra-proses. (Erdélyi et al., 2023)

d. Membatasi gula, garam, dan lemak.

Pembatasan ini penting untuk mencegah obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. (WHO, 2026)

e. Disesuaikan dengan kondisi individu.

Edukasi nutrisi harus memperhatikan usia, berat badan, aktivitas fisik, penyakit penyerta, kebiasaan makan, budaya, dan kemampuan ekonomi. (WHO, 2026; Liu et al., 2025)

5. Jenis-Jenis Edukasi Nutrisi

a. Gizi Seimbang

Edukasi gizi seimbang berisi anjuran untuk mengonsumsi makanan yang bervariasi dan sesuai kebutuhan tubuh. Perempuan menopause perlu mengonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air putih dalam jumlah cukup. (WHO, 2026)

b. Karbohidrat Sehat

Karbohidrat tetap dibutuhkan sebagai sumber energi, tetapi perlu dipilih dari sumber yang lebih sehat. Contohnya nasi merah, jagung, ubi, singkong rebus, kentang, oatmeal, sayur, buah utuh, dan kacang-kacangan. (WHO, 2026)

c. Protein

Protein penting untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, menjaga metabolisme, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber protein yang dianjurkan antara lain ikan, telur, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, susu, dan yoghurt. (Liu et al., 2025)

d. Lemak Sehat

Perempuan menopause perlu membatasi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak sehat dapat diperoleh dari ikan, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati dalam jumlah wajar. (WHO, 2026)

e. Serat, Sayur, dan Buah

Serat membantu melancarkan pencernaan, mengontrol berat badan, dan menjaga kesehatan metabolik. Sayur dan buah sebaiknya dikonsumsi setiap hari sebagai sumber vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. (WHO, 2026)

f. Kalsium dan Vitamin D

Kalsium dan vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang. Sumber kalsium dapat berasal dari susu, yoghurt, keju, ikan bertulang lunak, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Vitamin D dapat diperoleh dari sinar matahari, ikan berlemak, telur, dan makanan fortifikasi. (Liu et al., 2025)

g. Fitoestrogen

Fitoestrogen adalah senyawa alami dari tumbuhan yang memiliki efek mirip estrogen dalam kadar ringan. Sumber fitoestrogen antara lain kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Fitoestrogen dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, tetapi bukan pengganti terapi medis. (Ekasari & Yastirin, 2020)

h. Pembatasan Gula, Garam, dan Makanan Ultra Proses

Perempuan menopause perlu membatasi minuman manis, kue manis, makanan asin, makanan cepat saji, makanan kemasan, dan gorengan berlebihan. Pembatasan ini bertujuan mencegah obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. (WHO, 2026)

i. Hidrasi

Kebutuhan cairan perlu dipenuhi dengan cukup minum air putih. Perempuan dianjurkan membatasi minuman berpemanis, minuman bersoda, dan konsumsi kafein berlebihan, terutama bila mengalami gangguan tidur atau hot flashes. (Erdélyi et al., 2023)

j. Cara Pengolahan Makanan

Cara memasak juga memengaruhi kualitas makanan. Perempuan dianjurkan memilih makanan yang direbus, dikukus, dipepes, dipanggang, atau ditumis

dengan sedikit minyak. Makanan yang digoreng berulang sebaiknya dibatasi. (WHO, 2026)

6. Strategi Bidan dalam Edukasi Nutrisi

Strategi yang dapat dilakukan bidan antara lain:

a. Melakukan pengkajian pola makan.

Bidan menanyakan kebiasaan makan, jenis makanan yang sering dikonsumsi, frekuensi makan, konsumsi sayur dan buah, minuman manis, gorengan, serta sumber protein harian. (WHO, 2026)

b. Memberikan edukasi sederhana dan mudah dipahami.

Contohnya: "Setiap kali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah." (Musaidah et al., 2024)

c. Menyesuaikan edukasi dengan kondisi klien.

Perempuan dengan hipertensi perlu dibimbing membatasi garam, perempuan dengan obesitas perlu mengatur porsi makan, dan perempuan dengan risiko osteoporosis perlu memperhatikan kalsium serta vitamin D. (Liu et al., 2025)

d. Menganjurkan perubahan kecil tetapi konsisten.

Misalnya menambah satu porsi sayur setiap hari, mengurangi minuman manis, mengganti camilan tinggi gula dengan buah, atau mengurangi gorengan. (WHO, 2026)

e. Melibatkan keluarga.

Keluarga dapat membantu menyediakan makanan sehat, mendukung perubahan pola makan, dan mengurangi kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak di rumah. (Musaidah et al., 2024)

7. Indikator Keberhasilan Edukasi Nutrisi

Keberhasilan edukasi nutrisi dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Pengetahuan meningkat.

Perempuan mampu menjelaskan kembali pentingnya gizi seimbang, protein, kalsium, vitamin D, serat, cairan, dan pembatasan gula-garam-lemak. (Musaidah et al., 2024)

b. Perilaku makan membaik.

Perempuan mulai mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, memilih lauk berprotein, mengurangi gorengan, dan membatasi makanan manis atau asin. (WHO, 2026)

c. Status gizi lebih terkontrol.

Berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar perut dapat dipantau sebagai indikator perubahan pola makan. (Widjayanti, 2021)

d. Keluhan menopause berkurang.

Keluhan seperti cepat lelah, konstipasi, berat badan meningkat, dan gangguan metabolik dapat membaik dengan pola makan yang lebih sehat. (Liu et al., 2025)

e. Pemeriksaan kesehatan lebih teratur.

Perempuan menjadi lebih sadar untuk memantau tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan kesehatan tulang. (WHO, 2024; Liu et al., 2025)

D. Konsep Edukasi Aktivitas Fisik

1. Pengertian Aktivitas fisik

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang melibatkan kerja otot rangka dan mengeluarkan energi. Pada masa perimenopause dan menopause, aktivitas fisik bermanfaat untuk menjaga berat badan, memperkuat tulang dan otot, meningkatkan keseimbangan, memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, serta mendukung kualitas hidup. Kementerian Kesehatan menganjurkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, misalnya berjalan santai, peregangan, berjalan cepat, berkebun, membersihkan rumah, atau aktivitas lain sesuai kemampuan. (Kemenkes RI, 2024)

Jenis aktivitas fisik yang dianjurkan pada masa menopause meliputi latihan aerobik, latihan kekuatan, latihan beban, latihan fleksibilitas, dan latihan keseimbangan. Contoh latihan yang mudah diterapkan adalah jalan kaki, bersepeda santai, senam, yoga, pilates, latihan peregangan, latihan berdiri satu kaki, dan latihan kekuatan menggunakan beban ringan atau berat badan sendiri. Latihan beban dan kekuatan membantu menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot, sedangkan latihan keseimbangan membantu mengurangi risiko jatuh dan patah tulang. (Kemenkes RI, 2025)

Edukasi aktivitas fisik perlu dilakukan bertahap. Perempuan yang sebelumnya tidak aktif dapat memulai dari aktivitas ringan 10–15 menit per hari, kemudian ditingkatkan menjadi 30 menit per hari sesuai toleransi tubuh. Bidan perlu menekankan prinsip aman, nyaman, teratur, dan menyenangkan. Aktivitas tidak harus selalu dilakukan di pusat kebugaran; pekerjaan rumah, berjalan kaki ke warung, berkebun, menaiki tangga, atau mengikuti senam kelompok juga dapat menjadi bagian dari aktivitas fisik harian. (Kemenkes RI, 2024; Kemenkes RI, 2025)

2. Tujuan Edukasi Aktivitas Fisik pada Masa Perimenopause dan Menopause

a. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang pentingnya tetap aktif selama masa perimenopause dan menopause.

- b. Membantu perempuan memilih aktivitas fisik yang aman, nyaman, sesuai usia, kondisi tubuh, dan kemampuan.
 - c. Mencegah gaya hidup sedentari atau terlalu banyak duduk.
 - d. Membantu menjaga berat badan dan komposisi tubuh.
 - e. Membantu menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang.
 - f. Mengurangi risiko penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan osteoporosis.
 - g. Membantu mengelola stres, kecemasan, gangguan tidur, dan perubahan suasana hati.
 - h. Meningkatkan kemandirian, keseimbangan, mobilitas, dan kualitas hidup perempuan menopause.
3. Manfaat Aktivitas Fisik bagi Perempuan Perimenopause dan Menopause
- a. Manfaat metabolik
 - 1) Membantu mengendalikan berat badan.
 - 2) Membantu mengontrol kadar gula darah.
 - 3) Membantu mengendalikan kadar kolesterol.
 - 4) Membantu menurunkan risiko diabetes melitus tipe 2.
 - 5) Kemenkes menyebut aktivitas fisik bermanfaat untuk mengendalikan berat badan, tekanan darah, kolesterol, serta mencegah diabetes melitus.
 - b. Manfaat kardiovaskular
 - 1) Membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.
 - 2) Membantu menurunkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular.
 - 3) WHO menyebut aktivitas fisik pada orang dewasa dan lansia berhubungan dengan penurunan risiko kematian, penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes tipe 2, serta peningkatan kesehatan mental, kognitif, tidur, dan komposisi tubuh.
 - c. Manfaat tulang dan otot
 - 1) Membantu mempertahankan kepadatan tulang.
 - 2) Membantu mengurangi risiko osteoporosis.
 - 3) Membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot.
 - 4) Membantu mengurangi risiko jatuh dan patah tulang.
 - 5) Latihan kekuatan/resistensi diakui sebagai salah satu metode yang efektif untuk membantu kesehatan tulang dan mencegah penurunan kepadatan mineral tulang.
 - d. Manfaat psikologis
 - 1) Membantu mengurangi stres.
 - 2) Membantu memperbaiki suasana hati.
 - 3) Membantu mengurangi kecemasan dan gejala depresi.

- 4) Membantu meningkatkan rasa percaya diri.
 - 5) WHO menyebut aktivitas fisik dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan serta meningkatkan kesejahteraan umum.
- e. Manfaat kualitas hidup
- 1) Membantu perempuan menopause tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari.
 - 2) Membantu meningkatkan energi, kebugaran, dan fungsi tubuh.
 - 3) Literature review di Indonesia menemukan bahwa aktivitas fisik harian, latihan fisik, dan olahraga berpotensi memengaruhi kualitas hidup wanita menopause secara signifikan.
4. Jenis-Jenis Aktivitas Fisik yang Dianjurkan
- a. Aktivitas aerobik
- 1) Contoh:
 - a) jalan cepat,
 - b) bersepeda santai,
 - c) berenang,
 - d) senam,
 - e) menari,
 - f) jogging ringan sesuai kemampuan.
 - 2) Tujuan:
 - a) meningkatkan kebugaran jantung dan paru,
 - b) membantu mengontrol berat badan,
 - c) membantu menurunkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan penyakit jantung.
 - 3) Kemenkes menyebut aktivitas aerobik seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang dapat dilakukan 3–5 kali per minggu atau 150–300 menit per minggu.
- b. Latihan kekuatan atau resistensi
- 1) Contoh:
 - a) squat ringan,
 - b) wall push-up,
 - c) latihan dengan resistance band,
 - d) mengangkat botol air sebagai beban ringan,
 - e) naik turun kursi dengan aman,
 - f) latihan beban ringan,
 - g) latihan menggunakan berat badan sendiri.
 - 2) Tujuan:
 - a) mempertahankan kekuatan otot,

- b) membantu menjaga metabolisme,
 - c) mendukung kepadatan tulang,
 - d) membantu mencegah sarkopenia atau penurunan massa otot akibat usia.
- 3) American Heart Association menganjurkan aktivitas penguatan otot dengan intensitas sedang hingga tinggi minimal 2 hari per minggu, selain aktivitas aerobik.
- c. Latihan beban atau weight-bearing exercise
 - 1) Contoh:
 - a) jalan kaki,
 - b) jalan cepat,
 - c) naik tangga,
 - d) step-up,
 - e) menari,
 - f) latihan berdiri dari kursi.
 - 2) Tujuan:
 - a) memberi rangsangan mekanik pada tulang,
 - b) membantu menjaga kepadatan tulang,
 - c) mengurangi risiko osteoporosis.
 - 3) Latihan menahan beban seperti berjalan cepat dapat membantu menjaga tulang tetap kuat, sedangkan latihan seperti tai chi, yoga, dan pilates dapat membantu membangun kekuatan dan keseimbangan.
- d. Latihan fleksibilitas
 - 1) Contoh:
 - a) peregangan leher,
 - b) peregangan bahu,
 - c) peregangan punggung,
 - d) peregangan paha dan betis,
 - e) yoga ringan,
 - f) pilates ringan.
 - 2) Tujuan:
 - a) menjaga kelenturan sendi,
 - b) mengurangi kekakuan otot,
 - c) memperbaiki postur,
 - d) membantu tubuh lebih nyaman saat beraktivitas.
 - 3) Kemenkes juga menyebut aktivitas fisik bermanfaat menjaga dan memperbaiki kelenturan sendi dan otot serta memperbaiki postur tubuh.

e. Latihan keseimbangan

1) Contoh:

- a) berdiri satu kaki dengan pegangan kursi,
- b) berjalan lurus mengikuti garis,
- c) heel-to-toe walk,
- d) tai chi,
- e) latihan memindahkan berat badan kanan-kiri.

2) Tujuan:

- a) mengurangi risiko jatuh,
- b) meningkatkan koordinasi,
- c) menjaga kemandirian aktivitas harian.

3) WHO menganjurkan orang dewasa yang lebih tua, terutama dengan mobilitas terbatas, melakukan aktivitas yang meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh minimal 3 hari per minggu.

f. Mind-body exercise

1) Contoh:

- a) yoga,
- b) tai chi,
- c) pilates,
- d) latihan napas,
- e) meditasi bergerak.

2) Tujuan:

- a) membantu relaksasi,
- b) memperbaiki keseimbangan,
- c) mengurangi stres,
- d) meningkatkan kesadaran tubuh.

3) Overview of reviews tahun 2024 menemukan bahwa yoga memiliki bukti perbaikan pada gejala fisik, urogenital, dan total gejala menopause, meskipun bukti untuk gejala vasomotor dan psikologis masih belum sepenuhnya konsisten.

5. Dosis atau Anjuran Aktivitas Fisik

a. Anjuran umum untuk orang dewasa

- 1) Minimal 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang, atau
- 2) 75 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas berat, atau
- 3) kombinasi keduanya.
- 4) Aktivitas sebaiknya dibagi dalam beberapa hari, bukan dilakukan sekaligus.

- 5) WHO menyebut setiap aktivitas fisik lebih baik daripada tidak sama sekali, semua aktivitas fisik dihitung, waktu sedentari perlu dikurangi, dan latihan penguatan otot bermanfaat bagi semua orang.
- b. Anjuran tambahan untuk manfaat kesehatan lebih besar
 - 1) Aktivitas aerobik intensitas sedang dapat ditingkatkan sampai 300 menit per minggu.
 - 2) Latihan penguatan otot dilakukan minimal 2 hari per minggu.
 - 3) AHA juga menganjurkan 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu atau 75 menit aktivitas berat per minggu, ditambah latihan penguatan otot minimal 2 hari per minggu.
- c. Anjuran praktis harian
 - 1) Aktivitas dapat dilakukan minimal 30 menit per hari.
 - 2) Dapat dibagi menjadi beberapa sesi, misalnya:
 - a) 10 menit pagi,
 - b) 10 menit siang,
 - c) 10 menit sore.
 - 3) Kemenkes menekankan bahwa aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari dapat dilakukan di rumah, tempat kerja, maupun tempat umum, misalnya membersihkan rumah, berkebun, menggunakan tangga, atau berjalan kaki ke warung.
6. Prinsip Edukasi Aktivitas Fisik
 - a. Aman
 - 1) Disesuaikan dengan usia, status kesehatan, kebugaran, riwayat penyakit, dan risiko cedera.
 - 2) Perempuan dengan nyeri dada, sesak berat, pusing, riwayat penyakit jantung, osteoporosis berat, atau gangguan sendi berat perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai latihan.
 - b. Bertahap
 - 1) Perempuan yang belum terbiasa aktif dapat memulai dari aktivitas ringan.
 - 2) Contoh:
 - a) minggu pertama: 10 menit/hari,
 - b) minggu kedua: 15–20 menit/hari,
 - c) minggu ketiga: 20–30 menit/hari,
 - d) selanjutnya: ditingkatkan sesuai toleransi tubuh.
 - c. Teratur
 - 1) Aktivitas lebih baik dilakukan konsisten daripada berat tetapi jarang.
 - 2) Jadwal dapat dibuat 3–5 kali per minggu untuk aerobik dan 2 kali per minggu untuk latihan kekuatan.

- d. Menyenangkan
 - 1) Pilih aktivitas yang disukai agar mudah dipertahankan.
 - 2) Contoh:
 - a) jalan pagi bersama tetangga,
 - b) senam kelompok,
 - c) bersepeda santai,
 - d) berkebun,
 - e) menari,
 - f) yoga ringan.
- e. Sesuai kemampuan
 - 1) Tidak semua perempuan menopause harus melakukan olahraga berat.
 - 2) Aktivitas rumah tangga, berjalan kaki, naik tangga, dan berkebun tetap dapat dihitung sebagai aktivitas fisik harian.
- 7. Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Edukasi
 - a. Gunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
 - b. Tekankan bahwa aktivitas fisik tidak harus mahal dan tidak harus dilakukan di pusat kebugaran.
 - c. Anjurkan pemanasan 5–10 menit sebelum latihan.
 - d. Anjurkan pendinginan dan peregangan ringan setelah latihan.
 - e. Gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman.
 - f. Minum air yang cukup.
 - g. Hindari olahraga berat saat tubuh sangat lelah, demam, nyeri dada, sesak napas, atau pusing.
 - h. Hentikan aktivitas bila muncul:
 - 1) nyeri dada,
 - 2) sesak napas berat,
 - 3) pusing,
 - 4) jantung berdebar berlebihan,
 - 5) nyeri sendi berat,
 - 6) kelemahan mendadak.
 - i. Pada perempuan dengan osteoporosis, hindari gerakan memutar tulang belakang secara ekstrem, melompat berat, atau mengangkat beban berlebihan tanpa pendampingan.
- 8. Peran Bidan dalam Edukasi Aktivitas Fisik
 - a. Mengkaji tingkat aktivitas fisik perempuan perimenopause dan menopause.
 - b. Mengidentifikasi hambatan, seperti nyeri sendi, kurang waktu, kurang dukungan keluarga, takut cedera, atau kurang pengetahuan.

- c. Memberikan contoh latihan sederhana yang dapat dilakukan di rumah.
- d. Menganjurkan aktivitas yang realistis dan sesuai budaya setempat.
- e. Memberikan motivasi agar perempuan tidak hanya aktif sesaat, tetapi mampu mempertahankan kebiasaan bergerak.
- f. Melibatkan keluarga agar mendukung aktivitas fisik ibu.
- g. Mengarahkan pemeriksaan kesehatan bila terdapat keluhan atau faktor risiko.
- h. Memantau perubahan berat badan, tekanan darah, keluhan menopause, kadar kolesterol, dan kualitas hidup bila memungkinkan.
- i. Penelitian di Posyandu Lansia Sekarsari Bondowoso menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas fisik dan kadar kolesterol pada wanita menopause, sehingga perempuan menopause dianjurkan melakukan aktivitas fisik, olahraga, pemeriksaan kolesterol rutin, dan konsumsi makanan seimbang.

E. Konsep Edukasi Pengendalian Berat Badan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Perubahan hormon pada masa menopause dapat memengaruhi distribusi lemak tubuh, metabolisme, dan kecenderungan peningkatan berat badan. Oleh sebab itu, bidan perlu mengedukasi perempuan untuk memantau berat badan, lingkaran perut, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan keluhan yang dirasakan. Pemantauan ini penting terutama bagi perempuan dengan riwayat keluarga diabetes, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, osteoporosis, atau menopause dini. (Kemenkes RI, 2024; Hadijati et al., 2024)

Menjaga berat badan ideal dapat dilakukan melalui kombinasi pengaturan makan dan aktivitas fisik. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa aktivitas fisik rutin membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan keseimbangan, meningkatkan metabolisme, memelihara kesehatan tulang, otot, dan sendi, serta mengurangi risiko diabetes dan tekanan darah tinggi. Dalam edukasi kebidanan, pesan ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan perempuan sehari-hari, misalnya tetap kuat bekerja, tidak mudah lelah, tidur lebih baik, dan lebih percaya diri. (Kemenkes RI, 2024)

F. Peran Bidan dalam Edukasi Gaya Hidup Sehat

Bidan perlu melakukan pengkajian awal sebelum memberikan edukasi. Pengkajian meliputi usia, riwayat menstruasi, keluhan menopause, status gizi, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan tidur, tingkat stres, riwayat penyakit, penggunaan obat atau suplemen, riwayat merokok, konsumsi alkohol, serta dukungan keluarga.

Data tersebut membantu bidan menentukan pesan edukasi yang sesuai dan menghindari nasihat yang terlalu umum. (Kemenkes RI, 2025; Widjayanti, 2021)

Dalam konseling, bidan sebaiknya menggunakan bahasa sederhana, tidak menghakimi, dan menghargai pengalaman perempuan. Misalnya, bidan dapat mengatakan: "Ibu sedang memasuki fase alami kehidupan. Keluhan yang Ibu rasakan dapat dikelola dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur cukup, dan pemeriksaan kesehatan berkala." Pendekatan yang empatik membantu perempuan merasa didengar dan lebih termotivasi untuk mengubah perilaku. (Kemenkes RI, 2025)

Bidan juga perlu melibatkan keluarga, terutama pasangan dan anak dewasa, karena dukungan keluarga memengaruhi keberhasilan perubahan gaya hidup. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan sehat, menemani olahraga, mengurangi komentar negatif tentang perubahan tubuh, serta mendukung perempuan untuk memeriksakan diri bila mengalami keluhan berat. Edukasi yang melibatkan keluarga dapat mengubah menopause dari pengalaman yang menakutkan menjadi fase adaptasi yang lebih positif. (Kemenkes RI, 2025)

G. Kesimpulan

Edukasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan aktivitas fisik merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan pada perempuan perimenopause dan menopause. Menopause adalah fase alami yang membutuhkan penerimaan diri, pengetahuan, dan dukungan. Pola makan bergizi seimbang, pembatasan gula-garam-lemak, kecukupan kalsium dan vitamin D, aktivitas fisik teratur, pengendalian berat badan, tidur cukup, pengelolaan stres, serta pemeriksaan kesehatan berkala merupakan pesan utama yang perlu diberikan bidan. (Kemenkes RI, 2023; Kemenkes RI, 2024; Kemenkes RI, 2025)

Peran bidan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu perempuan membuat rencana perubahan perilaku yang realistis. Edukasi yang baik harus bersifat individual, praktis, berbasis budaya lokal, melibatkan keluarga, dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendampingan yang tepat, perempuan perimenopause dan menopause dapat tetap sehat, aktif, percaya diri, dan memiliki kualitas hidup yang baik. (Widjayanti, 2021; Khoeriyah et al., 2024)

H. Referensi

Hadijati, U., Hikmatin, N., & Suhartin, S. (2024). *Hubungan Status Gizi, Aktivitas Fisik Wanita Menopause dengan Kadar Kolesterol di Posyandu Lansia Sekarsari Taman Sari Indah Bondowoso*. TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi,

- Kesehatan, dan Humaniora, 5(2). Penerbit: Universitas Nurul Jadid, Indonesia.
- Hadijati, U., Hikmatin, N., & Suhartin, S. (2024). Hubungan status gizi, aktivitas fisik wanita menopause dengan kadar kolesterol di Posyandu Lansia Sekarsari Taman Sari Indah Bondowoso. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 5(2), 250–258. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i2.8594>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Gizi Seimbang saat Usia Menopause*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Cegah Meningkatnya Diabetes, Jangan Berlebihan Konsumsi Gula, Garam, Lemak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Isi Piringku, Panduan Kebutuhan Gizi Seimbang Harian*. Jakarta: Ayo Sehat, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Cara Merawat Tulang saat Menopause*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Menopause Hanya Momen Bukan Momok*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan RI.
- Khoeriyah, N., Kusumaningsih, M. R., & Adyani, K. (2024). *Aktifitas Fisik dan Kualitas Hidup Wanita Menopause: Literature Review*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 7(3), 613–619. Penerbit: Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia.
- Khoeriyah, N., Kusumaningsih, M. R., & Adyani, K. (2024). Aktifitas fisik dan kualitas hidup wanita menopause: Literature review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(3), 613–619. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i3.4576>
- Money, A., MacKenzie, A., Norman, G., Eost-Telling, C., Harris, D., McDermott, J., & Todd, C. (2024). The impact of physical activity and exercise interventions on symptoms for women experiencing menopause: Overview of reviews. *BMC Women's Health*, 24, Article 399. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03243-4>

- Permatasari, D., dkk. (2024). *Edukasi dan Implementasi Aktivitas Fisik sebagai Upaya Pencegahan Gejala Klimakterium pada Ibu Premenopause*. WASATHON: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1). Penerbit: Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia.
- Widjayanti, Y. (2021). *Status Gizi, Aktivitas Fisik dan Keluhan Menopause*. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, 6(1), 68–75. Penerbit: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia.

CHAPTER 5

DUKUNGAN KELUARGA DALAM ADAPTASI PEREMPUAN MENGHADAPI MENOPAUSE

Nurbaety, S.SiT., M.KM

A. Pendahuluan

Menopause adalah berhentinya menstruasi secara permanen akibat hilangnya fungsi folikel ovarium, dan secara alami umumnya terjadi pada usia 45–55 tahun. Secara klinis, menopause dinyatakan bila seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa sebab fisiologis atau patologis lain. Definisi ini penting karena banyak perempuan dan keluarga masih memandang perubahan haid menjelang menopause sebagai sesuatu yang samar, padahal fase ini memiliki makna biologis dan klinis yang jelas. (WHO, 2024; Lowdermilk et al., 2020; Nugroho & Setiawan, 2019).

Perubahan yang menyertai menopause tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek emosional, mental, dan sosial. WHO menegaskan bahwa perubahan hormonal pada masa ini dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan secara menyeluruh. Keluhan yang paling sering dilaporkan meliputi hot flushes, kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, gangguan tidur, kecemasan, dan perubahan suasana hati. Oleh karena itu, pembahasan tentang menopause tidak seharusnya berhenti pada peristiwa “berhentinya haid”, melainkan perlu diperluas pada bagaimana perempuan menjalani aktivitas sehari-hari secara nyaman, bermartabat, dan tetap sehat selama masa transisi tersebut. (WHO, 2024; NICE, 2024; Lowdermilk et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan layanan kesehatan pada masa klimakterium dan menopause juga telah tercermin dalam standar profesi bidan. Dokumen Kementerian Kesehatan memasukkan aspek perubahan dan adaptasi pada masa premenopause, menopause, dan postmenopause, termasuk dukungan psikososial, edukasi perubahan, serta konseling adaptasi pada masa klimakterium. Hal ini menunjukkan bahwa isu menopause secara jelas berada dalam wilayah pelayanan kebidanan. Dengan demikian, pembahasan mengenai dukungan keluarga menjadi penting karena tidak dapat dipisahkan dari asuhan yang utuh, holistik, dan berpusat pada perempuan. (Kemenkes RI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

B. Menopause sebagai Proses Adaptasi

Menopause sebaiknya dipahami sebagai proses adaptasi, bukan semata-mata sebagai kumpulan keluhan atau label “penuaan”. WHO menegaskan bahwa menopause bukan penyakit, melainkan bagian dari perjalanan hidup perempuan. Cara pandang ini penting karena bagaimana keluarga memaknai menopause akan sangat memengaruhi sikap mereka terhadap perempuan yang mengalaminya: apakah dianggap sekadar “banyak mengeluh”, atau justru dipahami sedang menyesuaikan diri dengan perubahan tubuh, emosi, dan peran sosial yang menyertainya. (WHO, 2024; WHO, 2021; Nugroho & Setiawan, 2019).

Adaptasi pada masa menopause berlangsung dalam beberapa lapisan. Secara biologis, perempuan mengalami penurunan kadar estrogen dan perubahan pola menstruasi. Secara psikologis, dapat muncul rasa gelisah, lebih sensitif, mudah lelah, atau penurunan kepercayaan diri. Secara sosial, perempuan juga dapat menghadapi perubahan peran di rumah, di tempat kerja, maupun dalam relasi intim dengan pasangan. NICE menempatkan menopause dalam kerangka *individualized care* serta *information and support*, yang menegaskan bahwa pengalaman setiap perempuan perlu dipahami secara personal dan tidak dapat disamaratakan. (WHO, 2024; NICE, 2024; Lowdermilk et al., 2020).

Adaptasi terhadap menopause dapat berlangsung secara positif maupun maladaptif. Adaptasi positif tampak ketika perempuan mampu menerima perubahan tubuhnya, tetap menjaga aktivitas sehari-hari, bersedia mencari informasi dan bantuan yang tepat, serta mempertahankan hubungan yang sehat dengan keluarga. Sebaliknya, adaptasi maladaptif dapat muncul dalam bentuk penolakan terhadap perubahan, menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak berharga, mudah berkonflik, atau mengabaikan gejala yang sebenarnya memerlukan pertolongan. Perbedaan ini penting karena keluarga dan tenaga kesehatan perlu mengenali sejak dini apakah perempuan sedang menyesuaikan diri secara sehat atau justru membutuhkan dukungan yang lebih intensif. (WHO, 2024; NICE, 2024; Badawy et al., 2024).

Aspek adaptasi psikologis menjadi sangat penting karena bukti mutakhir menunjukkan bahwa perimenopause merupakan fase dengan risiko depresi yang meningkat dibandingkan masa premenopause. Meta-analisis Badawy dkk. menunjukkan bahwa risiko depresi atau gejala depresif pada perempuan perimenopause lebih tinggi secara bermakna dibandingkan perempuan premenopause. Temuan ini tidak berarti semua perempuan akan mengalami gangguan mental, tetapi cukup untuk menegaskan bahwa keluarga perlu peka terhadap perubahan emosi, pola tidur, daya konsentrasi, dan kebutuhan dukungan

yang lebih besar selama masa transisi ini. (Badawy et al., 2024; WHO, 2024; NICE, 2024).

Dalam konteks asuhan kebidanan, bidan perlu mengenali proses adaptasi ini sejak fase perimenopause agar perempuan dan keluarganya memperoleh edukasi, pendampingan, dan dukungan yang tepat. Dengan demikian, bidan tidak hanya berperan membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi, tetapi juga memfasilitasi keluarga agar mampu menjadi sistem pendukung yang aktif dalam proses adaptasi menuju menopause yang sehat dan bermakna. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

C. Makna Dukungan Keluarga bagi Perempuan Menopause

Dalam keperawatan keluarga, keluarga dipahami sebagai sistem terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, proses pengambilan keputusan, serta kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi berbagai transisi kehidupan. Pada masa menopause, makna dukungan keluarga tidak hanya terletak pada kehadiran fisik anggota keluarga, tetapi pada kemampuannya menciptakan rasa aman, mengurangi ketidakpastian, dan menjaga perempuan tetap merasa dihargai di tengah perubahan tubuh, emosi, dan peran yang sedang dialaminya. Dukungan keluarga yang baik membantu perempuan memandang menopause sebagai fase kehidupan yang wajar dan dapat dilalui, bukan sebagai krisis yang harus ditanggung seorang diri. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

Bagi banyak perempuan, menopause dapat menjadi masa yang sensitif karena perubahan yang terjadi tidak selalu mudah dipahami, bahkan oleh perempuan itu sendiri. Ketika keluhan fisik dan emosional muncul bersamaan, perempuan sering membutuhkan ruang yang aman untuk didengar tanpa dihakimi. Dalam situasi inilah keluarga memiliki makna yang sangat penting sebagai tempat pertama untuk memperoleh penerimaan, ketenangan, dan penguatan. Keluarga yang suportif dapat membantu perempuan merasa bahwa dirinya tetap bernilai, tetap dibutuhkan, dan tetap memiliki tempat yang bermakna dalam sistem keluarga meskipun sedang mengalami perubahan biologis yang nyata. (WHO, 2024; Lowdermilk et al., 2020).

Secara konseptual, dukungan keluarga mencakup dukungan emosional, instrumental, informasional, dan appraisal atau penghargaan. Analisis konseptual Langford dkk. menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut berhubungan dengan keadaan kesehatan yang lebih positif, termasuk coping yang lebih efektif, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, serta penurunan kecemasan dan depresi. Artinya, dukungan keluarga tidak cukup dipahami sekadar sebagai "kehadiran", tetapi harus hadir dalam bentuk yang tepat sesuai kebutuhan perempuan.

Dukungan yang diberikan secara tepat akan membantu perempuan merasa dipahami, dibantu, diarahkan, dan dihargai dalam menghadapi masa menopause. (Langford et al., 1997; Friedman et al., 2018).

Dukungan emosional memiliki makna penting karena menopause sering kali disertai perubahan suasana hati, rasa sensitif, dan kebutuhan untuk dipahami. Perempuan yang memperoleh empati, perhatian, dan sikap tidak menghakimi dari keluarga akan lebih mudah menyesuaikan diri secara psikologis. Di sisi lain, dukungan informasional membantu perempuan dan keluarga memahami bahwa menopause adalah fase alamiah, mengenali gejala yang wajar, serta mengetahui kapan perlu mencari bantuan profesional. Sementara itu, dukungan instrumental memberi bantuan nyata dalam aktivitas sehari-hari, seperti membantu pekerjaan rumah, mengatur waktu istirahat, atau menemani ke fasilitas kesehatan. Adapun dukungan penghargaan menjaga harga diri perempuan agar ia tetap merasa dihormati, diakui, dan tidak dipandang sebagai beban bagi keluarga. (Langford et al., 1997; NICE, 2024; WHO, 2024).

Pada masa menopause, dukungan keluarga juga bermakna sebagai upaya menormalkan percakapan tentang gejala dan perubahan yang dialami perempuan. NICE secara eksplisit merekomendasikan agar informasi tentang menopause dibagikan bukan hanya kepada perempuan yang mengalami gejala, tetapi juga kepada keluarga atau caregiver yang relevan. Rekomendasi ini sangat penting karena keluarga yang memahami apa itu menopause akan lebih kecil kemungkinannya meremehkan keluhan, memelihara stigma, atau menafsirkan perubahan emosi sebagai "sifat buruk". Dengan komunikasi yang lebih terbuka, menopause tidak lagi menjadi topik yang dibungkam, tetapi menjadi bagian dari proses hidup yang dapat dibicarakan secara wajar dan ditangani bersama. (NICE, 2024; WHO, 2024).

Dalam perspektif *family systems theory*, perubahan pada satu anggota keluarga akan memengaruhi keseimbangan seluruh sistem keluarga. Karena itu, menopause yang dialami perempuan tidak hanya menjadi pengalaman individual, tetapi juga dapat memengaruhi pola komunikasi, relasi pasangan, pembagian peran rumah tangga, bahkan suasana emosional dalam keluarga. Bila keluarga mampu beradaptasi secara positif, maka perubahan tersebut justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat empati, komunikasi, dan kerja sama antaranggota keluarga. Sebaliknya, bila keluarga tidak memahami proses ini, menopause dapat menjadi sumber salah paham, konflik, atau jarak emosional. Pandangan ini menegaskan bahwa dukungan keluarga bukan sekadar bantuan tambahan, melainkan bagian dari mekanisme adaptasi yang menentukan apakah perempuan

dapat menjalani masa menopause secara sehat dan bermakna. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

Makna dukungan keluarga juga semakin penting jika dilihat dari dampaknya terhadap kualitas hidup perempuan. Perempuan yang merasa didukung cenderung lebih siap menghadapi gejala, lebih terbuka untuk mencari pertolongan, dan lebih mampu mempertahankan fungsi sosialnya dalam keluarga maupun masyarakat. Sebaliknya, perempuan yang merasa sendirian, tidak dipercaya, atau tidak dipahami berisiko mengalami stres yang lebih besar, penurunan rasa percaya diri, bahkan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, dukungan keluarga bukan hanya faktor pelengkap, tetapi merupakan determinan penting dalam membentuk pengalaman menopause yang lebih positif. (WHO, 2024; NICE, 2024; Badawy et al., 2024).

Bagi praktik kebidanan, pemahaman terhadap makna dukungan keluarga sangat penting agar bidan tidak hanya menilai gejala menopause yang dialami perempuan, tetapi juga memetakan kekuatan sistem pendukung yang tersedia di sekitarnya. Bidan perlu melihat apakah perempuan memiliki keluarga yang suportif, apakah komunikasi dalam keluarga berjalan baik, dan apakah ada hambatan yang membuat perempuan sulit memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, intervensi kebidanan dapat dirancang tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk keluarga sebagai mitra dalam mendukung adaptasi yang sehat selama masa menopause. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

D. Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga

Bentuk dukungan keluarga yang paling bermakna bagi perempuan menopause dapat diringkas ke dalam empat kelompok utama, yaitu dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penghargaan. Keempat bentuk dukungan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dukungan emosional membantu perempuan merasa didengar dan dipahami; dukungan informasional membantu keluarga dan perempuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar; dukungan instrumental memberi bantuan nyata dalam kehidupan sehari-hari; sedangkan dukungan penghargaan menjaga harga diri serta rasa kompeten perempuan dalam menjalani fase hidup ini. Dengan demikian, dukungan keluarga bukan hanya persoalan kehadiran, tetapi juga kualitas bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan perempuan menopause. (Langford et al., 1997; Friedman et al., 2018; NICE, 2024).

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional merupakan bentuk dukungan yang paling mendasar karena menopause sering kali disertai perubahan suasana hati, rasa sensitif,

kecemasan, dan kebutuhan untuk dipahami. Dalam kondisi seperti ini, perempuan membutuhkan keluarga yang mampu mendengarkan tanpa meremehkan, hadir tanpa menghakimi, dan memberi rasa aman ketika keluhan fisik maupun emosional muncul. Dukungan emosional dapat ditunjukkan melalui sikap sabar, kata-kata yang menenangkan, perhatian terhadap perubahan kondisi perempuan, serta kesediaan untuk menjadi tempat berbagi. Ketika perempuan merasa dipahami, beban psikologis yang menyertai menopause cenderung lebih ringan dan proses adaptasi dapat berlangsung lebih sehat. (Langford et al., 1997; WHO, 2024).

2. Dukungan Informasional

Dukungan informasional berarti membantu perempuan memahami menopause secara benar, mengenali gejala yang umum, serta mengetahui langkah yang tepat bila keluhan mulai mengganggu kualitas hidup. Keluarga yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mampu membedakan mana perubahan yang masih wajar dan mana kondisi yang memerlukan pertolongan tenaga kesehatan. Bentuk dukungan ini dapat berupa mencari informasi dari sumber terpercaya, berdiskusi dengan bidan atau dokter, menyiapkan pertanyaan sebelum konsultasi, serta membantu perempuan menafsirkan informasi kesehatan dengan lebih tepat. Dukungan informasional penting karena kesalahan pemahaman sering kali menjadi sumber kecemasan, stigma, dan keterlambatan dalam mencari bantuan. (NICE, 2024; WHO, 2024; Friedman et al., 2018).

3. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental adalah bantuan nyata yang diberikan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Pada perempuan menopause, dukungan ini dapat berupa membantu pekerjaan rumah, menyesuaikan suasana rumah agar lebih nyaman untuk beristirahat, menemani ke fasilitas kesehatan, membantu mengatur jadwal kontrol, hingga menyediakan dukungan biaya atau transportasi bila dibutuhkan. Dukungan instrumental menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya peduli secara emosional, tetapi juga terlibat secara konkret dalam meringankan beban perempuan. Dalam banyak situasi, bantuan nyata seperti ini sangat berarti karena gejala menopause, terutama gangguan tidur, rasa lelah, dan perubahan emosi, dapat membuat perempuan lebih mudah kehabisan energi dalam menjalankan peran sehari-hari. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

4. Dukungan penghargaan

Dukungan penghargaan atau *appraisal support* berkaitan dengan upaya menjaga harga diri, rasa mampu, dan keyakinan perempuan bahwa dirinya tetap bernilai meskipun sedang menjalani perubahan pada masa menopause. Bentuk

dukungan ini tampak ketika keluarga mengakui bahwa perubahan yang dialami perempuan adalah nyata, tidak memberi label negatif, tetap menghormati pendapatnya, dan mendukung keputusan yang diambil setelah memperoleh konseling atau edukasi. Dukungan penghargaan sangat penting karena sebagian perempuan menopause dapat merasa kehilangan kepercayaan diri, merasa kurang menarik, atau khawatir tidak lagi memiliki peran yang bermakna. Dengan adanya penghargaan dari keluarga, perempuan akan lebih mudah mempertahankan citra diri yang positif dan menghadapi perubahan dengan rasa percaya diri yang lebih baik. (Langford et al., 1997; Friedman et al., 2018).

Keempat bentuk dukungan tersebut pada dasarnya saling menguatkan. Dukungan emosional tanpa dukungan informasional dapat membuat perempuan merasa diterima tetapi tetap bingung menghadapi gejala. Dukungan instrumental tanpa penghargaan bisa saja membantu secara fisik, tetapi tetap meninggalkan rasa tidak berdaya. Sebaliknya, ketika keempatnya hadir secara seimbang, perempuan akan lebih mungkin merasa aman, dipahami, terbantu, dan tetap dihargai sebagai anggota keluarga yang bermakna. Oleh karena itu, efektivitas dukungan keluarga sangat ditentukan oleh keseimbangan dan ketepatan bentuk dukungan yang diberikan. (Langford et al., 1997; NICE, 2024).

Tabel 4.1
Ringkasan bentuk dukungan keluarga pada perempuan menopause

Bentuk dukungan	Makna praktis	Contoh tindakan	Setting utama	Risiko Jika Dukungan tidak ada
Emosional	Membuat perempuan merasa didengar, aman, dan tidak dihakimi	Suami mendengarkan keluhan tanpa mengecilkan; anak memberi ruang bicara; keluarga menenangkan saat hot flushes atau gelisah	Rumah	Perempuan merasa sendiri, cemas, mudah tersinggung
Informasional	Membantu memahami menopause secara benar	Mencari informasi dari WHO, NICE, bidan, atau dokter; menyiapkan daftar pertanyaan sebelum konsultasi; memahami bahwa menopause ditegakkan setelah 12 bulan tanpa haid	Rumah, puskesmas, klinik	Salah paham, terlambat mencari bantuan

Instrumental	Bantuan nyata sehari-hari	Berbagi pekerjaan rumah; menyiapkan lingkungan tidur yang nyaman; menemani kontrol; mendukung biaya atau transportasi layanan	Rumah, fasilitas kesehatan	Kelelahan, tidak patuh kontrol, beban meningkat
Penghargaan/Appraisal	Menguatkan harga diri dan kepercayaan diri	Mengakui bahwa perubahan yang dialami itu nyata; mendukung pilihan perempuan setelah konseling; tidak memberi label negatif	Rumah, keluarga besar	Harga diri menurun, merasa tidak berguna

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan Langford et al. (1997), Friedman et al. (2018), WHO (2024), NICE (2024), dan Kemenkes RI (2020).

Selain jenis dukungan, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dukungan itu sendiri. Bantuan yang terlalu mengatur, terlalu cepat menilai, atau memaksa keputusan medis tertentu justru dapat membuat perempuan merasa kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya. Oleh karena itu, dukungan keluarga idealnya bersifat kolaboratif: keluarga hadir, membantu, dan menguatkan, tetapi tetap menghormati preferensi, nilai, dan keputusan perempuan yang sedang menjalani masa menopause. Dukungan yang baik bukan berarti mengambil alih, melainkan mendampingi dengan empati dan penghormatan. (NICE, 2024; Friedman et al., 2018).

Bagi praktik kebidanan, pemahaman terhadap bentuk-bentuk dukungan keluarga ini penting agar bidan dapat menilai secara lebih komprehensif kebutuhan perempuan menopause. Bidan tidak hanya perlu menanyakan gejala yang dialami, tetapi juga perlu menggali apakah perempuan memiliki keluarga yang mampu mendengar, memberi informasi yang benar, membantu secara nyata, dan tetap menghargai dirinya. Dengan pendekatan ini, asuhan kebidanan dapat lebih berpusat pada perempuan sekaligus melibatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses adaptasi menopause. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

E. Peran Suami dan Anak dalam Adaptasi Menopause

Peran suami dalam adaptasi menopause sangat penting karena hubungan pasangan merupakan ruang terdekat tempat perubahan fisik, emosional, tidur, dan seksualitas paling nyata dirasakan. Pada masa menopause, perempuan tidak hanya

menghadapi perubahan biologis, tetapi juga perubahan kenyamanan dalam relasi sehari-hari dengan pasangan. Suami yang mampu memahami bahwa menopause adalah fase alamiah, bukan kelemahan atau gangguan kepribadian, akan lebih mudah memberikan respons yang suportif. Dalam konteks ini, dukungan suami menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu perempuan merasa tetap diterima, tetap dihargai, dan tetap memiliki makna dalam hubungan perkawinan. (WHO, 2024; NICE, 2024; Friedman et al., 2018).

Dukungan suami dapat diwujudkan pertama-tama melalui sikap emosional yang hangat dan tidak menghakimi. Ketika perempuan mengalami *hot flushes*, sulit tidur, perubahan suasana hati, atau rasa tidak nyaman terhadap tubuhnya, suami perlu hadir sebagai pendengar yang sabar dan penenang yang dapat dipercaya. Sikap sederhana seperti mendengarkan tanpa mengecilkan, tidak menertawakan keluhan, tidak menyalahkan perubahan emosi, dan menunjukkan empati terhadap kondisi istri merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti. Validasi emosional seperti ini membantu perempuan mengurangi rasa malu, rasa bersalah, dan kecemasan yang dapat muncul selama masa menopause. (WHO, 2024; NICE, 2024; Langford et al., 1997).

Selain dukungan emosional, suami juga memiliki peran penting dalam dukungan instrumental. Peran ini tampak dalam keterlibatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berbagi pekerjaan rumah, membantu menciptakan suasana istirahat yang lebih nyaman, menemani istri berkonsultasi ke fasilitas kesehatan, atau mendorong pola hidup sehat seperti aktivitas fisik ringan dan pengaturan pola makan. Dukungan instrumental ini penting karena gejala menopause, terutama gangguan tidur, rasa lelah, dan perubahan kenyamanan fisik, dapat membuat perempuan lebih mudah mengalami kelelahan. Kehadiran suami dalam bentuk bantuan konkret akan meringankan beban perempuan sekaligus memperkuat rasa bahwa ia tidak menjalani masa transisi ini sendirian. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024; Zakiah et al., 2023).

Peran suami juga sangat bermakna dalam menjaga kualitas relasi intim dan harga diri perempuan. Pada masa menopause, sebagian perempuan mengalami kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, penurunan libido, atau rasa kurang percaya diri terhadap tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, suami perlu membangun komunikasi yang terbuka, menghormati kenyamanan istri, dan tidak memaksakan relasi seksual tanpa pemahaman terhadap perubahan yang sedang dialami perempuan. Sikap yang penuh pengertian akan membantu perempuan merasa tetap dihargai sebagai pasangan, bukan dinilai dari perubahan biologis yang sedang terjadi. Dengan demikian, dukungan suami tidak hanya menjaga

keharmonisan rumah tangga, tetapi juga melindungi kesejahteraan psikologis perempuan. (WHO, 2024; NICE, 2024; Lowdermilk et al., 2020).

Di samping suami, anak juga memiliki peran penting dalam mendukung adaptasi perempuan menghadapi menopause, terutama pada keluarga dengan anak remaja akhir atau dewasa. Anak yang memahami kondisi ibunya cenderung lebih mampu menunjukkan sikap empatik, mengurangi beban domestik, serta menjaga komunikasi yang lebih sopan dan suportif. Dalam konteks ini, peran anak bukan sekadar membantu pekerjaan rumah, tetapi juga menciptakan suasana psikologis yang lebih nyaman di dalam keluarga. Ketika anak mampu menunjukkan perhatian, menghargai perubahan yang dialami ibu, dan tidak memperlakukan ibunya sebagai sosok yang “merepotkan”, maka perempuan akan lebih mudah mempertahankan rasa percaya diri dan rasa bermakna dalam keluarga. (WHO, 2024; Friedman et al., 2018; Cowell et al., 2024).

Peran anak juga menjadi semakin penting dalam keluarga multigenerasi, ketika perempuan menopause masih menjalankan banyak tanggung jawab sekaligus, baik sebagai ibu, istri, maupun pengasuh anggota keluarga lain. Dalam situasi seperti ini, anak yang terlibat aktif dapat membantu mengurangi beban peran yang menumpuk pada ibu. Bantuan sederhana seperti menggantikan sebagian tugas rumah, membantu mengakses informasi kesehatan yang valid, atau menemani ibu saat membutuhkan dukungan emosional akan memberikan dampak besar terhadap proses adaptasinya. Kehadiran anak yang peka dapat mengubah suasana rumah dari tempat yang penuh tekanan menjadi lingkungan yang mendukung proses transisi perempuan menuju fase hidup yang baru. (Cowell et al., 2024; WHO, 2024).

Namun demikian, peran suami dan anak tidak akan berjalan optimal bila mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang menopause. Kurangnya pemahaman sering kali membuat perubahan emosi perempuan dianggap sebagai sikap berlebihan, keluhan fisik dianggap biasa dan tidak penting, atau kebutuhan perempuan untuk beristirahat dan mencari bantuan justru tidak dihargai. Oleh karena itu, edukasi kepada suami dan anak menjadi bagian yang sangat penting dalam penguatan dukungan keluarga. Keluarga yang memahami menopause sebagai proses alamiah akan lebih siap menyesuaikan komunikasi, perilaku, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan perempuan. (NICE, 2024; WHO, 2024; Audina et al., 2025).

Dalam praktik kebidanan, keterlibatan suami dan anak perlu dipandang sebagai bagian dari intervensi yang terarah, bukan sekadar pelengkap. Bidan dapat berperan aktif dengan mengajak suami dan keluarga hadir dalam sesi edukasi, memberikan penjelasan tentang gejala menopause yang umum, serta menekankan

bentuk dukungan yang dapat dilakukan di rumah. Dengan cara ini, dukungan keluarga tidak berhenti pada niat baik, tetapi menjadi tindakan nyata yang membantu perempuan menjalani menopause dengan lebih nyaman, sehat, dan bermartabat. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

F. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga terhadap perempuan yang sedang menghadapi menopause tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kualitas dukungan sangat ditentukan oleh bagaimana keluarga memahami menopause, bagaimana mereka berkomunikasi, serta bagaimana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi membentuk respons mereka terhadap perubahan yang dialami perempuan. Oleh karena itu, pembahasan tentang dukungan keluarga tidak cukup berhenti pada bentuk-bentuk dukungan yang ideal, tetapi juga perlu melihat faktor-faktor yang menentukan apakah dukungan tersebut dapat hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

1. Pengetahuan dan literasi kesehatan keluarga

Faktor pertama yang sangat menentukan adalah tingkat pengetahuan dan literasi kesehatan keluarga. Keluarga yang memahami bahwa menopause merupakan fase transisi alamiah, mengenali gejala-gejala yang umum, dan mengetahui kapan perlu mencari pertolongan cenderung memberikan dukungan yang lebih tepat. Sebaliknya, keluarga yang miskin informasi lebih mudah meremehkan keluhan, terjebak pada mitos, atau menyerahkan seluruh persoalan pada asumsi bahwa perubahan yang dialami perempuan hanyalah "faktor usia". Dalam kondisi seperti ini, perempuan berisiko tidak memperoleh dukungan emosional maupun bantuan praktis yang memadai. NICE menegaskan bahwa informasi dasar tentang menopause, gejala umum, dan pilihan intervensi perlu dibagikan juga kepada keluarga atau caregiver yang relevan. (NICE, 2024; WHO, 2024).

Literasi kesehatan juga memengaruhi cara keluarga menafsirkan gejala menopause. Keluarga yang memiliki akses pada informasi yang benar akan lebih mampu membedakan mana gejala yang masih wajar dan mana kondisi yang memerlukan konsultasi lebih lanjut. Sebaliknya, rendahnya literasi kesehatan dapat menyebabkan keluarga menganggap keluhan perempuan sebagai hal yang dibesar-besarkan, sehingga dukungan yang seharusnya muncul justru berubah menjadi pengabaian atau salah paham. Dengan demikian, pengetahuan keluarga merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap yang suportif terhadap perempuan menopause. (WHO, 2024; Friedman et al., 2018).

2. Budaya, nilai, dan keyakinan keluarga

Faktor kedua adalah budaya, nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam keluarga. WHO menegaskan bahwa pengalaman menopause dipengaruhi oleh norma gender, nilai keluarga, dan konteks sosiokultural. Dalam sebagian lingkungan, menopause dipandang sebagai fase alamiah yang dapat dibicarakan secara terbuka. Namun, dalam lingkungan lain, menopause justru dianggap sebagai hal yang tabu, memalukan, atau tanda bahwa perempuan telah kehilangan daya tarik dan produktivitasnya. Nilai-nilai seperti ini akan sangat memengaruhi bagaimana keluarga memperlakukan perempuan yang sedang mengalami menopause. (WHO, 2024; Cowell et al., 2024).

Budaya keluarga yang terbuka cenderung mempermudah perempuan menyampaikan keluhan dan kebutuhan dukungannya. Sebaliknya, budaya yang kaku dan penuh stigma dapat membuat perempuan memilih diam, menanggung gejalanya sendiri, atau merasa tidak nyaman membicarakan perubahan tubuh maupun emosi yang dialaminya. Karena itu, dukungan keluarga juga sangat ditentukan oleh apakah keluarga memiliki nilai yang menghargai perempuan sebagai individu yang tetap bermakna dalam setiap fase hidupnya. (WHO, 2024; NICE, 2024; Friedman et al., 2018).

3. Kualitas relasi dan pola komunikasi dalam keluarga

Faktor berikutnya adalah kualitas relasi dan pola komunikasi antaranggota keluarga. Pada keluarga yang terbiasa berbicara terbuka, mendengarkan satu sama lain, dan menyelesaikan masalah dengan dialog, dukungan terhadap perempuan menopause cenderung lebih mudah diberikan. Perempuan dapat mengungkapkan keluhan tanpa takut disalahkan, dan keluarga dapat menyesuaikan respons dengan kebutuhan yang nyata. Sebaliknya, pada keluarga yang komunikasinya kaku, penuh konflik, atau minim empati, perempuan sering kali tidak memperoleh ruang untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. (Friedman et al., 2018; Langford et al., 1997).

Komunikasi yang buruk dapat memperburuk pengalaman menopause. Perubahan emosi perempuan bisa disalahartikan sebagai sikap negatif, sementara keluhan fisik dianggap sebagai alasan untuk mengeluh. Dalam situasi seperti ini, masalah sebenarnya bukan hanya gejala menopause itu sendiri, tetapi ketidakmampuan keluarga untuk memahami dan menanggapi perubahan tersebut secara sehat. Oleh karena itu, kualitas komunikasi keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan kuat atau lemahnya dukungan yang dapat diberikan. (WHO, 2024; Cowell et al., 2024).

4. Kondisi sosial ekonomi keluarga

Kondisi sosial ekonomi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi dukungan keluarga. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil umumnya memiliki peluang lebih besar untuk menyediakan makanan sehat, ruang istirahat yang nyaman, biaya konsultasi, transportasi ke fasilitas kesehatan, dan waktu yang lebih fleksibel untuk mendampingi perempuan. Sebaliknya, keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi sering kali lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga perhatian terhadap kebutuhan khusus perempuan pada masa menopause menjadi berkurang. (WHO, 2024; Rindner et al., 2023).

Tekanan ekonomi juga dapat memperbesar stres dalam keluarga. Dalam suasana rumah tangga yang dibayangi masalah keuangan, anggota keluarga mungkin menjadi kurang sabar, kurang peka, dan lebih mudah berkonflik. Akibatnya, perempuan menopause bukan hanya harus beradaptasi dengan perubahan biologis, tetapi juga menghadapi lingkungan emosional yang kurang mendukung. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi ketersediaan bantuan praktis, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan emosional dalam keluarga. (Rindner et al., 2023; WHO, 2022; Badawy et al., 2024).

5. Beban peran dan tanggung jawab perempuan

Faktor lainnya adalah beban peran yang masih dipikul perempuan pada usia pertengahan. Banyak perempuan menopause masih menjalankan berbagai tanggung jawab sekaligus, seperti mengurus rumah tangga, mendampingi anak, membantu orang tua yang menua, dan tetap menjalankan pekerjaan di luar rumah. Kondisi ini sering membuat perempuan berada dalam posisi yang sangat lelah secara fisik dan emosional. Bila keluarga tidak menyadari beratnya beban peran tersebut, maka dukungan yang diberikan akan cenderung kurang memadai. (Rindner et al., 2023; WHO, 2024).

Dalam kondisi perempuan yang memikul banyak tanggung jawab, dukungan keluarga menjadi semakin penting. Keluarga yang peka akan lebih cepat membantu membagi beban, memberi ruang istirahat, dan memahami bahwa perempuan menopause membutuhkan penyesuaian, bukan tuntutan yang semakin besar. Sebaliknya, bila keluarga tetap menganggap semua tanggung jawab harus dijalankan seperti biasa tanpa perubahan apa pun, maka proses adaptasi perempuan terhadap menopause akan menjadi lebih berat. (WHO, 2024; Friedman et al., 2018).

6. Pengalaman keluarga menghadapi masalah kesehatan

Pengalaman keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan sebelumnya juga memengaruhi kualitas dukungan. Keluarga yang terbiasa menghadapi

masalah kesehatan dengan terbuka, mencari pertolongan profesional, dan saling mendukung cenderung lebih siap menghadapi menopause sebagai bagian dari proses kehidupan. Sebaliknya, keluarga yang tidak terbiasa mendiskusikan masalah kesehatan atau cenderung mengabaikan keluhan akan lebih sulit memberi dukungan yang tepat. Pengalaman ini membentuk pola respons keluarga, apakah mereka terbiasa responsif dan kolaboratif, atau sebaliknya pasif dan menghindar. (Friedman et al., 2018; NICE, 2024).

7. Berat ringannya gejala yang dialami perempuan

Tingkat keparahan gejala menopause juga memengaruhi bentuk dan intensitas dukungan keluarga. Pada perempuan dengan gejala ringan, keluarga mungkin tidak selalu melihat kebutuhan akan dukungan yang besar. Namun, pada perempuan dengan keluhan yang lebih berat seperti gangguan tidur berkepanjangan, perubahan suasana hati yang nyata, kecemasan, atau gangguan relasi seksual, dukungan keluarga menjadi jauh lebih dibutuhkan. Semakin berat gejala yang dialami, semakin besar kebutuhan perempuan akan keluarga yang peka, sabar, dan mampu membantu secara nyata. (WHO, 2024; NICE, 2024; Badawy et al., 2024).

8. Akses terhadap layanan dan sumber informasi

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah akses terhadap layanan kesehatan dan sumber informasi yang valid. Keluarga yang tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan, memiliki akses digital yang baik, atau terbiasa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan cenderung lebih mudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang menopause. Sebaliknya, keterbatasan akses layanan dan informasi dapat menyebabkan keluarga hanya mengandalkan pengalaman orang lain, mitos, atau informasi yang belum tentu benar. Hal ini akan memengaruhi kualitas keputusan yang diambil keluarga dalam mendampingi perempuan menopause. (NICE, 2024; WHO, 2024).

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi dukungan keluarga menunjukkan bahwa kualitas dukungan bukan hanya masalah niat baik, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan, budaya, komunikasi, kondisi ekonomi, pengalaman hidup, beban peran, tingkat keparahan gejala, dan akses terhadap layanan. Karena itu, upaya memperkuat dukungan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan memberi informasi kepada perempuan, tetapi juga dengan memberdayakan keluarga agar lebih siap memahami, menerima, dan mendukung perempuan pada masa menopause. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024; Kemenkes RI, 2020).

Dalam praktik kebidanan, pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar bidan dapat menilai tidak hanya kondisi klinis perempuan, tetapi juga konteks keluarga yang memengaruhi proses adaptasinya. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam keluarga, bidan dapat merancang edukasi, konseling, dan intervensi yang lebih tepat sasaran sehingga perempuan menopause memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

G. Tantangan Lapangan

Tantangan lapangan yang paling nyata dalam mendukung perempuan menghadapi menopause adalah budaya diam dan normalisasi berlebihan. WHO menyebut bahwa menopause masih sering tidak dibicarakan secara terbuka, baik di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun layanan kesehatan. Akibatnya, banyak perempuan tidak memahami bahwa gejala yang mereka alami berkaitan dengan proses menopause, atau justru merasa malu untuk menyampaikan keluhan dan meminta pertolongan. Dalam praktik sehari-hari, kondisi ini tampak dalam ungkapan-ungkapan seperti “sabar saja”, “namanya juga sudah umur”, atau “jangan terlalu dipikirkan”, yang sekilas terdengar menenangkan tetapi sesungguhnya dapat membuat pengalaman perempuan menjadi tidak terlihat dan tidak ditangani secara tepat. (WHO, 2024).

Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya literasi keluarga mengenai menopause. Meskipun akses terhadap informasi saat ini semakin mudah, kualitas informasi yang diterima keluarga tidak selalu baik. Sebagian keluarga memperoleh informasi dari pengalaman orang sekitar, media sosial, atau sumber yang tidak tervalidasi, sehingga lebih mudah terbentuk salah paham, mitos, atau ketakutan yang tidak berdasar. Padahal, NICE menekankan bahwa edukasi menopause harus mencakup pengertian menopause, gejala yang umum, serta pilihan perubahan atau intervensi yang dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Tanpa pemahaman yang benar, keluarga dapat terlambat mencari bantuan, memilih saran yang kurang tepat, atau menafsirkan gejala secara keliru. (NICE, 2024; WHO, 2024).

Di banyak keluarga, tantangan juga muncul dalam bentuk salah tafsir terhadap perubahan emosi perempuan. Sensitivitas, kecemasan, mudah marah, atau kelelahan yang muncul pada masa menopause kadang dipandang sebagai masalah sikap, bukan sebagai bagian dari proses adaptasi. Akibatnya, perempuan justru berisiko dianggap terlalu berlebihan, terlalu sensitif, atau tidak mampu mengendalikan diri. Dalam situasi seperti ini, keluarga yang seharusnya menjadi sumber dukungan dapat berubah menjadi sumber tekanan tambahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan menopause

bukan hanya gejala biologis, tetapi juga cara lingkungan terdekat memaknai perubahan yang dialaminya. (WHO, 2024; Badawy et al., 2024; Cowell et al., 2024).

Tantangan lapangan lainnya adalah kuatnya stigma sosial terhadap usia dan tubuh perempuan. Pada sebagian masyarakat, menopause masih dikaitkan dengan berakhirnya daya tarik, berkurangnya peran perempuan, atau menurunnya produktivitas. Pandangan seperti ini dapat memengaruhi harga diri perempuan dan membuatnya merasa kurang bermakna di dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Jika stigma ini tidak disadari, keluarga dapat secara tidak langsung memperkuat perasaan tidak berharga yang sedang dialami perempuan. Oleh karena itu, tantangan menopause tidak hanya berada pada perubahan biologis, tetapi juga pada nilai sosial yang mengiringi perubahan tersebut. (WHO, 2024; Nugroho & Setiawan, 2019).

Dalam konteks keluarga, tantangan lain yang cukup sering muncul adalah terbatasnya komunikasi yang terbuka dan empatik. Tidak semua keluarga terbiasa membicarakan isu kesehatan reproduksi, perubahan tubuh, atau masalah relasi intim. Akibatnya, perempuan yang mengalami ketidaknyamanan sering memilih diam karena takut disalahpahami atau dianggap membicarakan hal yang memalukan. Keluarga yang komunikasinya kaku atau penuh konflik juga cenderung lebih sulit memberi dukungan yang tepat, karena kebutuhan perempuan menopause tidak pernah benar-benar dibicarakan secara jelas. Dalam situasi seperti ini, gejala yang sebenarnya dapat ditangani secara kolaboratif justru menjadi sumber salah paham dan jarak emosional dalam rumah tangga. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

Di lapangan, hambatan juga sering diperberat oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Pada keluarga dengan tekanan ekonomi yang tinggi, perhatian terhadap menopause kadang dianggap bukan prioritas dibandingkan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Perempuan tetap diharapkan menjalankan seluruh tanggung jawab rumah tangga atau pekerjaan seperti biasa, meskipun sedang mengalami gangguan tidur, kelelahan, atau perubahan emosi. Ketika beban hidup sudah berat, dukungan emosional dan instrumental yang seharusnya diberikan justru berkurang karena seluruh anggota keluarga berada dalam tekanan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas dukungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kapasitas keluarga dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. (Rindner et al., 2023; WHO, 2022).

Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena isu menopause belum selalu memperoleh ruang yang cukup kuat dalam layanan primer dibandingkan isu kehamilan, persalinan, dan nifas. Padahal, standar profesi bidan telah memasukkan dukungan psikososial, edukasi perubahan, dan konseling adaptasi pada masa

klimakterium. Kesenjangan antara standar dan implementasi ini menyebabkan edukasi keluarga tentang menopause belum selalu dilakukan secara sistematis. Akibatnya, perempuan sering menjalani fase menopause lebih banyak dengan pengalaman pribadi dan dukungan informal, tanpa pendampingan terarah dari tenaga kesehatan maupun keluarga yang teredukasi dengan baik. (Kemenkes RI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Tantangan lain yang mulai menonjol adalah perubahan pola hidup modern. Kesibukan kerja, berkurangnya waktu interaksi keluarga, meningkatnya penggunaan gawai, dan menurunnya kualitas komunikasi tatap muka dapat membuat keluarga kurang peka terhadap perubahan yang dialami perempuan. Dalam keluarga modern, setiap anggota sering sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga ruang untuk mendengarkan, berbagi, dan saling memperhatikan menjadi semakin sempit. Situasi ini dapat membuat dukungan keluarga hadir secara fisik, tetapi tidak selalu hadir secara emosional. Padahal, pada masa menopause, perempuan sangat membutuhkan kehadiran yang benar-benar memperhatikan, bukan sekadar berada di rumah yang sama. (Cowell et al., 2024; WHO, 2024).

Dengan demikian, tantangan lapangan dalam mendukung perempuan menghadapi menopause tidak hanya terletak pada kurangnya pengetahuan, tetapi juga pada budaya diam, stigma, salah tafsir gejala, lemahnya komunikasi keluarga, tekanan sosial ekonomi, keterbatasan layanan, dan perubahan pola hidup modern. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga tidak dapat dianggap hadir secara otomatis. Ia perlu dibangun, diperkuat, dan diarahkan agar benar-benar menjadi sumber perlindungan bagi perempuan selama masa transisi menopause. (WHO, 2024; NICE, 2024; Friedman et al., 2018).

Dalam praktik kebidanan, memahami tantangan lapangan ini sangat penting agar bidan dapat mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, intervensi kebidanan tidak hanya berisi edukasi tentang gejala menopause, tetapi juga mencakup penguatan komunikasi keluarga, pelurusan stigma, peningkatan literasi kesehatan, dan pemberdayaan keluarga agar lebih siap menjadi sistem pendukung yang sehat bagi perempuan. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

H. Strategi Penguatan Dukungan Keluarga

Penguatan dukungan keluarga bagi perempuan yang menghadapi menopause perlu dilakukan secara terencana, bertahap, dan melibatkan seluruh pihak yang berada di sekitar perempuan. Dukungan keluarga tidak selalu terbentuk secara otomatis, karena dipengaruhi oleh pengetahuan, pola komunikasi, budaya, pengalaman keluarga, serta ketersediaan informasi dan layanan kesehatan. Oleh

karena itu, strategi penguatan dukungan keluarga harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang menopause, tetapi juga untuk membantu keluarga mengubah pengetahuan tersebut menjadi sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

1. Edukasi antisipatif sebelum gejala menjadi berat

Strategi pertama adalah memberikan edukasi antisipatif sebelum gejala menopause menjadi berat atau menimbulkan gangguan yang bermakna. Edukasi ini idealnya dimulai pada perempuan usia pertengahan dengan melibatkan suami atau anggota keluarga yang relevan. NICE secara tegas merekomendasikan agar informasi tentang menopause dibagikan bukan hanya kepada perempuan yang mengalami gejala, tetapi juga kepada keluarga atau *caregiver*, termasuk pengertian menopause, gejalanya, serta perubahan dan intervensi yang dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Dengan pendekatan ini, keluarga tidak belajar ketika masalah sudah menumpuk, tetapi sudah memiliki bahasa dan pemahaman yang cukup untuk memberi dukungan sejak awal. (NICE, 2024; Burgin et al., 2024; WHO, 2024).

Edukasi antisipatif juga penting untuk menurunkan kecemasan dan salah tafsir. Ketika keluarga memahami bahwa *hot flushes*, perubahan suasana hati, gangguan tidur, atau ketidaknyamanan seksual merupakan bagian dari proses transisi yang bisa terjadi, maka respons yang muncul akan cenderung lebih empatik dan lebih rasional. Edukasi seperti ini membantu keluarga berpindah dari pola pikir yang reaktif menjadi pola pikir yang preventif dan suportif. (WHO, 2024; NICE, 2024).

2. Penguatan komunikasi keluarga yang terbuka dan empatik

Strategi kedua adalah membangun komunikasi keluarga yang terbuka, empatik, dan tidak menghakimi. Dalam praktiknya, banyak hambatan dukungan justru muncul bukan karena keluarga tidak peduli, tetapi karena tidak ada ruang yang aman untuk berbicara. Perempuan sering menahan keluhan karena takut dianggap berlebihan, sedangkan keluarga tidak memahami kebutuhan perempuan karena tidak pernah dibicarakan secara jelas. Karena itu, penguatan komunikasi keluarga menjadi salah satu strategi paling mendasar dalam mendukung adaptasi menopause. (Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

Keluarga dapat didorong untuk membuat "rencana dukungan" sederhana, misalnya gejala apa yang paling sering muncul, bantuan apa yang dibutuhkan perempuan, siapa yang dapat mendampingi bila perlu kontrol, kapan waktu istirahat perlu dijaga, dan bagaimana cara berbicara ketika perempuan sedang merasa sensitif atau lelah. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *family nursing* karena mengubah dukungan dari sekadar niat baik menjadi bentuk

komunikasi dan tindakan yang nyata, teratur, dan mudah diterapkan di rumah. (Friedman et al., 2018; Langford et al., 1997).

3. Menjadikan gaya hidup sehat sebagai agenda keluarga

Strategi ketiga adalah menjadikan gaya hidup sehat sebagai agenda keluarga, bukan hanya tanggung jawab perempuan seorang diri. NICE menganjurkan edukasi mengenai aktivitas fisik, kesehatan tulang, dan peninjauan kesehatan secara berkala, sementara WHO menegaskan bahwa gejala yang berdampak pada kesejahteraan perlu dibicarakan dengan tenaga kesehatan untuk menentukan pilihan penatalaksanaan yang sesuai. Dalam konteks keluarga, hal ini berarti mendorong pola hidup sehat bersama, seperti olahraga ringan secara rutin, pola makan yang lebih seimbang, pengaturan waktu tidur, pengurangan stres, dan suasana rumah yang lebih mendukung kenyamanan perempuan. (NICE, 2024; WHO, 2024).

Melibatkan keluarga dalam gaya hidup sehat memiliki makna penting karena perempuan menopause sering kali sulit menjaga perilaku sehat bila lingkungan rumah tidak mendukung. Keluarga yang ikut menjalankan kebiasaan sehat akan membuat perempuan merasa lebih mudah beradaptasi dan tidak merasa menanggung beban perubahan seorang diri. Dengan demikian, dukungan keluarga tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk budaya hidup sehat yang dibangun bersama. (WHO, 2024; Lowdermilk et al., 2020).

4. Pelibatan suami dan anak secara aktif

Strategi keempat adalah melibatkan suami dan anak secara aktif dalam proses edukasi dan pendampingan. Suami memiliki posisi penting dalam memberikan dukungan emosional, menjaga kualitas komunikasi pasangan, dan membantu perempuan menghadapi perubahan fisik maupun seksual. Anak, terutama yang sudah remaja akhir atau dewasa, juga dapat berperan dalam membantu pekerjaan rumah, mendukung ibu secara emosional, dan menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Oleh karena itu, penguatan dukungan keluarga tidak boleh hanya menyasar perempuan, tetapi perlu secara langsung melibatkan anggota keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-harinya. (WHO, 2024; Cowell et al., 2024; Zakiah et al., 2023).

Pelibatan suami dan anak juga penting untuk menurunkan stigma dan salah tafsir. Ketika mereka memahami bahwa perubahan yang dialami perempuan bukanlah "sikap buruk" atau "keluhan berlebihan", maka mereka akan lebih mudah berperilaku suportif. Dalam konteks ini, edukasi keluarga tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu mengubah cara pandang keluarga terhadap menopause itu sendiri. (NICE, 2024; WHO, 2024).

5. Pemanfaatan konseling individual dan konseling keluarga

Strategi kelima adalah memperkuat peran konseling, baik konseling individual maupun konseling keluarga. Konseling individual diperlukan untuk membantu perempuan memahami perubahan yang sedang dialaminya, mengelola kecemasan, dan meningkatkan kesiapan menghadapi menopause. Sementara itu, konseling keluarga berguna untuk membantu anggota keluarga memahami cara memberikan dukungan yang tepat, memperbaiki komunikasi, dan menyamakan persepsi tentang kebutuhan perempuan. Konseling ini sangat penting terutama pada keluarga yang memiliki hambatan komunikasi, stigma yang kuat, atau konflik yang memperberat proses adaptasi perempuan. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

Dalam praktik kebidanan, konseling keluarga memungkinkan bidan tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada konteks kehidupan perempuan. Melalui konseling, bidan dapat membantu keluarga mengenali bentuk dukungan yang paling dibutuhkan, memperjelas kapan pertolongan profesional diperlukan, dan membimbing keluarga agar berperan sebagai mitra aktif dalam proses adaptasi perempuan menuju menopause yang sehat. (Kemenkes RI, 2020; Friedman et al., 2018).

6. Penguatan kelompok sebaya dan dukungan komunitas

Strategi keenam adalah memanfaatkan dukungan kelompok sebaya dan komunitas. Uji acak terkontrol oleh Rindner dkk. menunjukkan bahwa *person-centered individual support* pada topik menopause dapat memperbaiki kualitas hidup serta menurunkan gejala mental, somatik, urogenital, dan stres sampai sedikitnya 12 bulan. Sementara itu, Yazdkhasti dkk. menunjukkan bahwa metode *support group* dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan postmenopause secara bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga akan menjadi lebih kuat bila dipadukan dengan dukungan sebaya dan dukungan komunitas yang ramah menopause. (Rindner et al., 2023; Yazdkhasti et al., 2012).

Kelompok sebaya dapat menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, belajar dari perempuan lain, dan mengurangi rasa sendiri. Komunitas, posyandu lansia, kelas kesehatan perempuan, atau forum edukasi masyarakat dapat berperan sebagai sarana memperluas dukungan yang tidak hanya bertumpu pada keluarga inti. Dengan demikian, keluarga tetap menjadi sistem pendukung utama, tetapi tidak bekerja sendirian tanpa bantuan lingkungan yang lebih luas. (WHO, 2024; Cowell et al., 2024).

7. Penguatan peran layanan primer dan bidan

Strategi ketujuh adalah memperkuat layanan primer, khususnya peran bidan, dalam edukasi dan pendampingan keluarga. Bidan berada pada posisi

yang sangat strategis karena memiliki kedekatan dengan perempuan dan keluarga di masyarakat. Dalam konteks menopause, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai konselor, pendamping, dan fasilitator yang membantu keluarga memahami proses adaptasi perempuan. Kehadiran bidan yang aktif akan membuat dukungan keluarga lebih terarah, lebih berbasis bukti, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

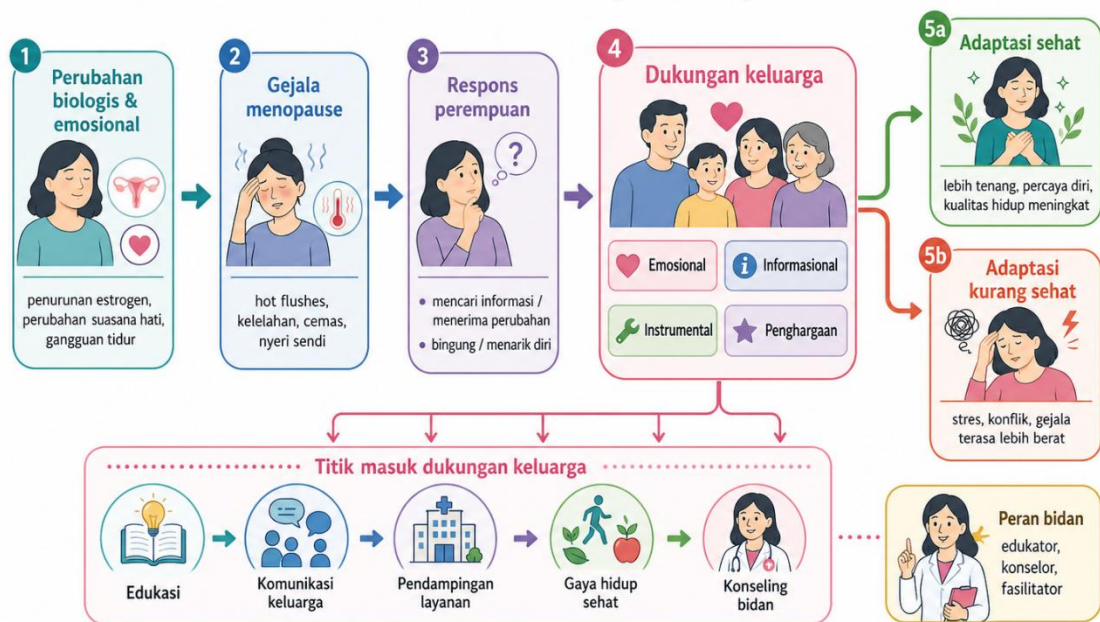
Bidan dapat mengintegrasikan edukasi menopause ke dalam pelayanan kesehatan perempuan usia pertengahan, konseling keluarga, kegiatan promosi kesehatan, maupun forum komunitas. Dengan strategi ini, menopause tidak lagi menjadi topik yang dibahas ketika masalah sudah berat, tetapi menjadi bagian dari edukasi kesehatan sepanjang daur hidup perempuan. (Kemenkes RI, 2020; NICE, 2024).

8. Membangun budaya keluarga yang menghormati perempuan

Strategi terakhir yang sangat penting adalah membangun budaya keluarga yang menghormati perempuan dalam setiap fase kehidupannya. Dukungan keluarga tidak akan optimal jika perempuan tetap dipandang berdasarkan stigma usia, kemampuan reproduksi, atau penilaian fisik semata. Karena itu, keluarga perlu diarahkan untuk memaknai menopause sebagai fase hidup yang wajar, bukan sebagai penurunan nilai perempuan. Sikap menghargai, menghormati keputusan perempuan, dan menjaga martabatnya merupakan fondasi yang memperkuat seluruh bentuk dukungan yang lain. (WHO, 2024; Friedman et al., 2018).

Dengan demikian, strategi penguatan dukungan keluarga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari edukasi, komunikasi, gaya hidup sehat, pelibatan suami dan anak, konseling, penguatan komunitas, hingga peningkatan peran layanan primer. Pendekatan yang komprehensif seperti ini akan membantu keluarga tidak hanya memahami menopause secara teoritis, tetapi juga mampu menjadi sistem pendukung yang nyata, sehat, dan berkelanjutan bagi perempuan yang sedang menjalani proses adaptasi. (WHO, 2024; NICE, 2024; Kemenkes RI, 2020).

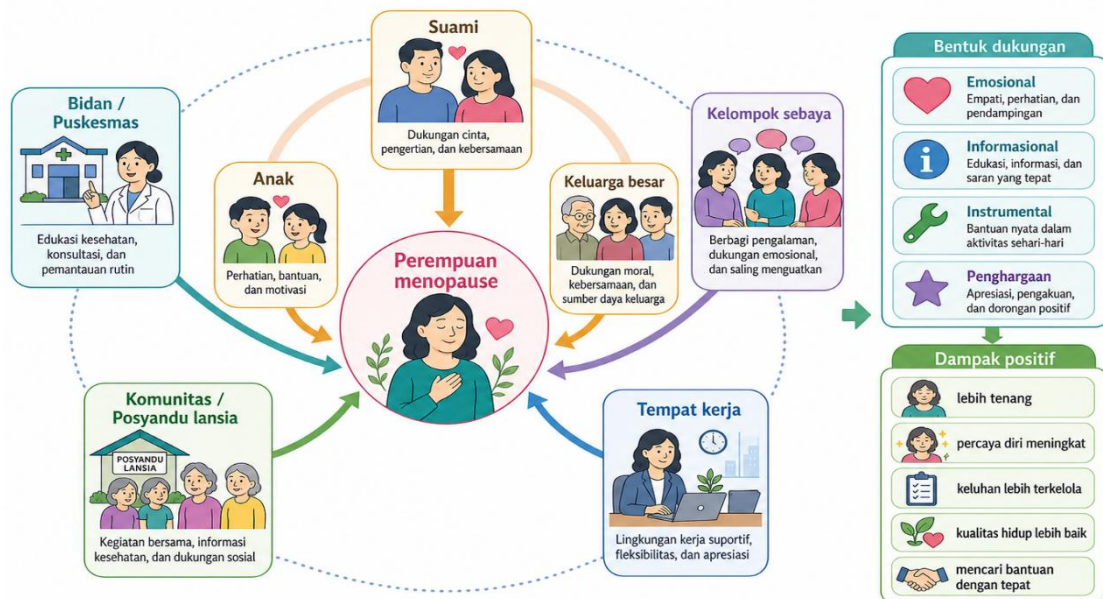
Dalam praktik kebidanan, strategi penguatan dukungan keluarga ini menempatkan bidan sebagai edukator, konselor, dan fasilitator adaptasi perempuan pada masa menopause. Dengan keterlibatan bidan yang aktif dan keluarga yang teredukasi, perempuan dapat menjalani masa menopause dengan lebih siap, lebih nyaman, dan lebih bermakna. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).



Gambar 4.1

Alur adaptasi perempuan menghadapi menopause dan titik masuk dukungan keluarga

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan WHO (2024), NICE (2024), Friedman et al. (2018), Langford et al. (1997), dan Kemenkes RI (2020).



Gambar 4.2 Ilustrasi ekosistem dukungan keluarga bagi perempuan menopause

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan WHO (2024), Cowell et al. (2024), NICE (2024), dan Kemenkes RI (2020).

Strategi penguatan dukungan keluarga ini menempatkan bidan sebagai edukator, konselor, dan fasilitator adaptasi perempuan pada masa menopause. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

I. Simpulan

Menopause merupakan fase alamiah dalam kehidupan perempuan yang tidak hanya ditandai oleh berhentinya menstruasi, tetapi juga oleh perubahan biologis, psikologis, sosial, dan relasional yang menuntut proses adaptasi. Karena itu, menopause tidak tepat dipahami semata-mata sebagai kumpulan keluhan atau tanda penuaan, melainkan sebagai transisi kehidupan yang memerlukan penerimaan diri, dukungan lingkungan, dan respons keluarga yang tepat. Cara keluarga memaknai menopause akan sangat memengaruhi apakah perempuan merasa dipahami dan didukung, atau justru merasa sendiri dalam menghadapi perubahan yang dialaminya. (WHO, 2024; WHO, 2021; NICE, 2024).

Dukungan keluarga memiliki makna yang sangat penting dalam membantu perempuan menjalani masa menopause secara sehat dan bermartabat. Dukungan tersebut mencakup dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penghargaan, yang masing-masing berperan dalam mengurangi kecemasan, memperkuat coping, menjaga harga diri, dan membantu perempuan tetap menjalankan peran sosialnya dengan baik. Suami dan anak, sebagai anggota keluarga terdekat, memiliki peran besar dalam menciptakan suasana yang aman, penuh empati, serta mendukung perempuan dalam menghadapi perubahan fisik maupun emosional yang terjadi selama masa menopause. (Langford et al., 1997; Friedman et al., 2018; WHO, 2024).

Namun, dukungan keluarga tidak selalu hadir secara optimal. Kualitas dukungan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga, budaya, pola komunikasi, kondisi sosial ekonomi, pengalaman hidup, beban peran perempuan, dan akses terhadap informasi maupun layanan kesehatan. Di lapangan, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan seperti budaya diam, salah tafsir gejala, stigma terhadap usia dan tubuh perempuan, lemahnya komunikasi keluarga, serta belum optimalnya konseling menopause dalam layanan primer. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga perlu dibangun secara sadar, diperkuat secara berkelanjutan, dan tidak dapat dibiarkan terbentuk secara spontan tanpa arahan. (WHO, 2024; Cowell et al., 2024; Kemenkes RI, 2020).

Oleh karena itu, penguatan dukungan keluarga perlu dilakukan melalui edukasi antisipatif, komunikasi keluarga yang lebih terbuka, pelibatan aktif suami dan anak, penerapan gaya hidup sehat berbasis keluarga, pemanfaatan konseling dan kelompok sebaya, serta optimalisasi peran layanan primer, khususnya bidan. Dalam konteks ini, bidan memiliki posisi strategis sebagai edukator, konselor, dan fasilitator yang membantu perempuan dan keluarga memahami menopause sebagai fase kehidupan yang alamiah dan dapat dijalani dengan lebih positif.

Dengan keterlibatan keluarga yang suportif dan pendampingan kebidanan yang tepat, perempuan dapat menjalani masa menopause dengan lebih siap, lebih nyaman, lebih sehat, dan tetap bermartabat. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024; NICE, 2024).

Dengan demikian, asuhan kebidanan pada perempuan menopause perlu menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam edukasi, dukungan emosional, pengambilan keputusan, dan penguatan perilaku sehat, sehingga perempuan dapat menjalani masa menopause dengan lebih siap, lebih nyaman, dan lebih bermartabat. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2024).

J. Referensi

- Audina, E., Wahyuni, S., & Wuriningsih, A. Y. (2025). *Hubungan dukungan keluarga terhadap kesiapan wanita dalam menghadapi menopause*. *Jurnal Ventilator*, 3(1), 172–180. doi:10.59680/ventilator.v3i1.1747.
- Badawy, Y., Spector, A., Li, Z., & Desai, R. (2024). *The risk of depression in the menopausal stages: A systematic review and meta-analysis*. *Journal of Affective Disorders*, 357, 126–133. doi:10.1016/j.jad.2024.04.041.
- Burgin, J., Pyne, Y., & Hickey, M. (2024). *Helping women prepare for menopause*. *BMJ*, 386, q1512. doi:10.1136/bmj.q1512.
- Cowell, A. C., Gilmour, A., & Atkinson, D. (2024). *Support mechanisms for women during menopause: Perspectives from social and professional structures*. *Women*, 4(1), 53–72. doi:10.3390/women4010005.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2018). *Family nursing: Research, theory, and practice* (6th ed.). Pearson.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Dampak kesehatan menopause*. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.
- Langford, C. P., Bowsher, J., Maloney, J. P., & Lillis, P. P. (1997). *Social support: A conceptual analysis*. *Journal of Advanced Nursing*, 25(1), 95–100. doi:10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2024). *Menopause: Identification and management (NG23)*. NICE.
- Nugroho, T., & Setiawan, A. (2019). *Kesehatan wanita, gender, dan permasalahannya*. Nuha Medika.

- Rindner, L., Nordeman, L., Strömme, G., Hange, D., Gunnarsson, R., & Rembeck, G. (2023). *Effect of group education and person-centered support in primary health care on mental health and quality of life in women aged 45–60 years with symptoms commonly associated with stress: A randomized controlled trial*. *BMC Women's Health*, 23, 128. doi:10.1186/s12905-023-02221-6.
- Sari, A. S., & Susilawati, D. (2021). *Hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup wanita menopause di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang*. *Avicenna: Journal of Health Research*, 4(2). doi:10.36419/avicenna.v4i2.526.
- World Health Organization. (2021). *WHO's work on the UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030)*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Guidelines on mental health at work*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Menopause*. WHO fact sheet.
- Yazdkhasti, M., Keshavarz, M., Khoei, E. M., Hosseini, A. F., Esmaeilzadeh, S., Pebdani, M. A., & Jafarzadeh, H. (2012). *The effect of support group method on quality of life in post-menopausal women*. *Iranian Journal of Public Health*, 41(11), 78–84.
- Zakiah, V., Andriyani, & Aridzka. (2023). *Pengaruh dukungan suami terhadap kesiapan ibu dalam menghadapi masa menopause di wilayah kerja Puskesmas Bungku Kabupaten Morowali*. *Jurnal Pelita Sains Kesehatan*, 107–113.

K. Glosarium

Adaptasi menopause	=	Proses penyesuaian biologis, psikologis, sosial, dan perilaku yang dilakukan perempuan saat memasuki perimenopause, menopause, dan postmenopause.
Appraisal support / dukungan penghargaan	=	Bentuk dukungan yang menjaga harga diri, rasa mampu, dan keyakinan perempuan bahwa ia dapat menjalani fase menopause dengan baik.
Dukungan emosional	=	Dukungan berupa empati, mendengarkan, menenangkan, dan hadir tanpa menghakimi.
Dukungan informasional	=	Dukungan berupa pemberian informasi, saran, klarifikasi, dan arahan untuk membantu pengambilan keputusan.
Dukungan instrumental	=	Bantuan nyata atau konkret, misalnya membagi pekerjaan rumah, menemani kontrol, atau membantu transportasi dan biaya.
Hot flushes	=	Sensasi panas mendadak, biasanya di wajah, leher, dan dada, yang dapat disertai keringat, jantung berdebar, dan rasa tidak nyaman.

Klimakterium	=	Masa transisi bertahap dari fase reproduktif menuju nonreproduktif, mencakup premenopause, perimenopause, menopause, dan postmenopause.
Kualitas hidup	=	Persepsi seseorang tentang kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
Menopause	=	Keadaan ketika menstruasi berhenti permanen dan baru dinyatakan setelah 12 bulan berturut-turut tanpa haid karena sebab alami atau non-patologis lain.
Perimenopause	=	Fase transisi yang dimulai sejak tanda-tanda awal perubahan siklus menstruasi sampai satu tahun setelah haid terakhir.
Postmenopause	=	Fase setelah menopause ditegakkan, ketika perempuan hidup bertahun-tahun setelah haid terakhir.
Terapi hormon menopause / HRT	=	Terapi berbasis estrogen, dengan atau tanpa progesteron, untuk membantu mengurangi gejala menopause pada perempuan yang sesuai indikasi.

PROFIL PENULIS



Bdn. Rosmawati, M.Keb., Lahir di Belitang, 18 Juli 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang D 4 Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2018. Profesi Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Gombong tahun 2022. Riwayat pekerjaan pada th 1984 – th 2022 di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Gombong mengampu mata kuliah KPPK, Etika Hukum Kesehatan, Gizi Reproduksi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wati1807rose@gmail.com. Organisasi: Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan 'Aisyiyah. Motto: "Teruslah berbuat baik, karena itulah yang akan kembali kepada kita"



Muninggar S.ST., M.Kes., Penulis lahir di Ngawi, 17 Juni 1973, penulis adalah dosen tetap di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia pada program studi Sarjana Kebidanan. Menyelesaikan pendidikan DIV kebidanan di Politeknik Karya Husada Jakarta pada tahun 2011 serta melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju pada tahun 2015, penulis merupakan seorang dosen tetap dan penulis aktif di Universitas Bhakti Pertiwi sampe sekarang, media social yang bisa dihubungi bisa melalui email muninggar1706@gmail.com , beberapa buku dan jurnal ilmiah sudah pernah saya buat. Motto "Libatkan Allah dalam setiap urusanmu"

PROFIL PENULIS



Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM., penulis lahir di Bandung pada 7 Agustus 1976 dan menetap di Malang, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tahun 2008, lulus S2 Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Reproduksi, Universitas Padjadjaran pada tahun 2015, lulus S3 Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran konsentrasi biologi reproduksi. Penulis adalah dosen Prodi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes dan mengampu mata kuliah Herbal dan Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Menopause. Penulis aktif melakukan riset di bidang herbal untuk kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Email: teh.nisa1@gmail.com

Instansi mengajar: Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes



Prassanti Widya Pravitasari, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Grobogan, 25 Desember 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Universitas Telogorejo Semarang, kemudian DIV Kebidanan di Universitas Karya Husada Semarang. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Sali Al-Aitaam Bandung mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Keterampilan Dasar Praktik Klinik, dan Praktik Klinik Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

prassantiwidya@gmail.com

PROFIL PENULIS



Nurbaety, S.SiT., M.K.M. lahir di Bima pada 02 September 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Prof. Dr. Hamka dan lulus pada tahun 2020. Karier penulis dimulai pada tahun 2010 di Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan pada periode 2017–2024. Selanjutnya, penulis dipercaya menjabat sebagai

Direktur Politeknik Muhammad Dahlan dan berperan dalam melanjutkan transformasi kelembagaan dari AKBID Harapan Bunda Bima menjadi politeknik multi-program hingga saat ini. Dalam bidang akademik, penulis aktif mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi dalam Praktik Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, serta Kewirausahaan dalam Kebidanan. Penulis juga aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi sebagai pengajar, narasumber, penulis buku dan artikel ilmiah, serta mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan pertemuan ilmiah tingkat nasional. Pada tahun 2020, penulis mendapat kepercayaan sebagai Pengawas Pusat Ujian Kompetensi Bidan. Sebagai pendidik dan akademisi, penulis telah ikut menulis dan menerbitkan beberapa buku di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat, serta terus mengembangkan inovasi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Politeknik Muhammad Dahlan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bettygindi@gmail.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Bunga rampai "Asuhan Kebidanan pada Perempuan Masa Perimenopause dan Menopause" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai fase transisi penting dalam kehidupan perempuan, yaitu masa perimenopause, klimakterium, dan menopause. Masa ini merupakan proses alamiah yang ditandai dengan penurunan fungsi reproduksi serta perubahan hormonal yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kualitas hidup perempuan.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar perimenopause dan menopause, meliputi pengertian, tahapan, karakteristik, serta pentingnya pemahaman bidan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pada masa tersebut. Selanjutnya, buku ini menguraikan perubahan hormonal, fisik, dan psikologis pada masa klimakterium, termasuk perubahan kadar estrogen, gangguan siklus menstruasi, perubahan metabolisme, suasana hati, hingga adaptasi emosional yang sering dialami perempuan.

Pembahasan juga mencakup berbagai keluhan yang sering dialami perempuan pada masa menopause, seperti hot flushes, gangguan tidur, mudah lelah, nyeri sendi, perubahan berat badan, penurunan kepadatan tulang, keluhan urogenital, serta perubahan dalam kehidupan seksual. Melalui pemahaman terhadap keluhan tersebut, tenaga kesehatan, khususnya bidan, diharapkan mampu melakukan deteksi dini, konseling, edukasi, dan rujukan apabila diperlukan.

Selain membahas aspek klinis, bunga rampai ini menekankan pentingnya edukasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan aktivitas fisik sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan perempuan pada masa menopause. Pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, istirahat cukup, pengelolaan stres, serta pemeriksaan kesehatan berkala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Buku ini juga menyoroti dukungan keluarga dalam adaptasi perempuan menghadapi menopause. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pemahaman, dukungan emosional, serta lingkungan yang positif agar perempuan dapat melewati masa transisi ini dengan lebih percaya diri dan nyaman.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa kebidanan, bidan, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat dalam memahami dan memberikan pendampingan yang tepat bagi perempuan pada masa perimenopause dan menopause. Melalui asuhan kebidanan yang holistik, edukatif, dan berpusat pada perempuan, masa menopause dapat dipahami bukan sebagai akhir produktivitas, melainkan sebagai fase kehidupan baru yang tetap sehat, bermakna, dan berkualitas.

Bunga rampai "Asuhan Kebidanan pada Perempuan Masa Perimenopause dan Menopause" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai fase transisi penting dalam kehidupan perempuan, yaitu masa perimenopause, klimakterium, dan menopause. Masa ini merupakan proses alamiah yang ditandai dengan penurunan fungsi reproduksi serta perubahan hormonal yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kualitas hidup perempuan.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar perimenopause dan menopause, meliputi pengertian, tahapan, karakteristik, serta pentingnya pemahaman bidan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pada masa tersebut. Selanjutnya, buku ini menguraikan perubahan hormonal, fisik, dan psikologis pada masa klimakterium, termasuk perubahan kadar estrogen, gangguan siklus menstruasi, perubahan metabolisme, suasana hati, hingga adaptasi emosional yang sering dialami perempuan.

Pembahasan juga mencakup berbagai keluhan yang sering dialami perempuan pada masa menopause, seperti hot flushes, gangguan tidur, mudah lelah, nyeri sendi, perubahan berat badan, penurunan kepadatan tulang, keluhan urogenital, serta perubahan dalam kehidupan seksual. Melalui pemahaman terhadap keluhan tersebut, tenaga kesehatan, khususnya bidan, diharapkan mampu melakukan deteksi dini, konseling, edukasi, dan rujukan apabila diperlukan.

Selain membahas aspek klinis, bunga rampai ini menekankan pentingnya edukasi gaya hidup sehat, nutrisi, dan aktivitas fisik sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan perempuan pada masa menopause. Pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, istirahat cukup, pengelolaan stres, serta pemeriksaan kesehatan berkala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Buku ini juga menyoroti dukungan keluarga dalam adaptasi perempuan menghadapi menopause. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pemahaman, dukungan emosional, serta lingkungan yang positif agar perempuan dapat melewati masa transisi ini dengan lebih percaya diri dan nyaman.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa kebidanan, bidan, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat dalam memahami dan memberikan pendampingan yang tepat bagi perempuan pada masa perimenopause dan menopause. Melalui asuhan kebidanan yang holistik, edukatif, dan berpusat pada perempuan, masa menopause dapat dipahami bukan sebagai akhir produktivitas, melainkan sebagai fase kehidupan baru yang tetap sehat, bermakna, dan berkualitas.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-39-8 (PDF)



9

786347

756398